



Buku Referensi

ASUHAN PASCAPERSALINAN DAN DUKUNGAN MENYUSUI BERBASIS BUKTI

Alyxia Gita Stellata • Etik Khusniyati
Dina Zakiyyatul Fuadah • Zulfa Nur Azizah
Shinta Ayu Nani • Nurmah • Nopi Nur Khasanah

BUKU REFERENSI: ASUHAN PASCAPERSALINAN DAN DUKUNGAN MENYUSUI BERBASIS BUKTI

Penulis

Alyxia Gita Stellata, S.Tr.Keb., M.Keb

Etik Khusniyati, SST., M.Keb

Dina Zakiyyatul Fuadah, S.Kep.Ns.,M.Kep

Zulfa Nur Azizah, M.Tr.Keb

Shinta Ayu Nani, S.S.T., M.Kes.

Nurmah, SST.,M.Kes

Dr. Ns. Nopi Nur Khasanah, M.Kep., Sp.Kep.An

Buku Referensi: Asuhan Pascapersalinan dan Dukungan Menyusui Berbasis Bukti

Penulis:

Alyxia Gita Stellata, S.Tr.Keb., M.Keb.
Etik Khusniyati, SST., M.Keb.
Dina Zakiyyatul Fuadah, S.Kep.Ns., M.Kep.
Zulfa Nur Azizah, M.Tr.Keb.
Shinta Ayu Nani, S.S.T., M.Kes.
Nurmah, SST., M.Kes.
Dr. Ns. Nopi Nur Khasanah, M.Kep., Sp.Kep.An.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Helmi Syauckani

ISBN: 978-634-7426-74-1

Cetakan Pertama: November, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat



PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya buku referensi “Asuhan Pascapersalinan dan Dukungan Menyusui Berbasis Bukti” ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku ini hadir sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan akan sumber rujukan yang komprehensif, mutakhir, dan praktis mengenai asuhan pada masa pascapersalinan serta dukungan menyusui yang berlandaskan bukti ilmiah.

Periode pascapersalinan merupakan masa transisi yang sangat menentukan bagi kesehatan fisik, psikologis, dan sosial ibu serta bayi. Tidak hanya terbatas pada proses pemulihan organ reproduksi, masa ini juga meliputi penyesuaian laktasi, pembentukan ikatan ibu–bayi, serta penentuan keberhasilan menyusui. Oleh karena itu, buku ini diawali dengan pembahasan mengenai Fisiologi Pemulihan Ibu dan Laktasi sebagai landasan ilmiah bagi tenaga kesehatan dalam memahami perubahan normal maupun deteksi dini kondisi yang menyimpang.

Angka kesakitan dan kematian ibu pada masa nifas masih banyak dipengaruhi oleh perdarahan, infeksi, dan anemia. Untuk itu, kami memandang penting untuk menguraikan secara khusus Konsep Perdarahan Pasca Persalinan: Pencegahan dan Tata Laksana, dilanjutkan dengan bahasan Infeksi, Anemia, dan Nyeri Pascapersalinan. Kedua topik ini disusun dengan mengacu pada pedoman nasional dan internasional serta hasil penelitian terkini, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dalam penerapan tindakan pencegahan, penatalaksanaan komprehensif, dan pemantauan berkelanjutan guna menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu.

Di sisi lain, menyusui merupakan hak sekaligus kebutuhan dasar bayi serta memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan ibu. Buku ini memuat topik Inisiasi Menyusu Dini dan Menyusui Eksklusif yang menekankan pentingnya praktik inisiasi menyusui dini dan keberlanjutan menyusui eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan. Selanjutnya, pada bagian Masalah Laktasi dan Solusi Berbasis Bukti, pembaca akan menemukan berbagai penjelasan mengenai masalah-masalah umum laktasi beserta pendekatan pemecahannya yang berlandaskan bukti ilmiah, sehingga dapat diaplikasikan secara tepat dalam praktik klinik maupun komunitas.

Masa pascapersalinan juga merupakan momen strategis untuk perencanaan kehamilan berikutnya secara sadar dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, buku ini menyertakan pembahasan mengenai Kontrasepsi Pasca Persalinan yang meliputi prinsip pemilihan metode, keamanan penggunaan, waktu pemberian yang tepat, serta aspek konseling yang berpusat pada kebutuhan dan hak reproduksi perempuan.

Harapannya, tenaga kesehatan dapat memberikan layanan kontrasepsi pascapersalinan yang holistik, bermutu, dan menghargai otonomi klien.

Sebagai upaya peningkatan mutu layanan, bab Indikator Luaran Ibu Bayi dan Audit Mutu disusun untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana mengukur keberhasilan asuhan pascapersalinan dan dukungan menyusui, serta bagaimana melaksanakan audit mutu secara sistematis. Dengan demikian, buku ini tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi juga mendorong penerapan budaya mutu dan keselamatan pasien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Buku referensi ini ditujukan bagi mahasiswa kebidanan, keperawatan, dan kedokteran, bidan praktik mandiri, perawat, dokter umum, dokter spesialis, pengelola program kesehatan ibu dan anak, serta seluruh tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan pada ibu dan bayi pascapersalinan. Kami berharap buku ini dapat menjadi rujukan dalam proses pembelajaran, praktik klinik, penyusunan kebijakan internal, maupun pengembangan pedoman asuhan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca dan pengguna buku ini sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan pada edisi-edisi berikutnya.

Akhir kata, semoga buku "Asuhan Pascapersalinan dan Dukungan Menyusui Berbasis Bukti" ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam mendukung tercapainya derajat kesehatan ibu dan bayi yang lebih baik, meningkatkan keberhasilan menyusui, serta memperkuat praktik pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berbasis bukti.

November, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 FISIOLOGI PEMULIHAN IBU DAN LAKTASI	1
A.Pendahuluan	1
B.Konsep Dasar Asuhan Pascapersalinan	2
C.Perubahan Fisiologi Pada Ibu Pascapersalinan	3
D.Fisiologi Laktasi.....	14
E.Upaya Meningkatkan Keberhasilan Laktasi	19
F.Faktor yang Mempengaruhi Pemulihan Ibu Pascapersalinan	21
G.Penutup	22
H.Referensi.....	22
I.Glosarium.....	24

BAB 2 KONSEP PERDARAHAN PASCA PERSALINAN: PENCEGAHAN DAN TATA LAKSANA	27
A.Pendahuluan	27
B.Definisi Perdarahan Pasca Persalinan.....	27
C.Faktor Predisposisi	27
D.Penyebab (Mnemonic 4T)	29
E.Faktor Risiko	29
F.Pencegahan Perdarahan Pasca Persalinan	29
G.Tatalaksana Perdarahan Pasca Persalinan.....	31
H.Komplikasi Perdarahan Pasca Persalinan	34
I.Konsultasi.....	35
J.Daftar Pustaka.....	35

BAB 3 INFEKSI, ANEMIA, DAN NYERI PASCAPERSALINAN	37
A.Pendahuluan	37
B.Infeksi.....	38
C.Anemia	40
D.Anemia Pascapersalinan.....	41
E.Nyeri Pascapersalinan	43
F.Nyeri Pascapersalinan Akibat Infeksi	44
G.Asuhan Kebidanan pada Nyeri Pascasalin	45
H.Penutup	47

I.Referensi.....	47
------------------	----

BAB 4 INISIASI MENYUSU DINI DAN MENYUSUI EKSKLUSIF 49

A.Pendahuluan	49
B.Pengertian Inisiasi Menyusu Dini.....	50
C.Kebijakan Pemerintah Berkaitan dengan Inisiasi Menyusu Dini	50
D.Peran Bidan dalam Mempersiapkan IMD.....	51
E.Syarat Melakukan Inisiasi Menyusu Dini	52
F.Kontra Indikasi Melakukan Inisiasi Menyusu Dini	52
G.Manfaat Inisiasi Menyusu Dini	52
H.Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Inisiasi Menyusu Dini.....	53
I.Tata Laksana Inisiasi Menyusu Dini Secara Umum	54
J.Langkah-Langkah Inisiasi Menyusu Dini	54
K.Inisiasi Menyusu Dini pada Operasi Caesar	55
L.Inisiasi Menyusu Dini pada Bayi Kembar.....	56
M.Inisiasi Menyusu Dini yang Kurang Tepat.....	57
N.Hambatan Inisiasi Menyusu Dini.....	57
O.Komplikasi yang Dapat Terjadi Saat Melakukan Inisiasi Menyusu Dini	59
P.Pengertian ASI Eksklusif	59
Q.Manfaat ASI Eksklusif	59
R.Peraturan Tentang ASI Eksklusif.....	60
S.Pentingnya ASI Eksklusif bagi Pertumbuhan dan Perkembangan Anak	60
T.Peran Tenaga Kesehatan dalam Meningkatkan Pemberian ASI Eksklusif.....	61
U.Penyebab Kegagalan ASI Eksklusif	62
V.Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif.....	63
W.Penutup	64
X.DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB 5 MASALAH LAKTASI DAN SOLUSI BERBASIS BUKTI 67

A.Pendahuluan	67
B.Konsep Dasar Laktasi	68
C.Masalah Umum Laktasi	69
D.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Laktasi	72
E.Dukungan Laktasi Berbasis Bukti (Intervensi Klinis dan Komunitas)	74
F.Tantangan Kontemporer dan Strategi Inovatif dalam Dukungan Laktasi.....	77
G.Penutup	79
H.Referensi.....	81
I.Glosarium.....	83

BAB 6 KONTRASEPSI PASCA PERSALINAN 89

A.Pendahuluan	89
B.Pengertian Kontrasepsi Pasca Persalinan	89
C.Tujuan KB Pasca Persalinan	90
D.Waktu penggunaan metode kontrasepsi pasca persalinan.	90
E.Pentingnya KB Pasca Persalinan	91
F.Manfaat KB Pasca Persalinan	92
G.Konseling KB Pasca Persalinan	92
H.Jenis-jenis Metode Kontrasepsi Pasca Persalinan	98
I.Penutup	109
J.Referensi	109

BAB 7 INDIKATOR LUARAN IBU BAYI DAN AUDIT MUTU 111

A.Pendahuluan	111
B.Indikator Luaran Ibu	112
C.Indikator Luaran Bayi	118
D.Audit Mutu Pelayanan Pascapersalinan dan Menyusui	127
E.Tantangan dalam Monitoring Indikator dan Audit Mutu	139
F.Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Pascapersalinan	142
G.Penutup	144
H.Referensi.....	146
I.Glosarium.....	148

PROFIL PENULIS 151

BAB 1

FISIOLOGI PEMULIHAN IBU DAN LAKTASI

A. Pendahuluan

Masa nifas (*puerperium*) merupakan periode penting yang dimulai segera setelah lahirnya plasenta hingga sekitar enam minggu pascapersalinan. Pada masa ini tubuh ibu mengalami proses adaptasi fisiologis yang kompleks untuk kembali ke kondisi sebelum hamil, termasuk pemulihan organ reproduksi, perubahan hormonal, dan dimulainya proses laktasi. Pengetahuan mengenai perubahan ini penting untuk mendukung proses pemulihan, mendeteksi dini komplikasi atau menjadi dasar dalam mengenali perbedaan antara proses normal dan kondisi patologis yang dapat membahayakan kesehatan ibu, serta memberikan asuhan berbasis bukti (Cunningham, Leveno, Bloom, Spong, et al., 2022).

Selain pemulihan fisik, masa nifas juga merupakan waktu dimulainya proses laktasi. Produksi dan pengeluaran air susu ibu (ASI) merupakan hasil kerja sama antara sistem endokrin dan neurofisiologis, dengan melibatkan hormon prolaktin dan oksitosin (Wambach & Spencer, 2021). ASI merupakan makanan utama yang mengandung zat gizi lengkap sekaligus faktor imunologis yang melindungi bayi dari infeksi (Wambach & Spencer, 2021). ASI tidak hanya menjadi sumber nutrisi optimal bagi bayi, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jangka panjang bagi ibu. Menyusui membantu mempercepat involusi uterus, menurunkan risiko perdarahan, serta memberikan proteksi jangka panjang terhadap kanker payudara dan ovarium (Victora et al., 2016).

Pemulihan yang optimal berdampak pada kesehatan jangka panjang ibu, termasuk pencegahan anemia, gangguan psikologis, serta komplikasi kronis. Namun, kendala seperti keterlambatan inisiasi menyusui dini, kurangnya pemahaman ibu tentang mekanisme produksi ASI, serta masalah payudara sering menjadi hambatan yang dapat menurunkan keberhasilan menyusui (WHO, 2020).

Pemahaman yang komprehensif mengenai fisiologi pemulihan ibu dan laktasi merupakan landasan utama bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam memberikan asuhan yang aman, efektif, dan berbasis bukti. Hal ini penting dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi secara menyeluruh (Kemenkes RI, 2021).

B. Konsep Dasar Asuhan Pascapersalinan

1. Pengertian Masa Nifas

Kata *puerperium* memiliki akar kata dari Latin: *puer* yang bermakna "bayi" serta *parus* yang berarti "melahirkan". Masa nifas mengacu pada tahapan pemulihan pasca persalinan yang dialami seorang ibu, berawal dari momen kelahiran sampai alat-alat reproduksinya pulih seperti sedia kala sebelum mengandung (Cunningham, et al., 2022)

Konsep nifas dipahami secara beragam oleh sejumlah ahli. Prawirohardjo (2012), menjelaskan bahwa periode puerperium atau masa nifas diawali sesaat setelah plasenta dilahirkan dan berakhir saat seluruh organ reproduksi telah kembali pada keadaan semula sebelum kehamilan terjadi. Rentang waktu ini bermula dua jam pasca keluarnya plasenta dan berlanjut selama enam minggu (42 hari).

Menurut World Health Organization (WHO, 2022), masa pascapersalinan (*postnatal period*) adalah periode dimulai segera setelah kelahiran plasenta hingga 6 minggu pertama, yang mencakup pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan penyesuaian terhadap peran baru sebagai ibu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masa nifas atau pascapersalinan adalah periode adaptasi dan pemulihan menyeluruh yang dialami ibu setelah melahirkan, dimulai segera setelah lahirnya plasenta hingga kira-kira enam minggu (42 hari) pascapersalinan.

2. Tujuan Asuhan Pascapersalinan

Pelayanan kesehatan pascapersalinan merupakan rangkaian perawatan yang disediakan untuk ibu beserta bayinya dalam rentang waktu mulai dari 6 jam hingga 42 hari pascakelahiran, dengan penerapan yang menyeluruh dan terpadu. Ibu pada masa nifas serta bayi yang baru dilahirkan dalam kondisi sehat dapat diperbolehkan pulang setelah melewati 24 jam sejak proses melahirkan (Kemenkes RI, 2022). Tujuan asuhan pelayanan kesehatan pascapersalinan bagi ibu dan bayi adalah sebagai berikut:

Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik secara fisik maupun psikologis.

Deteksi dini masalah, penyakit dan penyulit pascapersalinan.

Memberikan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE), dan konseling untuk memastikan perawatan diri, nutrisi, keluarga berencana, menyusui, pemberian imunisasi dan asuhan bayi baru lahir pada ibu beserta keluarganya.

Menjaga kesehatan ibu dan bayi baru lahir dengan melibatkan peran aktif dari ibu, suami, dan keluarga.

Memberikan pelayanan KB sesegera mungkin setelah persalinan.

Pelayanan kesehatan selama masa nifas umumnya dilakukan setidaknya selama empat kali kunjungan. Kunjungan pertama dilakukan dalam jangka waktu antara 6 jam sampai 2 hari setelah melahirkan. Kunjungan kedua berlangsung dalam rentang 3 hingga 7 hari setelah melahirkan. Kunjungan ketiga dilaksanakan dalam periode 8 hingga 28 hari setelah kelahiran. Kunjungan keempat diadakan antara 29 hingga 42 hari setelah melahirkan, terutama bagi ibu. Pada setiap kunjungan tersebut, tenaga medis akan menyediakan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan ibu dan bayi serta menyampaikan informasi dan pendidikan kepada ibu dan keluarganya terkait perawatan yang benar selama masa nifas (Kemenkes RI, 2022).

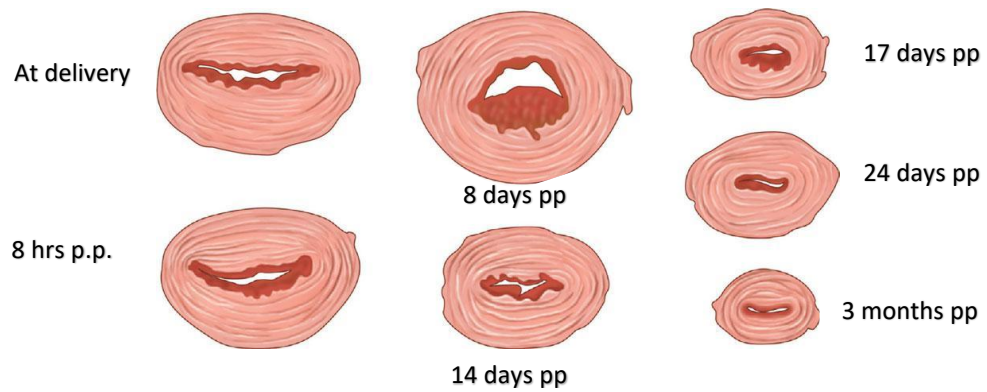
C. Perubahan Fisiologi Pada Ibu Pascapersalinan

1. Perubahan Sistem Reproduksi

Perubahan pada sistem reproduksi secara keseluruhan disebut proses involusi. Adapun organ-organ dalam sistem reproduksi yang mengalami perubahan selama masa nifas meliputi:

a. Uterus

Uterus merupakan organ reproduksi yang mengalami perubahan paling besar selama masa nifas. Segera setelah proses persalinan selesai, uterus akan mengalami involusi, yaitu suatu proses fisiologis di mana jaringan otot rahim berkontraksi dan mengalami penurunan ukuran secara bertahap hingga mencapai kondisi seperti sebelum kehamilan. Fundus uteri yang telah berkontraksi terletak sedikit di bawah umbilikus. Uterus pada tahap ini sebagian besar terdiri atas miometrium yang dilapisi oleh serosa di bagian luar dan desidua basalis di bagian dalam. Dinding anterior dan posterior uterus saling berdekatan dengan ketebalan masing-masing sekitar 4–5 cm. Berat uterus mencapai sekitar 1000 gram, lalu menurun menjadi 500 gram pada minggu pertama, 300 gram pada minggu kedua, dan sekitar 50-100 gram setelah enam minggu (Cunningham, et al., 2022; Kemenkes RI, 2022).

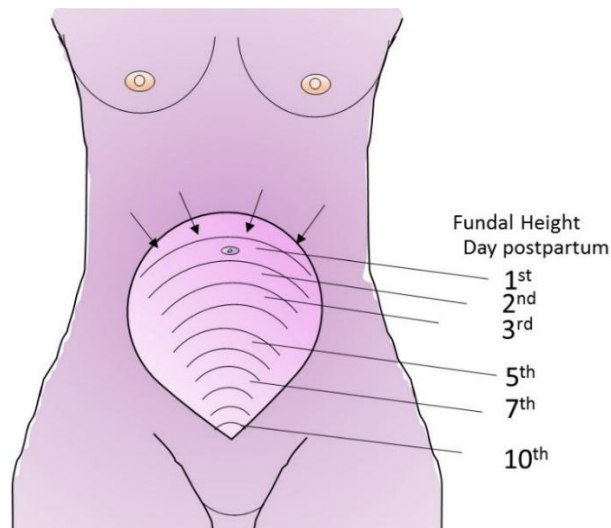


Gambar 1. 1

Potongan melintang uterus pada tempat implantasi plasenta yang mengalami involusi pada waktu yang bervariasi setelah melahirkan (Cunningham, et al., 2022)

Kontraksi uterus pada awalnya disebabkan oleh penurunan ukuran sel miometrium yang signifikan, yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah sehingga dapat membatasi perdarahan. Involusi uterus selanjutnya terjadi akibat autolisis (penghancuran diri sel) dan infark pada pembuluh darah uterus. Menurunnya level hormon estrogen dan progesteron pascapersalinan memicu peningkatan kerja enzim kolagenase beserta enzim proteolitik lainnya, yang pada gilirannya mempercepat berlangsungnya autolisis. Tak hanya itu, intima serta jaringan elastik pada pembuluh darah uterus mengalami proses fibrosis dan degenerasi hialin, kondisi ini berakibat pada terjadinya infark dan luruhnya sel-sel uterus yang selanjutnya dibersihkan oleh makrofag. Lapisan superfisial dan basal endometrium mengalami nekrosis kemudian terkelupas, dan pemulihan penuh jaringan endometrium umumnya tercapai dalam rentang waktu 2–3 minggu (Chauhan & Tadi, 2022).

Perubahan pada uterus dapat dideteksi melalui pemeriksaan palpasi dengan meraba pada bagian tengah garis tubuh (midline), yaitu di antara umbilikus (pusar) dan simfisis pubis. Saat bayi lahir, tinggi fundus uteri sejajar dengan umbilikus. Dalam beberapa hari berikutnya, uterus turun secara bertahap ke dalam rongga panggul dengan kecepatan sekitar 1 cm per hari (atau setara dengan satu jari). Setelah 10 hari, uterus biasanya telah turun sepenuhnya ke dalam panggul dan tidak lagi teraba melalui pemeriksaan abdomen (Wray et al., 2021)



Gambar 1.2
Involusi uteri(Wray et al., 2021)

Tabel 1.1
Penilaian involusi uterus

Waktu Setelah Persalinan	Lokasi Fundus Uteri	Dokumentasi Klinis
Segera setelah melahirkan	Di garis tengah, terletak antara umbilikus dan simfisis pubis	—
1–2 jam	Setinggi umbilikus	U (umbilikus)
12 jam	± 1 cm di atas umbilikus (± 1 jari)	U + 1
24 jam	± 1 cm di bawah umbilikus (± 1 jari)	U – 1
2 hari	± 2 cm di bawah umbilikus (± 2 jari)	U – 2
3 hari	± 3 cm di bawah umbilikus (± 3 jari)	U – 3
7 hari	Teraba di atas simfisis pubis	—
10 hari	Tidak teraba	—

(Ward & Hisley, 2009)

Kontraksi uterus pada masa nifas tidak hanya berperan dalam proses involusi, tetapi juga membantu mengeluarkan darah, sisa selaput janin, serta verniks kaseosa dari kavum uteri melalui pengeluaran vagina yang disebut *lochia*. (Wray et al., 2021).

Pada awal masa nifas, cairan yang keluar dari vagina dikenal sebagai lochia rubra, yang biasanya tampak berwarna merah dan muncul sekitar hari ke-2 setelah persalinan. Beberapa hari kemudian, warnanya berubah menjadi merah kekuningan dan mengandung campuran darah serta lendir, disebut lochia sanguinolenta, yang umumnya berlangsung pada hari ke-3 hingga ke-7 postpartum. Selanjutnya, pengeluaran tersebut berangsur berubah menjadi kuning dan tidak lagi mengandung darah, disebut lochia serosa, yang terjadi pada hari ke-7 hingga ke-14 setelah persalinan. Setelah dua minggu, warna cairan semakin pucat hingga putih, dikenal sebagai lochia alba, dan jumlahnya

semakin sedikit (Kemenkes RI, 2022). Durasi pengeluaran lochia dapat bervariasi pada setiap ibu, namun secara umum akan berhenti dalam waktu sekitar lima minggu setelah persalinan.

Perubahan warna kehijauan atau bau tidak sedap pada lochia dapat menjadi tanda adanya infeksi. Sementara itu, pengeluaran lochia yang banyak dan berlangsung lebih dari 6 minggu perlu diwaspadai karena dapat menandakan adanya komplikasi.

Involusi Tempat Implantasi Plasenta

Segera setelah persalinan, ukuran daerah implantasi plasenta kira-kira sebesar telapak tangan. Dalam beberapa jam setelah melahirkan, area ini berisi banyak pembuluh darah yang mengalami trombosis, yang kemudian akan mengalami proses organisasi jaringan. Pada akhir minggu kedua, ukurannya menyusut menjadi sekitar 3 hingga 4 cm dan 1 hingga 2 cm pada akhir masa nifas (Sulistyowati, 2024)

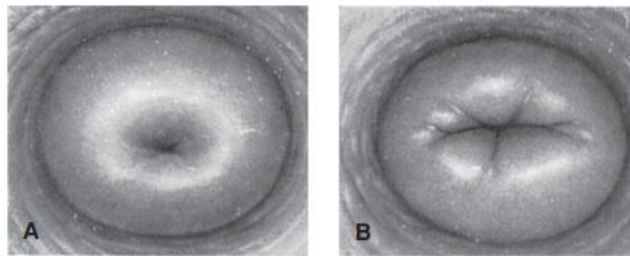
Involusi pada tempat implantasi plasenta terjadi melalui proses eksfoliasi, yang sebagian besar dipicu oleh pertumbuhan endometrium baru di bawah area implantasi. Dengan demikian, involusi ini bukan sekadar proses penyerapan jaringan di tempatnya. Proses eksfoliasi melibatkan pertumbuhan ke arah bawah dan ke arah tepi endometrium dari batas area tempat plasenta menempel, serta perkembangan jaringan endometrium yang berasal dari kelenjar dan stroma yang tersisa di lapisan desidua basalis setelah plasenta terlepas (Cunningham, et al., 2022). Eksfoliasi daerah implantasi plasenta terjadi akibat peluruhan jaringan superfisial yang mengalami infark dan nekrosis, yang kemudian diikuti oleh proses pembentukan kembali (remodeling) jaringan endometrium yang baru.

Proses pengeluaran atau pengelupasan sempurna pada daerah implantasi plasenta membutuhkan waktu hingga enam minggu.

Serviks

Selama proses persalinan, tepi serviks yang mengalami dilatasi yang merupakan bagian dari ostium uteri eksternum dapat mengalami robekan (laserasi). Serviks memperlihatkan warna yang cenderung kemerahan gelap hingga kehitaman akibat tingginya vaskularisasi pembuluh darah di area tersebut. Transformasi yang dialami serviks selama periode postpartum mencakup perubahan struktur yang membentuk pola corong. Konfigurasi seperti ini terbentuk karena adanya kontraksi pada korpus uteri, sementara serviks uteri justru tidak mengalami proses kontraksi yang sama, sehingga menciptakan semacam lingkaran batas di area pertemuan antara korpus dan serviks uteri (Lalita et al., 2025).

Setelah persalinan, pembukaan serviks menutup secara perlahan dan dalam beberapa hari pertama masih dapat dimasuki dua jari. Menjelang akhir minggu pertama masa nifas, pembukaan tersebut mulai menyempit, serviks menebal kembali, dan kanalis endoservikalis terbentuk ulang. Namun, ostium eksternum tidak sepenuhnya kembali ke bentuk seperti sebelum hamil. Biasanya, ostium eksternum tetap lebih lebar, dan lekukan-lekukan pada ektoserviks di bekas robekan menjadi permanen. Perubahan ini merupakan ciri khas serviks pada wanita yang telah melahirkan (parous cervix) (Cunningham, et al., 2022).



Gambar 1. 3.

Penampakan serviks nulipara (A) dan parous (B) (Cunningham, et al., 2022)

Segmen bawah uterus (lower uterine segment) yang sebelumnya sangat menipis selama persalinan akan berkontraksi dan beretraksi, meskipun tidak sekuat bagian korpus uteri. Dalam beberapa minggu berikutnya, segmen bawah ini akan berubah dari struktur besar yang mampu menampung kepala janin menjadi bagian sempit yang dikenal sebagai isthmus uteri, yang memisahkan korpus uteri dari ostium internum.

Secara normal, ostium uteri internum akan menutup pada minggu kedua setelah persalinan, sedangkan ostium uteri eksternum dapat tetap sedikit terbuka selama beberapa minggu berikutnya. Pada minggu keenam pascapersalinan, serviks telah kembali menutup sepenuhnya.

Vulva, Vagina dan Perineum

Vulva dan vagina mengalami tekanan dan peregangan yang signifikan selama persalinan. Hal ini akan menyebabkan kedua bagian mengalami kekenduran beberapa hari pascapersalinan. Namun vulva dan vagina secara bertahap akan mengecil ukurannya setelah persalinan, walaupun jarang kembali sepenuhnya ke ukuran seperti sebelum hamil. Rendahnya hormon estrogen pascapersalinan mengakibatkan dinding mukosa vagina menjadi lebih tipis dan struktur lipatan alamiah yang dikenal sebagai rugae mengalami kehilangan. Struktur rugae vagina umumnya mulai terbentuk lagi memasuki pekan ketiga periode nifas, kendati tidak sekuat kondisi semula (Lalita et al., 2025; Sulistyowati, 2024)

Selaput dara (hymen) pascapersalinan tidak lagi utuh, tetapi terdapat sisa jaringan kecil yang kemudian membentuk jaringan parut yang dikenal sebagai karunkula mirtoformis (myrtiform caruncles). Proliferasi atau pertumbuhan kembali epitel vagina biasanya dimulai pada minggu ke-4 hingga ke-6, bersamaan dengan kembalinya produksi hormon estrogen oleh ovarium (Cunningham, et al., 2022)

Robekan atau peregangan perineum selama persalinan dapat menyebabkan relaksasi atau pelebaran introitus vagina. Selain itu, kerusakan pada dasar panggul (pelvic floor) sering kali tidak dapat dihindari selama proses persalinan, dan kondisi ini dapat meningkatkan risiko inkontinensia urine serta prolaps organ panggul pada kemudian hari.

Perubahan Sistem Perkemihan

Selama kehamilan normal, terjadi peningkatan laju filtrasi glomerulus (glomerular hyperfiltration) sebagai akibat adaptasi fisiologis tubuh. Kondisi ini masih bertahan pada hari pertama pascapersalinan, namun biasanya kembali ke kadar normal (sebelum hamil) dalam waktu sekitar dua minggu. Selain itu, pelebaran ureter dan pelvis renalis yang terjadi selama kehamilan juga akan berangsur-angsur kembali ke ukuran normal dalam waktu 2 hingga 8 minggu setelah melahirkan (Sulistiyowati, 2024).

Produksi urine dalam volume besar umumnya terjadi pada periode 12 sampai 36 jam pasca persalinan. Fenomena diuresis ini dipicu oleh penurunan drastis konsentrasi hormon estrogen yang berperan dalam pengaturan penahan cairan tubuh. Diuresis yang sangat banyak dalam hari-hari pertama puerperium.

Pada masa nifas, dinding kandung kemih dapat mengalami edema dan hiperemia, bahkan kadang terjadi overdistensi tanpa disertai dorongan untuk berkemih. Retensi urin pada beberapa hari pertama pascapersalinan umumnya disebabkan oleh penurunan tonus otot dinding perut dan dasar panggul, atonia kandung kemih, kompresi uretra akibat edema atau hematoma, serta inhibisi refleks berkemih akibat trauma pada saluran genitourinarius (Cunningham, et al., 2022; Lowdermilk et al., 2019)

Sebaliknya, inkontinensia urin dapat terjadi pada sekitar 30% ibu pascapersalinan. Kondisi ini paling sering dikaitkan dengan stres psikologis yang menyertai proses persalinan serta adaptasi pascapersalinan (Chauhan & Tadi, 2022)

Akibat masih adanya dilatasi sistem urine, ditambah dengan sisa urine (residual urine) dan kemungkinan adanya bakteriuria pada kandung kemih yang

mengalami trauma selama persalinan, maka infeksi saluran kemih (ISK) menjadi salah satu komplikasi yang perlu diwaspadai pada masa nifas.

Trauma kandung kemih sering kali berhubungan dengan lama proses persalinan, sehingga hingga batas tertentu dianggap sebagai bagian normal dari persalinan pervaginam.

Pada masa pascapersalinan, kapasitas kandung kemih meningkat, namun sensitivitas terhadap tekanan intravesikal menurun. Akibatnya, overdistensi (pelebaran berlebihan), pengosongan kandung kemih yang tidak sempurna, serta peningkatan volume urine sisa (residual urine) sering terjadi (Cunningham, et al., 2022)

2. Perubahan Sistem Pencernaan

Aktivitas sistem gastrointestinal akan meningkat kembali segera setelah persalinan. Umumnya, ibu akan merasakan lapar dan haus setelah melalui proses persalinan yang sering kali disertai dengan pembatasan asupan makanan dan cairan.

Selama kehamilan, hormon peptida relaksin mencapai kadar sirkulasi yang tinggi dan menyebabkan penurunan motilitas usus (*bowel motility*) (Cunningham, et al., 2022). Selain itu, relaksasi otot-otot dinding abdomen dan usus, serta pengaruh hormon progesteron yang masih berlanjut pada otot polos, turut berperan dalam menurunnya aktivitas peristaltik usus pada masa nifas. Kombinasi faktor-faktor tersebut sering menyebabkan konstipasi pada periode awal puerperium. Setelah melahirkan, defekasi umumnya tertunda hingga hari kedua atau ketiga pascapersalinan. Selain itu, adanya hemoroid, trauma perineum, maupun luka episiotomi dapat menyebabkan nyeri saat buang air besar.

Untuk mencegah konstipasi, ibu dianjurkan untuk melakukan mobilisasi dini, mengonsumsi cairan dalam jumlah yang cukup, serta memperbanyak asupan makanan tinggi serat. Langkah-langkah ini efektif dalam membantu meningkatkan motilitas usus dan mencegah gangguan eliminasi selama masa nifas. Faal usus memerlukan waktu 3-4 hari untuk kembali normal (Lalita et al., 2025).

Gangguan yang lebih serius pada masa ini adalah inkontinensia fekal, yaitu ketidakmampuan menahan pengeluaran feses. Kondisi ini terjadi akibat regangan atau cedera pada otot dan saraf dasar panggul yang berperan dalam pengendalian defekasi, termasuk sfingter ani selama proses persalinan. Risiko kerusakan saraf dan otot meningkat pada persalinan dengan bantuan forseps atau vakum, serta pada robekan perineum derajat tinggi yang meluas ke arah posterior.

Meskipun seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman dan rasa malu bagi ibu, inkontinensia fekal umumnya bersifat sementara dan dapat membaik dalam beberapa bulan. Namun, apabila keluhan tersebut tidak membaik atau menetap, diperlukan evaluasi dan penanganan spesialis, termasuk kemungkinan tindakan pembedahan rekonstruktif untuk memperbaiki fungsi sfingter ani dan dasar panggul (Wray et al., 2021).

3. Perubahan Sistem Muskuloskeletal

Selama kehamilan, sendi dan ligamen panggul mengalami kelonggaran. Hormon relaksin dan progesteron diyakini berperan dalam melonggarkan jaringan lunak (termasuk otot, ligamen, dan jaringan ikat) di daerah panggul ibu untuk mempermudah proses persalinan. Pada sebagian wanita, pelonggaran sendi panggul ini dapat menimbulkan rasa nyeri serta keterbatasan fungsi gerak. Setelah persalinan, hormon relaksin secara perlahan menurun, dan ligamen mulai mengalami proses *remodeling*. Proses ini memungkinkan ligament yang telah meregang untuk berkontraksi dan Kembali ke bentuk serta kekuatannya sebelum kehamilan (Lalita et al., 2025; Ward & Hisley, 2009).

Dalam beberapa hari pertama setelah melahirkan, ibu dapat mengalami kelelahan otot dan nyeri tubuh secara umum akibat usaha fisik selama persalinan dan kelahiran bayi. Kelelahan otot ini dapat bertambah berat karena asupan makanan dan cairan yang terbatas selama proses persalinan. Selain itu, penggunaan glukosa tubuh yang meningkat selama proses persalinan juga berkontribusi terhadap kelelahan otot, yang dapat mengganggu kemampuan ibu untuk berjalan dan memulai latihan pascapersalinan.

Selama kehamilan, dinding abdomen mengalami regangan progresif untuk menopang janin yang sedang tumbuh. Regangan ini menyebabkan penurunan tonus otot rektus abdomen, sehingga otot menjadi lembek, kendur, dan lemah setelah melahirkan. Diastasis rekti abdominis adalah kondisi di mana otot rektus abdominis mengalami jarak pemisahan melebihi 2,5 cm, khususnya pada area sejajar dengan umbilicus, yang disebabkan oleh dampak hormonal pada linea alba serta tekanan regangan mekanis yang dialami dinding abdomen (Lalita et al., 2025)

Wanita perlu menyadari bahwa pada periode awal pascapersalinan, dinding perut belum cukup kuat untuk menahan tekanan dari aktivitas fisik yang meningkat.

Striae gravidarum yang terjadi selama kehamilan biasanya hanya memudar warnanya tetapi dapat menetap secara permanen.

4. Perubahan Sistem Kardiovaskuler

Selama kehamilan, jantung mengalami pergeseran posisi sedikit ke atas dan ke kiri akibat desakan dari uterus yang membesar. Seiring dengan involusi uterus pada masa nifas, jantung akan kembali ke posisi normalnya.

Perubahan hemodinamik maternal yang signifikan terjadi akibat kelahiran bayi, pengeluaran plasenta, dan kehilangan cairan amnion. Perubahan mendadak ini dapat menyebabkan instabilitas kardiovaskular pada periode segera setelah persalinan.

Meskipun terjadi kehilangan darah fisiologis sekitar 500 mL pada persalinan pervaginam dan 1000 mL pada persalinan sesar, curah jantung ibu tetap meningkat secara signifikan di atas kadar sebelum persalinan selama 1–2 jam pertama pascapersalinan, dan tetap tinggi hingga 48 jam berikutnya. Curah jantung umumnya kembali ke tingkat pra-kehamilan dalam waktu 2–4 minggu setelah melahirkan.

Rata-rata terjadi penurunan berat badan sekitar 3 kg selama minggu pertama masa nifas. Proses diuresis fisiologis berlangsung antara hari ke-2 hingga ke-5 pascapersalinan. Perpindahan cairan utama terjadi melalui pergeseran cairan ekstraseluler kembali ke sistem vena untuk kemudian diekskresikan melalui urin dan keringat. Apabila diuresis fisiologis tidak terjadi dengan baik, maka akan meningkatkan risiko terjadinya edema paru.

Curah jantung dan volume sekuncup tetap meningkat selama sedikitnya 48 jam setelah melahirkan. Dalam waktu 2 minggu, curah jantung menurun sekitar 30%, dan kemudian mencapai nilai pra-kehamilan antara 6 hingga 12 minggu pascapersalinan (Ward & Hisley, 2009).

5. Perubahan Sistem Hematologi

Selama persalinan, kadar hematokrit ibu dapat menurun akibat kehilangan darah, namun akan meningkat kembali seiring berkurangnya volume plasma melalui proses diuresis dan hemokonsentrasi. Nilai hematokrit biasanya kembali normal dalam waktu 3–5 hari pascapersalinan, seiring penyesuaian kembali volume plasma tubuh ibu (Chauhan & Tadi, 2022).

Variasi nilai hemoglobin pada periode pascapersalinan disebabkan oleh perubahan volume plasma akibat perpindahan cairan tubuh. Kehilangan darah sekitar 500 mL pada persalinan pervaginam (atau sekitar 1000 mL pada persalinan seksio sesarea) biasanya menyebabkan penurunan kadar hemoglobin sekitar 1 gram (atau 2 gram pada seksio sesarea) (Ward & Hisley, 2009). Beberapa studi longitudinal menunjukkan bahwa diperlukan waktu sekitar 4–6 bulan untuk mengembalikan kadar hemoglobin ke tingkat normal sebagaimana pada wanita yang tidak hamil.

Selain itu, ibu dapat mengalami leukositosis fisiologis, yaitu peningkatan jumlah sel darah putih hingga sekitar $25.000/\text{mm}^3$ sebagai respons terhadap stres akibat persalinan. Kondisi ini bersifat sementara dan biasanya kembali ke kadar sebelum hamil dalam waktu empat minggu pascapersalinan. Trombositopenia gestasional yang terjadi selama kehamilan juga akan membaik antara hari ke-4 hingga hari ke-10 setelah persalinan. Selama kehamilan, terjadi peningkatan aktivitas beberapa faktor pembekuan darah seperti fibrinogen, faktor VII, VIII, X, XII, faktor von Willebrand, serta aktivitas ristocetin. Peningkatan ini merupakan mekanisme fisiologis untuk mencegah kehilangan darah berlebihan selama persalinan. Pada periode postpartum awal, kadar fibrinogen tetap tinggi, sementara jumlah trombosit secara bertahap meningkat menuju nilai normal. Meskipun kondisi ini memberikan efek protektif terhadap perdarahan, hal tersebut juga meningkatkan risiko terbentuknya trombus

Enzim plasminogen, yang berperan dalam proses pelisisan bekuan darah, belum menunjukkan peningkatan atau normalisasi selama masa nifas awal. Kondisi hiperkoagulabilitas yang terjadi selama kehamilan akan membaik secara bertahap, dengan kadar faktor pembekuan kembali normal dalam waktu 8–12 minggu pascapersalinan.

6. Perubahan Sistem Endokrin

Sistem endokrin maternal mengalami penyesuaian besar selama kehamilan untuk mendukung keberhasilan proses kehamilan. Hormon estrogen dan progesteron awalnya diproduksi oleh korpus luteum selama beberapa minggu pertama kehamilan, namun setelah implantasi, produksi hormon tersebut diambil alih oleh plasenta. Kadar kedua hormon ini meningkat secara bertahap sepanjang kehamilan, tetapi segera setelah persalinan dan pengeluaran plasenta, kadarnya menurun secara drastis (Wray et al., 2021)

Selain itu, kadar kortisol dan prolaktin juga meningkat tajam selama kehamilan. Plasenta menghasilkan *corticotropin-releasing hormone* (pCRH), yang menstimulasi pelepasan kortisol. Proses ini independen dari *hypothalamic-pituitary-adrenal axis* (HPA axis). Pada saat persalinan, terjadi peningkatan konsentrasi kortisol yang lebih tinggi lagi, yang diyakini membantu mematangkan sistem janin agar siap untuk lahir. Namun, setelah plasenta lahir pCRH hilang dan kadar CRH plasma kembali normal dalam waktu sekitar 15 jam pascapersalinan. Kadar kortisol kemudian menurun cepat dalam beberapa hari hingga minggu pertama masa nifas.

Prolaktin disekresikan oleh kelenjar hipofisis anterior, dan menjelang akhir kehamilan, kadarnya 10–20 kali lebih tinggi daripada kadar tidak hamil. Kerja prolaktin dihambat oleh adanya progesteron, tetapi begitu kadar progesteron

turun, prolaktin merangsang produksi ASI. Menyusui menyebabkan pelepasan prolaktin lebih lanjut dan kadarnya akan tetap tinggi hingga menyusui berhenti. Jika seorang wanita tidak menyusui, kadar prolaktin akan kembali normal dalam waktu 2–3 minggu.

Selama proses persalinan, terjadi sekresi oksitosin dalam jumlah besar dari hipofisis posterior. Selain berperan dalam kontraktilitas miometrium selama persalinan dan refleks pengeluaran ASI selama laktasi, oksitosin juga memiliki peran sentral dalam pembentukan perilaku keibuan, termasuk proses keterikatan dan pembentukan ikatan emosional antara ibu dan bayi.

Perubahan hormonal yang ekstrem selama masa nifas juga berhubungan dengan timbulnya gangguan suasana hati (*mood disorders*), mulai dari *baby blues* hingga depresi pascapersalinan dan psikosis pascapersalinan. Penurunan mendadak kadar estradiol atau rendahnya kadar oksitosin dapat berperan dalam terjadinya gangguan kesehatan mental pada ibu pascapersalinan.

Kadar hormon *human chorionic gonadotropin* (hCG), yang memiliki efek menyerupai hormon perangsang tiroid, menurun drastis setelah persalinan. Akibatnya, volume kelenjar tiroid akan kembali ke ukuran sebelum hamil dalam waktu sekitar 12 minggu, dan fungsi tiroid biasanya kembali normal dalam 4 minggu pascapersalinan.

7. Perubahan Tanda-tanda Vital

Pengukuran tanda vital pada ibu memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan ibu secara menyeluruh. Dalam kondisi normal, denyut nadi ibu berada pada rentang 60-80 kali per menit secara fisiologis. Apabila terjadi perubahan denyut nadi yang mengarah pada bradikardi (kurang dari 60 kali per menit) atau takhikardi (melebihi 100 kali per menit), hal ini mengindikasikan kemungkinan adanya shock atau kehilangan darah. Secara fisiologis, suhu tubuh mengalami perubahan pada periode segera pascapersalinan, di mana terjadi peningkatan ringan berkisar antara 0,2-0,5°C. Peningkatan ini disebabkan oleh aktivitas metabolisme yang melonjak selama proses melahirkan serta kebutuhan energi kalori yang bertambah di saat persalinan berlangsung. Suhu tubuh normal berada dalam rentang 36,5°C hingga 37,5°C. Akan tetapi, jika suhu tubuh meningkat hingga mencapai 38°C, kondisi ini sudah mengisyaratkan adanya indikasi infeksi yang perlu diwaspadai.

Dalam kondisi yang wajar, laju pernapasan cenderung stabil tanpa fluktuasi berarti selama periode postpartum, dengan kisaran normal seperti orang dewasa pada umumnya yakni 12-16 kali setiap menitnya. Tekanan darah pada masa nifas awal, secara fisiologis akan meningkat secara bertahap dan kembali mendekati nilai normal seperti sebelum kehamilan. MAP (Mean Arterial Pressure) atau

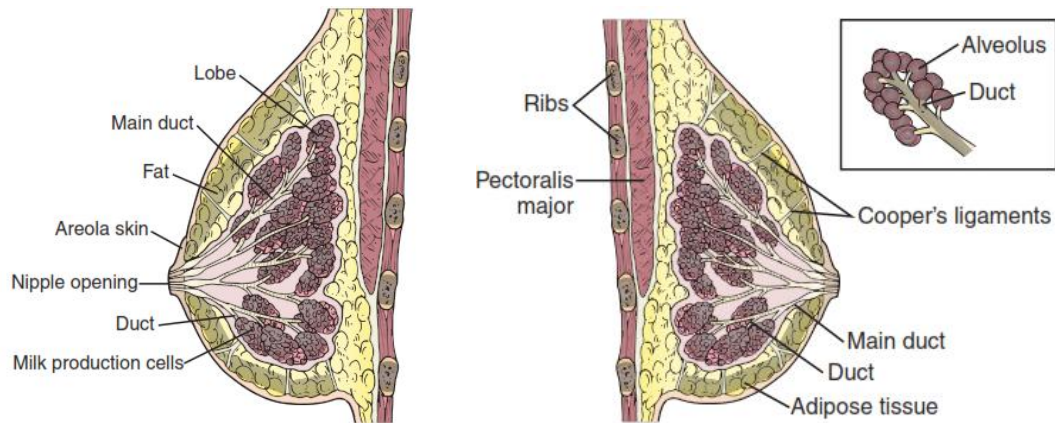
tekanan arteri rata-rata juga akan menyesuaikan menuju kisaran normal, seiring dengan proses adaptasi sistem kardiovaskular pascapersalinan (Cunningham, et al., 2022; Wahyuningsih, 2018).

D. Fisiologi Laktasi

1. Anatomi Fisiologi Payudara

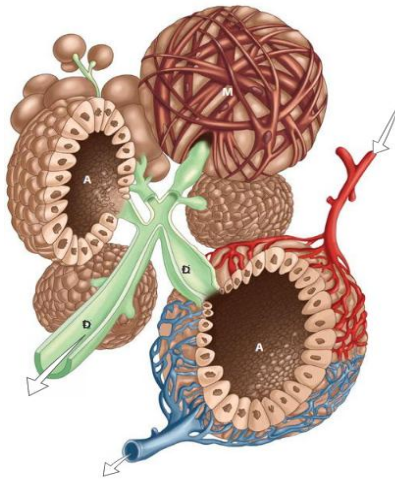
Payudara adalah organ kelenjar susu yang pembentukannya dimulai pada fase embrional, tepatnya di sekitar minggu kelima masa kehamilan, yang berasal dari struktur jaringan glandular dan posisinya berada di antara lapisan kulit bagian luar serta otot dada bagian dalam. Peran primer payudara bagi perempuan ialah memproduksi air susu ibu (ASI) yang menjadi asupan nutrisi pokok untuk bayi. Massa payudara mengalami fluktuasi yang disesuaikan dengan tahapan fase fisiologis tubuh, dimulai dari bobot sekitar 200 gram saat belum hamil, kemudian bertambah hingga kurang lebih 600 gram ketika memasuki masa kehamilan, dan mencapai puncaknya sekitar 800 gram pada saat periode laktasi berlangsung (Sulistyowati, 2024)

Lokasi payudara membentang dari iga nomor dua hingga nomor enam, dimulai dari sternum menuju ke arah pusat tubuh, melewati area otot pektoralis. Penyangga kedua payudara ini berupa struktur jaringan ikat fibrosa yang dikenal dengan sebutan ligamen cooper. Ukuran payudara pada setiap ibu berbeda-beda, di mana perbedaan ini lebih ditentukan oleh volume jaringan lemak ketimbang jumlah jaringan kelenjar di dalamnya. Pada bagian sentral permukaan luar payudara, terdapat areola yang merupakan zona dengan pigmentasi khusus. Ukuran diameter areola umumnya mencapai 15 mm. Putting susu merupakan bagian yang memiliki kepekaan tinggi dan karakteristik erektile, tersusun dari serat-serat otot polos, kolagen, serta jaringan ikat elastis yang tersusun dalam dua pola yakni sirkuler dan radial. Posisi putting susu berada tepat di pusat areola (Wahyuningsih, 2018)



Gambar 1.4
Anatomi payudara pada masa laktasi (Ward & Hisley, 2009)

Payudara dibentuk oleh jaringan lemak dan jaringan glanduler yang tidak dapat dipisahkan, kecuali di daerah subkutaneus yang hanya terdapat lemak. Pada payudara yang sedang menyusui, terdapat lobus-lobus yang berisi sel-sel penghasil susu yang disebut alveolus, jaringan lemak, serta duktus. Saluran-saluran tersebut bergabung dan bermuara menjadi sekitar 9 hingga 10 lubang pada puting susu. Setiap payudara terdiri atas 15 hingga 25 lobus. Struktur lobus-lobus ini tersebar mengikuti pola radial dengan pemisahan antara satu dan lainnya melalui lapisan jaringan lemak dalam proporsi yang tidak seragam. Setiap lobus dibentuk oleh sejumlah lobulus, di mana masing-masing lobulus tersusun dari banyak sekali alveolus. Tiap alveolus dilengkapi dengan saluran berukuran kecil yang saling berhubungan dan menyatu membentuk saluran berdiameter lebih besar untuk melayani setiap lobus. Saluran-saluran laktiferus ini bermuara secara terpisah pada puting susu, di mana lubang-lubangnya dapat terlihat sebagai orifisium kecil yang tampak jelas.



Gambar 1.5

Skema sistem alveolar dan duktus pada masa laktasi. Serabut mioepitel (*M*) tampak mengelilingi bagian luar alveolus bagian atas. Sekresi yang dihasilkan oleh sel-sel kelenjar dikeluarkan ke dalam lumen alveolus (*A*), kemudian didorong keluar oleh kontraksi sel-sel mioepitel menuju sistem duktus (*D*), yang selanjutnya bermuara melalui puting susu. Suplai darah arteri ke alveolus ditunjukkan oleh panah di bagian kanan atas, sedangkan aliran balik vena ditunjukkan oleh panah di bagian bawah (Cunningham, et al., 2022).

2. Endokrinologi Laktasi

Proses laktasi diatur oleh mekanisme hormonal (*humoral*) dan saraf (*neural*) yang saling berinteraksi secara kompleks. Beberapa hormon utama yang berperan meliputi progesteron, estrogen, plasenta laktogen, prolaktin, kortisol, dan insulin yang selama kehamilan, hormon-hormon ini bekerja sama untuk menstimulasi pertumbuhan jaringan kelenjar susu dan mempersiapkan payudara agar mampu memproduksi ASI setelah persalinan.

Setelah persalinan kadar hormon progesteron dan estrogen menurun secara drastis. Penurunan ini menghilangkan efek penghambatan progesteron terhadap pembentukan α -laktalbumin, yaitu protein penting dalam sintesis laktosa. Dengan berkurangnya progesteron, enzim laktosa sintase menjadi aktif sehingga meningkatkan produksi laktosa (gula susu) dan merangsang sel-sel alveolus untuk mulai memproduksi ASI. Pada saat yang sama, prolaktin dapat bekerja secara optimal tanpa hambatan untuk merangsang sintesis komponen utama ASI.

Setelah proses laktasi dimulai, stimulasi mekanis dari hisapan bayi menjadi faktor utama yang mempertahankan produksi ASI. Ketika bayi menyusui atau payudara dikosongkan secara teratur, ini akan merangsang pelepasan prolaktin dari lobus anterior hipofisis untuk mempertahankan produksi susu. Sebaliknya, jika rangsangan menyusui berkurang atau payudara tidak dikosongkan dengan baik, produksi ASI akan menurun.

Secara bersamaan, oksitosin yang dihasilkan oleh lobus posterior hipofisis bekerja secara berdenyut untuk membantu pengeluaran ASI. Hormon ini menyebabkan kontraksi sel mioepitel yang mengelilingi alveolus dan saluran ASI, sehingga ASI terdorong keluar menuju puting. Proses ini dikenal sebagai refleks ejeksi susu atau refleks let-down.

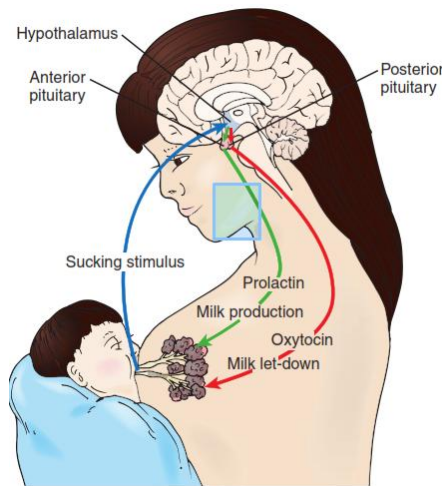
Refleks let-down biasanya dipicu oleh rangsangan menyusui, namun dapat juga muncul hanya dengan mendengar tangisan bayi. Sebaliknya, kondisi emosional seperti rasa cemas, takut, atau stres pada ibu dapat menghambat pelepasan oksitosin, sehingga mengganggu proses pengeluaran ASI (Cunningham, et al., 2022)

Dengan demikian, keberhasilan menyusui sangat dipengaruhi oleh keseimbangan hormon prolaktin dan oksitosin serta kondisi emosional dan stimulasi yang adekuat pada payudara.

3. Fisiologi Laktasi

Laktogenesis merupakan proses di mana payudara menghasilkan dan mengeluarkan ASI. Proses ini bergantung pada pelepasan dua hormon utama, yaitu prolaktin dan oksitosin. Pembentukan ASI dimulai segera setelah plasenta lahir, yang menyebabkan penurunan kadar hormon progesteron dan estrogen dalam plasma, serta peningkatan sekresi prolaktin dari lobus anterior kelenjar hipofisis. Hormon prolaktin menstimulasi alveolus, yaitu sel-sel penghasil ASI, untuk memproduksi dan mensekresikan ASI.

Stimulasi dari hisapan bayi akan memicu pelepasan hormon oksitosin dari lobus posterior hipofisis. Oksitosin menyebabkan kontraksi otot polos sel mioepitel yang mengelilingi alveolus, sehingga mendorong ASI keluar dari alveolus menuju duktus laktiferus. Pengeluaran ASI ke dalam duktus laktiferus untuk dikeluarkan disebut refleks ejeksi susu atau refleks let-down. Ibu menyusui sering menggambarkan sensasi let-down sebagai rasa kesemutan atau seperti tertusuk jarum halus yang muncul tepat sebelum atau selama menyusui.



Gambar 1.6
Mekanisme produksi ASI (Ward & Hisley, 2009)

Proses laktogenesis terbagi ke dalam tiga stadium pokok. Dua stadium pertama dipicu oleh aktivitas hormonal atau respon *neuroendokrin*, yakni keterkaitan antara sistem *endokrin* dan sistem saraf (*neuroendocrine responses*), yang berlangsung secara otomatis tanpa bergantung pada keinginan ibu untuk menyusui. Sementara itu, stadium ketiga bersifat *autocrine* (kondisi di mana sel memproduksi senyawa kimiawi atau hormon yang bekerja terhadap dirinya sendiri), atau berada di bawah kontrol lokal.

- b. Tahap 1 (Laktogenesis I), terjadi pada akhir masa kehamilan. Pada tahap ini, alveolus mengalami pematangan, proliferasi sistem duktus sekretori, serta peningkatan ukuran dan berat payudara. Meskipun hormon prolaktin sudah hadir sepanjang masa kehamilan, aktivitasnya tertekan akibat peningkatan kadar progesteron, estrogen, serta HPL (*Human Placental Lactogen*), ditambah adanya PIF (*Prolactin Inhibiting Factor*) yang berfungsi sebagai penghambat. Adapun keluarnya kolustrum pada ibu yang sedang mengandung biasanya mulai terjadi di trimester 3, terutama ketika usia kandungan memasuki rentang 34 hingga 36 minggu.
- c. Tahap 2 (Laktogenesis II), dimulai pada masa pascapersalinan dan merupakan permulaan produksi ASI. Penurunan kadar progesteron dalam plasma menyebabkan peningkatan kadar prolaktin, yang memicu produksi ASI dalam jumlah besar pada hari keempat hingga kelima setelah persalinan. Kontak *skin-to-skin* dengan bayi pada waktu inisiasi menyusui dini (IMD) akan merangsang produksi prolaktin dan okitosin. Menyusui secara dini dan teratur menghambat produksi PIF dan merangsang produksi prolaktin.
- d. Tahap 3 (Laktogenesis III), merupakan tahap pematangan dan pemeliharaan produksi ASI. Laktogenesis III mengindikasikan pengaturan autokrin. Tahap ini

diatur oleh prinsip *supply and demand* (persediaan dan permintaan), yaitu semakin sering bayi menyusu, semakin banyak susu yang diproduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat suatu protein whey yang disebut feedback inhibitor of lactation (FIL), yang disekresikan oleh sel laktosit dan berperan dalam mengatur produksi air susu ibu (ASI) pada tingkat lokal di payudara. Ketika alveolus mengalami penggelembungan akibat penumpukan ASI, kadar FIL meningkat sehingga proses sintesis ASI terhambat. Sebaliknya, apabila ASI dikeluarkan secara optimal melalui kegiatan menyusui, konsentrasi FIL akan menurun dan produksi ASI kembali berlangsung normal. Mekanisme ini bersifat lokal dan dapat terjadi pada salah satu maupun kedua payudara. Proses ini merupakan bentuk umpan balik negative (*negative feedback hormone*), di mana pengeluaran ASI yang tidak efektif seperti menyusui yang kurang optimal atau tidak adanya aktivitas menyusu akan menurunkan stimulasi produksi ASI (Cunningham, et al., 2022; Wahyuningsih, 2018; Ward & Hisley, 2009)

Tahap penyapihan yang kadang disebut tahap 4, terjadi ketika stimulasi payudara berhenti. Pada tahap ini, produksi susu menurun secara signifikan seiring berkurangnya rangsangan mekanis pada puting.

Apabila menyusui tidak dilakukan, baik pada ibu menyusui maupun yang tidak menyusui, atau bila payudara tidak dikosongkan secara teratur (misalnya dengan pompa), maka akan terjadi penumpukan peptida penghambat (inhibiting peptides). Peptida ini, yang dilepaskan di bawah pengaruh hipotalamus, bekerja pada sel sekretori payudara dan menyebabkan penurunan bertahap volume susu serta akhirnya kematian sel epitel penghasil susu.

E. Upaya Meningkatkan Keberhasilan Laktasi

Keberhasilan laktasi tidak hanya ditentukan oleh faktor fisiologis, tetapi juga oleh dukungan emosional, sosial, dan lingkungan yang mendukung ibu dalam proses menyusui.

1. Pendampingan oleh Tenaga Kesehatan dan Konsultan Laktasi

Kolaborasi antar tenaga kesehatan dan sumber daya komunitas sangat penting untuk mendukung keberhasilan laktasi dan kesejahteraan ibu menyusui. Bidan dan konsultan laktasi perlu bekerja secara terpadu dalam memberikan asuhan yang komprehensif, berkesinambungan, dan berpusat pada kebutuhan ibu dan bayi. Bidan atau konsultan laktasi memiliki keahlian mendalam dalam fisiologi laktasi, teknik menyusui, penanganan masalah laktasi, serta konseling ibu menyusui (Ward & Hisley, 2009).

2. Perawatan Payudara Selama Masa Laktasi

Tindakan breast care atau perawatan payudara memiliki tujuan untuk memperlancar aliran darah serta mencegah tersumbatnya saluran ASI agar produksi dan keluarnya air susu ibu dapat berjalan lancar. Salah satu bentuk perawatan payudara yang bisa diterapkan ialah melalui teknik pijat laktasi. Pijat laktasi memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan produksi ASI pada ibu nifas (Hanubun et al., 2023). Pijat laktasi dapat merangsang pelepasan hormon prolaktin dan oksitosin, dua hormon utama yang berperan dalam proses laktasi. Prolaktin menstimulasi sel alveoli untuk menghasilkan susu, sedangkan oksitosin membantu kontraksi sel mioepitel sehingga mempermudah pengeluaran ASI. Selain itu, pijat laktasi juga dapat membantu ibu merasa rileks, menurunkan stres, memperlancar sirkulasi darah, serta mencegah sumbatan pada saluran ASI.

3. Pemenuhan Nutrisi dan Istirahat Ibu

Asupan nutrisi yang seimbang, hidrasi yang cukup, serta istirahat yang memadai sangat penting untuk mendukung produksi ASI. Ibu menyusui dianjurkan mengonsumsi makanan bergizi tinggi dan memperbanyak cairan. Ibu menyusui dianjurkan juga menghindari stres berlebihan (Cunningham, et al., 2022; (WHO), 2022)

4. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Pelaksanaan IMD pada jam awal pasca melahirkan terbukti mampu mempercepat laju produksi ASI sekaligus menguatkan refleks menyusu pada bayi. Sentuhan langsung kulit ibu dengan kulit bayi turut merangsang keluarnya hormon oksitosin, yang memiliki fungsi vital dalam proses refleks ejeksi ASI serta membangun kedekatan emosional antara ibu dan sang buah hati. Praktik IMD yang dilakukan dalam rentang 30 menit sejak bayi terlahir tercatat sebagai satu dari 10 langkah strategis untuk mencapai kesuksesan dalam program menyusui (Umar, 2021; Zahra et al., 2023).

5. Dukungan Suami dan Keluarga

Dukungan emosional dari suami dan keluarga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan menyusui. Suami berperan dalam memberikan motivasi, membantu pekerjaan rumah tangga, serta menciptakan suasana yang nyaman dan tenang agar ibu dapat menyusui dengan rileks. Dukungan emosional dan praktis dari keluarga dapat meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam menyusui, mengurangi stres, dan mendorong ibu untuk terus memberikan ASI meskipun menghadapi tantangan (Mulia Fujianty, 2024).

6. Peningkatan self-efficacy

Self-efficacy mempengaruhi motivasi dan ketahanan ibu dalam menyusui. *Self-efficacy* yang tinggi terkait dengan pengetahuan yang lebih baik tentang

teknik menyusui dan manfaat ASI, yang pada gilirannya akan meningkatkan keberhasilan laktasi. *Breastfeeding Self Efficacy* (BSE) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran produksi ASI pada ibu nifas. Ibu dengan tingkat kepercayaan diri tinggi cenderung memiliki produksi ASI yang lebih baik (Khusniyati, 2025; Mulia Fujianty, 2024).

F. Faktor yang Mempengaruhi Pemulihan Ibu Pascapersalinan

Pemulihan masa nifas dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik secara fisik maupun psikologis. Faktor-faktor ini menentukan seberapa cepat dan optimal tubuh ibu dapat kembali pulih setelah melahirkan (Herien, 2024).

1. Kondisi kesehatan ibu

Keadaan kesehatan secara umum, termasuk riwayat penyakit sebelum dan sesudah persalinan, berperan besar dalam proses pemulihan. Komplikasi seperti perdarahan, infeksi, atau tindakan operasi caesar dapat memperlambat penyembuhan dan memerlukan perhatian serta perawatan khusus.

2. Nutrisi dan Asupan Cairan

Kecukupan gizi menjadi faktor penting dalam mempercepat pemulihan dan kesejahteraan ibu pascapersalinan. Makanan bergizi membantu memperbaiki jaringan tubuh, mengembalikan energi yang hilang, serta menunjang produksi air susu ibu (ASI). Ibu perlu mengonsumsi makanan dengan kandungan protein, vitamin, dan mineral yang seimbang, disertai asupan cairan yang memadai untuk memproduksi ASI dan memenuhi kebutuhan energi.

3. Istirahat dan Tidur

Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup dan kualitas tidur yang baik serta relaksasi untuk mengembalikan energi dan memperbaiki jaringan setelah proses persalinan. Kurangnya waktu tidur dapat menyebabkan kelelahan, meningkatkan stres, dan menurunkan daya tahan tubuh, sehingga menghambat proses pemulihan pascapersalinan.

4. Aktivitas Fisik dan Mobilisasi Dini

Melakukan mobilisasi dini secara bertahap setelah melahirkan bermanfaat untuk melancarkan sirkulasi darah, mengurangi resiko pembekuan darah, serta mempercepat pemulihan kekuatan otot. Aktivitas sederhana seperti berjalan dapat membantu mempercepat penyembuhan luka dan meningkatkan stamina ibu.

5. Personal Hygiene

Menjaga kebersihan tubuh, terutama area genital dan payudara, sangat penting untuk mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan luka.

Kebersihan yang terjaga juga memberikan rasa nyaman serta meningkatkan kesejahteraan fisik dan emosional ibu.

6. Dukungan Emosional dan Kesehatan Mental

Perubahan hormon dan tanggung jawab baru sebagai ibu dapat memengaruhi kondisi emosional. Dukungan dari pasangan, keluarga, dan lingkungan sekitar sangat berperan dalam mengurangi stres, mencegah depresi pascapersalinan, serta menumbuhkan rasa percaya diri ibu dalam merawat bayinya.

G. Penutup

Pemahaman yang komprehensif mengenai fisiologi pemulihan ibu dan laktasi merupakan dasar penting dalam praktik asuhan kebidanan pascapersalinan. Masa nifas adalah periode adaptasi fisiologis yang melibatkan perubahan besar pada sistem reproduksi, kardiovaskular, endokrin, serta psikologis ibu. Proses pemulihan ini tidak hanya memastikan kembalinya fungsi tubuh ke keadaan sebelum hamil, akan tetapi juga mendukung keberhasilan menyusui sebagai komponen penting dari kesehatan ibu dan bay.

Laktasi adalah hasil kerja sama kompleks antara sistem hormonal dan system saraf yang dikendalikan oleh keseimbangan prolaktin dan oksitosin. Proses ini memperlihatkan bahwa produksi dan pengeluaran ASI sangat bergantung pada kondisi emosional, nutrisi, serta dukungan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, tenaga kesehatan, khususnya bidan berperan penting dalam memberikan edukasi, konseling, dan dukungan emosional untuk membantu ibu melewati masa transisi pascapersalinan dengan baik.

Dengan pemahaman yang tepat terhadap proses fisiologis ini, tenaga kesehatan diharapkan mampu menerapkan asuhan berbasis bukti yang aman, efektif, dan berkelanjutan. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual akan mendukung tercapainya kesejahteraan ibu dan bayi secara optimal serta berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

H. Referensi

- Chauhan, G., & Tadi, P. (2022). *'Physiology, Postpartum Changes*. National Library of Medicine National Centre For Biotechnology Information [Preprint].
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2022). *Williams Obstetrics* (26th ed.). McGraw-Hill Education.

- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Spong, C. Y., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Sheffield, J. S. (2022). *Williams obstetrics (26th ed.)*. McGraw-Hill Education.
- Herien, Y. (2024). Kebutuhan Dasar Ibu Postpartum. In *CV EUREKA MEDIA AKSARA*.
- Jihan El Arief Hanubun, Triana Indrayani, & Retno Widiowati. (n.d.). *Pengaruh Pijat Laktasi Terhadap Produksi Asi Ibu Nifas*.
- Kemenkes RI. (2022). Panduan Pelayanan Pasca Persalinan bagi Ibu dan Bayi Baru Lahir. In *Kemenkes RI*.
- Khusniyati, E. (2025). Pengaruh Breastfeeding Self Efficacy (BSE) terhadap Kelancaran Produksi ASI pada Ibu Nifas di PMB Teta Irayanti, AMD. Keb Desa Plososari Kecamatan Puri Kab. Mojokerto. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 1682–1692.
- Lalita, E. M. F., Indarsita, D., Melly, Sarliana, Amanupunny, otesya A., Murtiyarini, I., & Isnina. (2025). *ASUHAN KEBIDANAN MASA NIFAS*. PT MEDIA PUSTAKA INDO.
- Lowdermilk, D. L., Cashion, K., Perry, S. E., Alden, K. R., & Olshansky, E. (2019). *Maternity and Women's Health Care 12th Edition*. Elsevier.
- Mulia Fujianty, M. K. D. M. S. (2024). Hubungan Breastfeeding Self Efficacy, Manajemen Laktasi dan Dukungan Keluarga. *Maryam Syarah INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 4120–4130.
- Prawirohardjo, S. (2012). *Ilmu Kebidanan*. Bina Pustaka.
- Sulistiyowati, A. N. (2024). *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas dan Menyusui* (Cetakan I). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Umar, F. (2021). *Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan Kelangsungan ASI Anak Usia di Bawah Dua Tahun*. Penerbit NEM.
- Victora CG, Bahl R, Barros AJ, França GV, Horton S, Krasevec J, Murch S, Sankar MJ, Walker N, R. N. (2016). Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. *Lancet.*, 387(10017), 475-90. doi: 10.1016/S0140-6736(15)01024-7. PMID: 26869575.
- Wahyuningsih, H. P. (2018). *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Kementerian Kesehatan RI.
- Wambach, K., & Spencer, B. (2021). *Breastfeeding and human lactation (6th ed.)*. Jones & Bartlett Learning.
- Ward, Js. L., & Hisley, S. M. (2009). *Maternal-Child Nursing Care Optimizing Outcomes for Mothers, Children, and Families*. F.A. Davis Company.
- (WHO), W. H. O. (2022). *WHO Recommendations on Maternal and Newborn Care for a Positive Postnatal Experience*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240045989>

Wray, S., Prendergast, C., & Wallace, H. (2021). Physiology of the Puerperium and Lactation. In *The Continuous Textbook of Women's Medicine Series – Obstetrics Module Volume 15 The puerperium*. Glob Libr Women's Med.

Zahra, I. M., Rini, A. S., & Hidayani, H. (2023). Hubungan Inisiasi Menyusu Dini, Tingkat Kecemasan, Dan Frekuensi Menyusui Terhadap Onset Laktasi Pada Ibu Postpartum Di Rsud Jagakarsa Tahun 2022. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7), 2405–2419. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1141>

I. Glosarium

A

Alveolus : adalah tempat produksi dan penyimpanan susu di kelenjar mammae.

ASI (Air Susu Ibu) : cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu sebagai sumber utama nutrisi dan imunologis bagi bayi.

E

Endometrium : Adalah lapisan terdalam di dalam rahim (uterus) wanita yang berperan penting dalam siklus menstruasi dan kehamilan yang mengalami regenerasi pasca persalinan setelah proses peluruhan desidua.

F

FIL (Feedback Inhibitor of Lactation): Protein whey yang berfungsi mengatur produksi ASI secara lokal melalui mekanisme umpan balik negatif di alveolus payudara

H

Hipofisis : Kelenjar endokrin utama di dasar otak yang menghasilkan hormon prolaktin dan oksitosin, berperan penting dalam laktasi.

I

Involusi Uterus : Proses pengembalian ukuran Rahim ke kondisi normal setelah melahirkan.

L

Laktogenesis : Proses di mana payudara menghasilkan dan mengeluarkan ASI.

Let-down Reflex : Refleks yang menyebabkan kontraksi sel mioepitel untuk mendorong ASI keluar dari alveolus menuju puting, dipicu oleh hormon oksitosin

Lochia : Cairan yang keluar dari rahim setelah melahirkan, terdiri dari darah, lendir, dan jaringan yang terlepas dari dinding rahim

M

Mioepitel : Sel otot polos kecil yang mengelilingi alveolus dan duktus pada payudara, berfungsi membantu ejeksi ASI.

O

Oksitosin : Hormon yang diproduksi oleh hipofisis posterior dan berperan dalam kontraksi uterus serta refleks ejeksi ASI.

P

Prolaktin : Hormon dari hipofisis anterior yang menstimulasi produksi ASI pada sel-sel alveolus

Puerperium : periode adaptasi dan pemulihan menyeluruh yang dialami ibu setelah melahirkan, dimulai segera setelah lahirnya plasenta hingga kira-kira enam minggu (42 hari) pascapersalinan

S

Self-efficacy : kepercayaan diri ibu terhadap kemampuannya untuk menyusui bayinya secara berhasil dan berkelanjutan

U

Uterus : Organ reproduksi wanita tempat janin tumbuh selama kehamilan dan mengalami proses involusi setelah melahirkan

BAB 2

KONSEP PERDARAHAN PASCA PERSALINAN: PENCEGAHAN DAN TATA LAKSANA

A. Pendahuluan

Perdarahan pascapersalinan (PPH) terus menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas ibu di sebagian besar negara di dunia. Meskipun berbagai upaya kolaboratif di semua tingkatan telah dilakukan, masih terdapat kekurangan implementasi atau kepatuhan terhadap rekomendasi penatalaksanaan PPH dalam menghadapi kegawatdaruratan obstetrik ini. Keterlambatan implementasi ini sebagian disebabkan oleh kurangnya informasi dari bukti yang ada dan kurangnya penyatuan berbagai pedoman diagnosis dan strategi pengendalian perdarahan. Semua wanita yang sedang hamil 20 minggu memiliki resiko perdarahan postpartum. Walaupun angka kematian maternal telah turun secara drastis di negara-negara berkembang, perdarahan postpartum tetap merupakan penyebab kematian maternal terbanyak dimana-mana. Insiden perdarahan postpartum adalah Atonia uteri 50 – 60 %, Sisa plasenta 23 – 24 %, Retensio plasenta 16 – 17 %, Laserasi jalan lahir 4 – 5 %, Kelainan darah 0,5 – 0,8 % (Kelly, *et al.* 2024)

B. Definisi Perdarahan Pasca Persalinan

1. Perdarahan Pasca Persalinan Primer/Dini merupakan kondisi kegawatdaruratan obstetri yang dapat menyebabkan kematian maternal dalam waktu singkat (dapat terjadi dalam waktu 2 jam sejak perdarahan dimulai). Kehilangan darah ≥ 500 ml setelah persalinan pervaginam atau ≥ 1000 ml setelah seksio sesarea, terjadi dalam 24 jam pertama setelah melahirkan.
2. Perdarahan Pasca Persalinan Sekunder/Lanjut: Perdarahan abnormal atau berlebihan dari saluran genital yang terjadi setelah 24 jam hingga 12 minggu pasca persalinan (Manuaba, 2014).

C. Faktor Predisposisi

Faktor yang mempengaruhi perdarahan postpartum adalah:

1. Usia

Wanita yang melahirkan anak pada usia lebih dari 35 tahun merupakan faktor predisposisi terjadinya perdarahan postpartum yang dapat mengakibatkan kematian maternal. Hal ini dikarenakan pada usia diatas 35 tahun fungsi

reproduksi seorang wanita sudah mengalami penurunan dibandingkan fungsi reproduksi normal (Saifuddin, 2014).

2. Paritas

Salah satu penyebab perdarahan postpartum adalah multiparitas. Paritas menunjukkan jumlah kehamilan terdahulu yang telah mencapai batas viabilitas dan telah dilahirkan. Primipara adalah seorang yang telah pernah melahirkan satu kali satu janin atau lebih yang telah mencapai batas viabilitas, oleh karena itu berakhirnya setiap kehamilan melewati tahap abortus memberikan paritas pada ibu. Seorang multipara adalah seorang wanita yang telah menyelesaikan dua atau lebih kehamilan hingga viabilitas. Hal yang menentukan paritas adalah jumlah kehamilan yang mencapai viabilitas, bukan jumlah janin yang dilahirkan. Paritas tidak lebih besar jika wanita yang bersangkutan melahirkan satu janin, janin kembar, atau janin kembar lima, juga tidak lebih rendah jika janinnya lahir mati. Uterus yang telah melahirkan banyak anak, cenderung bekerja tidak efisien dalam semua kala persalinan (Saifuddin, 2014).

3. Anemia dalam kehamilan

Anemia adalah suatu keadaan yang ditandai dengan penurunan nilai hemoglobin dibawah nilai normal, dikatakan anemia jika kadar hemoglobin kurang dari 11g/dL. Kekurangan haemoglobin dalam darah dapat menyebabkan komplikasi lebih serius bagi ibu baik dalam kehamilan, persalinan, dan nifas. Oksigen yang kurang pada uterus akan menyebabkan otot-otot uterus tidak berkontraksi dengan adekuat sehingga dapat timbul atonia uteri yang mengakibatkan perdarahan postpartum (Manuaba, 2014).

4. Riwayat persalinan

Riwayat persalinan dimasa lampau sangat berhubungan dengan hasil kehamilan dan persalinan berikutnya. Bila riwayat persalinan yang lalu buruk petugas harus waspada terhadap terjadinya komplikasi dalam persalinan yang akan berlangsung. Riwayat persalinan buruk ini dapat berupa abortus, kematian janin, eklampsia dan preeklampsia, sectio caesarea, persalinan sulit atau lama, janin besar, infeksi dan pernah mengalami perdarahan antepartum dan postpartum.

5. Bayi makrosomia

Bayi besar adalah bayi lahir yang beratnya lebih dari 4000 gram. Menurut kepustakaan bayi yang besar baru dapat menimbulkan dystosia kalau beratnya melebihi 4500 gram. Kesukaran yang ditimbulkan dalam persalinan adalah karena besarnya kepala atau besarnya bahu. Karena regangan dinding rahim oleh anak yang sangat besar dapat menimbulkan inertia dan kemungkinan perdarahan postpartum lebih besar.

6. Kehamilan ganda

Kehamilan ganda dapat menyebabkan uterus terlalu meregang, dengan overdistensi tersebut dapat menyebabkan uterus atonik atau perdarahan yang berasal dari letak plasenta akibat ketidak mampuan uterus berkontraksi dengan baik.

D. Penyebab (Mnemonic 4T)

Perdarahan postpartum disebabkan oleh banyak faktor. Beberapa faktor predisposisi adalah anemia, yang berdasarkan prevalensi di negara berkembang merupakan penyebab yang paling bermakna. Penyebab perdarahan postpartum paling sering adalah atonia uteri serta retensio plasenta, penyebab lain kadang-kadang adalah laserasi serviks atau vagina, ruptur uteri, dan inversi uteri (Saifuddin, 2014).

Penyebab utama Perdarahan Pasca Persalinan primer menurut Kelly, *et al* (2024), sebagai berikut:

1. *Tonus* (Atonia Uteri): kondisi kegawatdaruratan obstetri yang terjadi ketika rahim (uterus) gagal berkontraksi atau mengencang dengan baik setelah melahirkan bayi dan plasenta. Kontraksi uterus tidak adekuat setelah plasenta lahir, sehingga pembuluh darah di tempat implantasi plasenta tidak tertutup.
2. *Tissue* (Retensio Plasenta/Sisa Plasenta): Plasenta atau sebagian jaringan plasenta (dan bekuan darah) tertinggal di dalam uterus.
3. *Trauma* (Robekan Jalan Lahir): Robekan pada serviks, vagina, atau perineum, atau ruptur uteri.
4. *Thrombin* (Koagulopati): Gangguan pembekuan darah (misalnya, kondisi bawaan atau didapat seperti pre-eklampsia berat/HELLP syndrome).

E. Faktor Risiko

1. Riwayat Perdarahan Pasca Persalinan sebelumnya.
2. Kehamilan ganda (gemeli).
3. Peregangan uterus berlebihan (misalnya, polihidramnion, bayi besar).
4. Anemia pada ibu hamil.
5. Persalinan lama atau persalinan dengan tindakan (misalnya, forseps, vakum).
6. Jarak kehamilan yang pendek.

F. Pencegahan Perdarahan Pasca Persalinan

Klasifikasi kehamilan risiko rendah dan risiko tinggi akan memudahkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk menata strategi pelayanan ibu hamil

saat perawatan antenatal dan melahirkan. Akan tetapi, pada saat proses persalinan, semua kehamilan mempunyai risiko untuk terjadinya patologi persalinan, salah satunya adalah PPP (Prawirohardjo, 2014). Adapun Pencegahan PPH secara umum dapat dilakukan antara lain:

1. Persiapan Antenatal

- a. Mengatasi anemia dan penyakit kronis sebelum atau selama kehamilan.
- b. Identifikasi faktor risiko perdarahan pasca persalinan pada ibu.
- c. Merencanakan persalinan di fasilitas dengan bank darah atau layanan bedah jika risiko tinggi.

2. Manajemen Aktif Kala Tiga (MAKT)

Strategi pencegahan utama yang dilakukan secara rutin pada semua persalinan, sebagai berikut:

- a. Pemberian Uterotonika: Pemberian Oksitosin 10 IU secara intramuskular (IM) segera setelah bayi lahir (pilihan pertama dan paling efektif).
- b. Peregangannya Tali Pusat Terkendali (PTT): Setelah uterus berkontraksi.
- c. Masase Uterus: Segera setelah plasenta lahir hingga uterus berkontraksi dengan baik.

3. Tindakan Tambahan

- a. Menghindari episiotomi rutin.
- b. Melakukan inspeksi plasenta dan selaput ketuban untuk memastikan kelengkapan.
- c. Memantau tonus uterus dan perdarahan setiap 15 menit selama dua jam pertama pasca persalinan.

Berikut Rekomendasi *Federasi Internasional Ginekologi dan Obstetri* (FIGO) untuk pencegahan perdarahan pascapersalinan terkait penggunaan Uterotonika.

1. Penggunaan uterotonika untuk pencegahan PPH selama kala tiga persalinan direkomendasikan untuk semua kelahiran. Oksitosin (10 IU intravena/intramuskular [IV/IM]) direkomendasikan untuk pencegahan PPH pada persalinan pervaginam dan seksio sesarea. Pada kondisi penggunaan oksitosin, perhatian harus diberikan pada rantai dingin oksitosin.
2. Pada kondisi di mana oksitosin tidak tersedia atau kualitasnya tidak dapat dijamin, penggunaan uterotonik suntik lainnya (jika sesuai ergometrine/methylergometrine 200 µg IM/IV; gangguan hipertensi dapat disingkirkan dengan aman sebelum penggunaannya) atau misoprostol oral (400–600 µg secara oral) atau carbetocin 100 µg IM/IV direkomendasikan untuk pencegahan PPH.

3. Kombinasi ergometrin plus oksitosin atau misoprostol plus oksitosin mungkin merupakan strategi obat uterotonika yang lebih efektif untuk pencegahan perdarahan postpartum ≥ 500 ml dibandingkan dengan standar saat ini, oksitosin. Hal ini mengorbankan risiko efek samping yang lebih tinggi (muntah dan hipertensi akibat ergometrin dan demam akibat misoprostol).
4. Pada kondisi dimana bidan terlatih tidak hadir untuk memberikan uterotonika suntik dan oksitosin tidak tersedia, pemberian misoprostol (400–600 μg secara oral) oleh petugas kesehatan masyarakat dan petugas kesehatan awam direkomendasikan untuk pencegahan PPH.
5. Pada kondisi di mana bidan yang terampil tidak tersedia, traksi tali pusat terkendali (KTK) tidak direkomendasikan.
6. Pijat rahim yang berkelanjutan tidak direkomendasikan sebagai intervensi untuk mencegah PPH pada wanita yang telah menerima oksitosin profilaksis
7. Penilaian tonus uterus abdomen pascapersalinan untuk identifikasi dini atonia uterus direkomendasikan untuk semua wanita.
8. Oksitosin (IV atau IM) dan CCT adalah metode yang direkomendasikan untuk mengeluarkan plasenta guna mencegah PPH pada persalinan sesar.

G. Tatalaksana Perdarahan Pasca Persalinan

Penanganan pasien dengan PPP memiliki dua komponen utama yaitu resusitasi dan pengelolaan perdarahan obstetri yang mungkin disertai syok hipovolemik dan identifikasi serta pengelolaan penyebab dari perdarahan. Keberhasilan pengelolaan perdarahan postpartum mengharuskan kedua komponen secara simultan dan sistematis ditangani (Edhi, 2013).

1. Prinsip Umum (HAEMOSTASIS)

Tatalaksana dilakukan secara simultan dan sistematis:

- a. *Help* (Minta Bantuan): Panggil staf senior/tim bantuan.
- b. *Assess* (Nilai): Nilai kondisi umum, tanda-tanda vital, dan jumlah perdarahan (pengukuran kumulatif lebih akurat daripada perkiraan visual).
- c. *Establish Access & Resuscitation* (Akses & Resusitasi): Pasang 2 akses intravena (IV) berukuran besar (misalnya, 14G atau 16G). Berikan cairan kristaloid maksimal 2 liter.
- d. *Measure* (Ukur): Ukur kehilangan darah dan pantau tanda vital secara ketat (tiap 5 menit).
- e. *Oxygenate & Monitor* (Oksigenasi & Pantau): Berikan oksigen dan pantau saturasi.
- f. *Special Investigations* (Pemeriksaan Khusus): Ambil sampel darah (darah lengkap, faktor koagulasi, *crossmatch*).

- g. *Treat the Cause* (Tangani Penyebab): Tangani penyebab perdarahan (4T).
 - h. *Additional Measures* (Tindakan Tambahan): *Tranexamic acid* dapat diberikan (1 gram IV) jika uterotonika tidak efektif atau dicurigai adanya koagulopati.
 - i. *Surgical/Interventional Management* (Tatalaksana Bedah/Intervensi): Jika penanganan awal gagal.
 - j. *Inform* (Informasi): Komunikasi dengan pasien dan tim.
 - k. *Support* (Dukungan): Dukungan emosional dan debriefing staf.
2. Tatalaksana Berdasarkan Penyebab
- a. *Tonus* (Atonia Uteri)
 - 1) Tindakan Awal: Masase uterus, Kompresi Bimanual Eksterna/Interna.
 - 2) Farmakologi:
 - a) Oksitosin (10-40 IU dalam 500-1000 ml kristaloid secara drip).
 - b) Misoprostol (800-1000 mcg per rektal).
 - c) Ergometrin/Metilergometrin (kontraindikasi pada hipertensi).
 - 3) Tatalaksana Lanjut (Jika Gagal):
 - a) Intrauterine Balloon Tamponade (misalnya, balon Bakri).
 - b) Kompresi jahitan uterus (misalnya, teknik B-Lynch).
 - c) Devaskularisasi arteri pelvis.
 - d) Histerektomi (sebagai pilihan terakhir).
 - b. *Tissue* (Retensio Plasenta/Sisa Plasenta)
 - 1) Plasenta Belum Lahir: Persiapan tatalaksana *manual removal of placenta* (pelepasan plasenta manual) di bawah anestesi jika PTT gagal.
 - 2) Sisa Plasenta: Evakuasi sisa plasenta (misalnya, kuretase tumpul) setelah plasenta lahir.
 - c. *Trauma* (Robekan Jalan Lahir)
 - 1) Identifikasi sumber robekan melalui inspeksi.
 - 2) Lakukan penjahitan robekan yang sesuai pada serviks, vagina, atau perineum.
 - 3) Tatalaksana hematoma.
 - 4) Tatalaksana ruptur uteri (bedah).
 - d. *Thrombin* (Koagulopati)
 - 1) Pemberian produk darah (PRC, FFP, Krio) sesuai protokol transfusi masif dan hasil laboratorium.
 - 2) Konsultasi dengan ahli hematologi.
 - 3) Pemberian *Tranexamic Acid*.

Rekomendasi FIGO (2022) untuk penanganan perdarahan pascapersalinan

- a. Oksitosin intravena saja merupakan obat uterotonika lini pertama yang direkomendasikan untuk pengobatan PPH.
- b. Jika oksitosin intravena tidak tersedia, atau jika perdarahan tidak merespons oksitosin, penggunaan ergometrin intramuskular, dosis tetap oksitosin-ergometrin, atau obat prostaglandin (termasuk misoprostol sublingual, 800 µg) direkomendasikan.
- c. Tidak ada bukti tentang keamanan dan kemanjuran dosis tambahan misoprostol 800 µg untuk pengobatan PPH bila diberikan kepada wanita yang telah menerima 600 µg misoprostol profilaksis secara oral.
- d. Penggunaan kristaloid isotonik direkomendasikan sebagai pengganti penggunaan koloid untuk resusitasi cairan intravena awal pada wanita dengan PPH. [4](#)
- e. Penggunaan asam traneksamat intravena dini segera setelah PPH terdiagnosis tetapi dalam waktu 3 jam setelah melahirkan sebagai tambahan perawatan standar direkomendasikan bagi wanita dengan PPH yang terdiagnosis secara klinis setelah melahirkan pervaginam atau operasi caesar.
- f. Pemberian 1 g (100 mg/ml) asam traneksamat secara intravena dengan kecepatan 1 ml/menit (yaitu diberikan selama 10 menit), dengan dosis kedua 1 g secara intravena jika perdarahan berlanjut setelah 30 menit, atau jika perdarahan kembali terjadi dalam 24 jam setelah menyelesaikan dosis pertama. Mengurangi kematian ibu akibat perdarahan melalui peningkatan penggunaan asam traneksamat untuk penanganan PPH dapat memberikan dampak positif terhadap pemerataan kesehatan dan meningkatkan luaran di kalangan perempuan kurang mampu, terutama di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah (LMIC).
- g. Pijat uterus direkomendasikan untuk pengobatan PPH.
- h. Penggunaan kompresi uterus bimanual atau kompresi aorta eksternal untuk penanganan PPH akibat atonia uterus setelah persalinan pervaginam direkomendasikan sebagai tindakan sementara sampai tersedia penanganan yang tepat.
- i. Jika wanita tidak merespons pengobatan menggunakan uterotonika, atau jika uterotonika tidak tersedia, penggunaan tamponade balon uterus direkomendasikan sebagai teknik nonsurgical yang efektif yang berpotensi meningkatkan kelangsungan hidup pada wanita dengan PPH karena atonia uterus setelah menyingkirkan produk konsepsi yang tertahan atau ruptur uterus sebagai faktor penyebabnya.

- j. Penggunaan pakaian anti-guncangan non-pneumatik direkomendasikan sebagai tindakan sementara sampai tersedia perawatan yang tepat.
 - k. Penggunaan tampon uterus tidak direkomendasikan untuk penanganan PPH akibat atonia uteri setelah persalinan pervaginam. ³
 - l. Embolisasi arteri uterina dapat menjadi tindakan manajemen konservatif lain untuk PPH jika kondisi teknis dan sumber daya manusia yang terampil tersedia untuk penggunaannya. ¹⁷
 - m. Jika pendarahan tidak berhenti meskipun telah dilakukan pengobatan menggunakan uterotonika dan intervensi konservatif lain yang tersedia (misalnya pijat rahim, tamponade balon), penggunaan intervensi bedah dianjurkan. Intervensi bedah meliputi penggunaan teknik jahitan kompresi, ligasi arteri rahim dan hipogastrik, dan histerektomi.
 - n. Prioritasnya adalah menghentikan pendarahan sebelum pasien mengalami masalah koagulasi dan kerusakan organ akibat perfusi yang kurang. Pendekatan konservatif harus dicoba terlebih dahulu, dan segera beralih ke prosedur yang lebih invasif jika tidak berhasil.
3. Persiapan Rujukan
- a. Lakukan stabilisasi pasien seoptimal mungkin sebelum merujuk.
 - b. Pastikan akses IV terpasang, perdarahan terkontrol (jika memungkinkan), dan tanda vital stabil.
 - c. Dampingi pasien selama rujukan dan berikan informasi tatalaksana yang telah diberikan.

H. Komplikasi Perdarahan Pasca Persalinan

Kehilangan darah terjadi pada perdarahan postpartum (PH), sehingga pasien berisiko mengalami syok hipovolemik. Ketika pasien kehilangan 20% darah, mereka mengalami takikardia, takipnea, tekanan nadi menyempit, dan pengisian kapiler tertunda. Hal ini dapat menyebabkan cedera iskemik pada hati, otak, jantung, dan ginjal. Sindrom Sheehan, atau hipopituitarisme postpartum, juga merupakan komplikasi dari kehilangan darah berlebih yang terlihat pada perdarahan postpartum. Komplikasi yang terkait dengan penanganan PPH meliputi hal berikut:

1. Cedera paru akut terkait transfusi
2. Infeksi
3. Edema paru
4. Reaksi transfusi hemolitik
5. Sinekia intrauterin
6. Persalinan prematur
7. Kemandulan

I. Konsultasi

Pendekatan interprofesional diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam pengelolaan PPH, termasuk:

1. Obstetri dan Ginekologi
2. Kedokteran ibu-janin
3. Bedah umum
4. Anestesiologi
5. Hematologi
6. Urologi
7. Kedokteran darurat
8. Personel laboratorium
9. Radiologi intervensional

J. Daftar Pustaka

- A. Fahira Nur *et.al.* 2019. Faktor Resiko Kejadian Perdarahan Postpartum di Rumah Sakit Umum Anutapura. Palu : Jurnal Kebidanan Stikes Widya Palu, Vol. 5, No. 1 Januari 2019.
- ACOG Committee on Practice Bulletins—Obstetrics. (2017). Postpartum Hemorrhage: Practice Bulletin No. 183. *Obstetrics & Gynecology*, 130(4), e168–e186.
- Ann Evensen, Janice M. Anderson, Patricia fontaine. 2017. Postpartum Hemorrhage: Prevention and Treatment. *American Family Physician*.
[https://www.aafp.org/pubs/afp.html?cmpid= van 188](https://www.aafp.org/pubs/afp.html?cmpid=van_188)
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. 2014. *Williams Obstetrics*. New York: McGraw-Hill Education.
- FIGO. (2022). FIGO Consensus Guidelines on Postpartum Hemorrhage. International Federation of Gynecology and Obstetrics. Prevention and treatment of postpartum hemorrhage in low-resource settings. *Int J Gynecol Obstet*. 2012;117:108-118
- Manuaba, I. B. G., Manuaba, I. A. C., & Manuaba, I. B. F. (2014). *Pengantar Kuliah Obstetri*. Jakarta: EGC.
- Saifuddin, A. B. 2014. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- WHO. 2012. *WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum haemorrhage*. Geneva: World Health Organization.

WHO. 2018. WHO recommendation on uterotonics for the prevention of postpartum haemorrhage. Geneva: World Health Organization.

BAB 3

INFEKSI, ANEMIA, DAN NYERI PASCAPERSALINAN

A. Pendahuluan

Masa nifas atau masa setelah melahirkan merupakan masa yang penting dan berisiko, dimana tubuh ibu mulai menyesuaikan dan pulih dari proses melahirkan. Pada masa ini, terjadi perubahan di dalam tubuh yang cepat, seperti perut kembali seperti semula, darah dalam tubuh berkurang, serta perubahan hormon dan daya tahan tubuh. Perubahan ini bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang mungkin mengganggu kondisi ibu. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah infeksi setelah melahirkan, seperti infeksi pada luka setelah operasi atau episiotomi.(Wijaya, Limbong and Yulianti, 2023) Infeksi ini masih menjadi penyebab utama kecacatan atau kematian ibu, terutama di daerah yang tidak memiliki akses layanan kesehatan yang baik. Berdasarkan penelitian, beberapa faktor meningkatkan risiko infeksi, seperti kunjungan ke bidan atau dokter yang kurang, operasi caesar, serta kekurangan darah selama kehamilan (anemia). Infeksi ini tidak hanya membuat ibu harus lebih lama berada di rumah sakit, tetapi juga bisa menyebabkan kondisi serius seperti sepsis atau peradangan pembuluh darah di daerah pinggul.(Setiani and Yulianti, 2022)

Selain itu, anemia setelah melahirkan juga merupakan masalah kesehatan yang sering diabaikan. Persentase ibu yang menderita anemia pada masa nifas cukup tinggi, terutama di wilayah yang sumber daya kesehatan terbatas. Studi menunjukkan bahwa anemia setelah melahirkan memiliki dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental ibu, seperti merasa lelah, depresi, serta mengganggu interaksi antara ibu dan anak. Anemia selama kehamilan juga terbukti menjadi faktor penyebab perdarahan setelah melahirkan yang bisa memperburuk kondisi ibu. (Moya *et al.*, 2022)

Nyeri setelah melahirkan juga merupakan hal penting yang memengaruhi pemulihan ibu secara keseluruhan, termasuk kemampuan bergerak, nyaman, menyusui, dan kualitas hidup. Nyeri bisa terjadi karena kontraksi rahim, luka di perineum, luka dari operasi caesar, atau nyeri di tulang dan otot pasca melahirkan. Jika nyeri tidak diatasi dengan baik, proses pemulihan bisa terhambat, kegiatan sehari-hari terganggu, dan risiko gangguan mental meningkat. Dari penjelasan di atas, penting bagi para tenaga kesehatan, seperti bidan, perawat, dan dokter

kandungan, untuk memahami lebih dalam mengenai permasalahan infeksi, anemia, dan nyeri setelah melahirkan.(Wijaya, Limbong and Yulianti, 2023)

Buku ini dibuat untuk menjadi sumber ilmu dan panduan praktis berdasarkan bukti, agar bisa membantu mencegah, mendeteksi dini, dan menangani masalah tersebut. Dengan demikian, diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kesehatan ibu pasca melahirkan, mengurangi risiko kesakitan dan kematian ibu, serta membantu pemulihan segera pascasalin.

B. Infeksi

Infeksi adalah salah satu masalah kesehatan yang paling umum terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan, baik klinik maupun rumah sakit. Infeksi dapat terjadi pada pasien, petugas kesehatan, maupun pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan.(Ririn *et al.*, 2023) Infeksi bisa disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan parasit.(Kementerian Kesehatan RI, 2020)

Virus adalah merupakan salah satu penyebab penyakit infeksi yang paling sering ditemui. Virus tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa karena ukurannya yang sangat kecil ($\pm 1/50$ bakteri). Virus mengandung sejumlah kecil asam nukleat (DNA atau RNA) tetapi tidak kombinasi keduanya. Virus diselubungi semacam bahan pelindung yang terdiri atas protein, lipid, glikoprotein, atau kombinasi ketiganya. Virus bersifat parasit obligat, hal tersebut disebabkan karena virus hanya dapat bereproduksi di dalam material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup. Virus berkembang biak dalam sel inangnya dengan cara memasukkan asam Replikasi terjadi melalui penggandaan materi genetik sel inang dan mengambil alih metabolisme sel inang untuk membentuk materi genetik virus itu sendiri. Beberapa penyakit akibat infeksi virus yang banyak ditemukan di Indonesia, antara lain: Influenza, Campak, Hepatitis, Demam Berdarah Dengue (DBD), HIV/AIDS, Flu Burung, SARS, Novel Coronavirus (Covid-19).

Bakteri adalah kelompok mikroorganisme yang tidak memiliki membran inti sel, dan berukuran sangat kecil, namun lebih besar dari virus. Bakteri memiliki peran besar dalam kehidupan manusia karena dapat memberikan manfaat di bidang pangan, pengobatan, dan industri. Namun kelompok bakteri yang patogen justru sangat merugikan manusia. Bakteri dapat ditemukan hampir pada semua tempat: di tanah, air, udara, dalam simbiosis dengan organisme lain maupun sebagai agen parasit (patogen), bahkan dalam tubuh manusia.

Jamur mudah tumbuh di daerah beriklim tropis, hangat, kelembaban tinggi, dan tidak higienes. Jamur adalah organisme yang dapat hidup secara alami di tanah atau tumbuhan. Bahkan jamur bisa hidup di kulit manusia. Meskipun normalnya tidak berbahaya, namun beberapa jamur dapat mengakibatkan gangguan

kesehatan yang serius. Beberapa contoh penyakit akibat jamur yang sering terjadi antara lain: Infeksi jamur kaki (Athlete's foot), Infeksi jamur kulit (panau), pada kuku, infeksi jamur pada vagina, Histoplasmosis, Blastomycosis, Candidiasis, dan Aspergillosis. Sebagian jenis jamur juga dapat menyebabkan Meningitis dan Pneumonia.

Parasit adalah organisme yang hidup pada atau di dalam makhluk hidup lain (inang) dengan menyerap nutrisi, tanpa memberi bantuan atau manfaat lain padanya. Parasit dapat menyerang manusia dan hewan, parasit penyebab infeksi yang banyak ditemui antara lain: cacing, amuba, malaria, giardia, amoeba, toksoplasma. Adapun, kejadian infeksi di fasilitas kesehatan dapat disebabkan oleh 6 komponen rantai penularan yaitu agen infeksi, reservoir, pintu keluar, cara penularan, pintu masuk, dan penjamu rentan.

Agen infeksi (infectious agent) adalah mikroorganisme penyebab infeksi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya berupa bakteri, virus, jamur dan parasit. Ada tiga faktor pada agen penyebab yang mempengaruhi terjadinya infeksi yaitu: patogenitas, virulensi dan jumlah (dosis, atau "load"). Reservoir atau tempat tempat/sumber agen infeksi dapat hidup, tumbuh, berkembang biak dan siap ditularkan kepada pejamu atau manusia. Berdasarkan penelitian, reservoir terbanyak adalah pada manusia, alat medis, binatang, tumbuh-tumbuhan, tanah, air, lingkungan dan bahan-bahan organik lainnya. Dapat juga ditemui pada orang sehat, permukaan kulit, selaput lendir mulut, saluran napas atas, usus dan vagina juga merupakan reservoir. Pintu keluar (portal of exit): adalah tempat agen infeksi meninggalkan reservoir misalnya melalui saluran napas, saluran cerna, saluran kemih, luka pada kulit atau transplasenta. Cara penularan: adalah metode transmisi adalah metode transpor mikroorganisme dari tempat/reservoir ke penjamu yang rentan melalui kontak (langsung dan tidak langsung), droplet, airborne, melalui vehikulum (makanan, air/minuman, darah) dan melalui vektor (biasanya serangga dan binatang pengerat).

Pintu masuk (portal of entry): adalah tempat agen infeksi memasuki host, misalnya saluran napas, saluran cerna, kemih, mata, kelamin atau kulit yang tidak tertutup. Pejamu rentan adalah seseorang dengan kekebalan tubuh menurun sehingga tidak mampu melawan agen infeksi. Adapun, faktor yang dapat mempengaruhi kekebalan adalah umur, status gizi, status imunisasi, penyakit kronis, luka bakar yang luas, trauma, pasca pembedahan. (Kementerian Kesehatan RI, 2020)

C. Anemia

Anemia merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan kurangnya jumlah sel darah merah dalam darah. Kekurangan hemoglobin dalam darah dapat menyebabkan komplikasi lebih serius bagi ibu baik dalam kehamilan, persalinan dan nifas. Oksigen yang kurang pada uterus akan menyebabkan otot-otot uterus tidak berkontraksi dengan adekuat sehingga dapat timbul atonia uteri yang mengakibatkan perdarahan.(Kasjmir, et all, 2018)

Anemia didefinisikan sebagai konsentrasi hemoglobin (Hb) yang rendah dalam darah. Anemia pada ibu nifas didefinisikan sebagai kadar hemoglobin kurang dari 10 gr/dl, hal ini merupakan masalah yang umum dalam bidang obstetric.(Tri Zelharsandy, Soleha and Abdurahman Palembang, 2023) Penegakkan diagnosis anemia dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium kadar hemoglobin/Hb dalam darah dengan menggunakan metode Cyanmethemoglobin. Anemia terjadi karena berbagai sebab, seperti defisiensi besi, defisiensi asam folat, vitamin B12 dan protein. Secara langsung anemia terutama disebabkan karena produksi/kualitas sel darah merah yang kurang dan kehilangan darah baik secara akut atau menahun.(Kementerian Kesehatan RI, 2018)

Anemia atau disebut juga kurang darah adalah keadaan di mana sel darah merah kurang dari normal dan biasanya yang digunakan sebagai dasar ukur adalah kadar Hemoglobin (Hb). Hemoglobin merupakan indikator yang penting untuk mengetahui adanya anemia atau tidak. Hemoglobin (Hb) terdapat dalam sel darah merah. Hemoglobin merupakan protein yang terdapat dalam sel darah merah atau eritrosit, yang memberi warna merah pada darah. Hemoglobin terdiri dari zat besi yang merupakan pembawa oksigen. Jika jumlah hemoglobin dalam eritrosit rendah, maka kemampuan membawa sel darah merah ke seluruh tubuh akan menurun.(Arisani and Seri Wahyuni, 2024)

Pada kondisi awal, pasien akan memiliki toleransi yang rendah untuk melakukan aktivitas fisik, sesak saat beraktifitas ringan, serta mudah lelah. Bila derajat anemia makin parah, tanda dan gejala klinis pun menjadi lebih jelas, seperti penurunan kinerja dan daya tahan, apatis, gelisah, gangguan kognitif dan konsentrasi, sesak, berdebar, pusing berputar, hipotensi ortostatik, serta ditemukan pucat seluruh tubuh, dan murmur sistolik pada katup mitral jantung. Keparahan derajat gejala yang diderita pasien juga berkaitan dengan komorbiditas yang ada pada pasien. Misalnya, pasien dengan kelainan jantung dan paru, manifestasinya akan menjadi lebih jelas.

Gejala anemia dapat dibedakan menjadi akut dan kronis. Anemia akut akan menyebabkan sesak yang tiba-tiba, pusing, dan kelelahan yang mendadak. Pada

kondisi anemia kronis seperti defisiensi besi, gejala yang muncul bersifat gradual, dan baru disadari oleh pasien saat kondisi eritrosit sudah sangat rendah. Khusus pada anemia defisiensi besi, kondisi defisiensi besi yang parah akan merusak enzim yang memerlukan besi, seperti sitokrom di banyak jaringan pada tubuh. Hal ini akan terlihat paling signifikan pada kulit yang menjadi sangat tidak sehat. Di antaranya adalah koilonikia (kuku berbentuk cekung dan sangat rapuh), ngular stomatitis (luka atau ulkus pada ujung mulut), glositis (peradangan pada mulut), antropik gastritis (inflamasi pada gaster), achlorhydria (kekurangan asam hialuronat pada gaster), disfagia (sulit menelan (akibat plummer-vinson syndrome atau Peterson-Brown-Kelly syndrome)).(Wibowo, Rima and Rabbania, 2021)

D. Anemia Pascapersalinan

Anemia merupakan keadaan tidak mencukupinya eritrosit untuk mengantarkan kebutuhan oksigen jaringan. Karena hal ini sulit diukur, maka anemia didefinisikan sebagai rendahnya konsentrasi hemoglobin (Hb), hitung eritrosit, dan hematokrit (Hct) dari nilai normal.(Wibowo, Rima and Rabbania, 2021)

Anemia adalah masalah yang sering dialami oleh ibu nifas. Pada masa nifas, terjadi kehilangan darah yang menyebabkan jumlah hemo-globin didalam tubuh menurun, sehingga menyebabkan sel-sel tubuh tidak cukup mendapatkan pasokan oksigen.(Wibowo, Rima and Rabbania, 2021; Estiningtyas *et al.*, 2023) Anemia nifas merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi tingginya angka kematian ibu di Indonesia, maka upaya pencegahannya adalah mengetahui sejak dini apakah seseorang menderita anemia atau tidak dan segera mengupayakan langkah-langkah penanggulangan anemia.(Tri Zelharsandy, Soleha and Abdurahman Palembang, 2023)

Anemia postpartum (Nifas) didefinisikan suatu keadaan dengan ditandai menurunnya kadar hemoglobin di bawah nilai normal akibatnya dapat mengganggu kapasitas darah untuk mengangkut oksigen ke sekitar tubuh. Menurut WHO tahun 2021, kejadian anemia pada ibu postpartum adalah 56%. India kematian akibat anemia mencapai 19%, dari kasus anemia pada ibu postpartum 65%- 75%. Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2020 menyebutkan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2020 di Indonesia kematian pada ibu postpartum dikarenakan anemia mencapai 30%.(Sulastri *et al.*, 2023)

Anemia masa nifas menyebabkan penurunan kualitas hidup, penurunan kemampuan kognitif, ketidak-stabilan emosi, serta depresi pada ibu nifas. Anemia pada periode nifas merupakan satu dari berbagai masalah yang berkontribusi pada angka mortalitas dan morbiditas maternal. Terdapat sekitar 50- 80% wanita nifas

mengalami anemia dalam periode waktu 48 jam setelah melahirkan. Mayoritas penyebab anemia adalah defisiensi zat besi. Prevalensi anemia nifas pada negara berkembang berkisar antara 50- 80%. Ibu nifas dengan anemia dapat sembuh setelah beberapa minggu atau bulan setelah persalinan dan tidak mengalami gejala yang serius. Akan tetapi, jika proses pemulihan membutuhkan waktu yang lebih lama, ibu akan mengalami gejala seperti depresi, defisit kognitif, dan kelelahan. Keadaan ini dapat menyebabkan perburukan sistem imunitas dan menurunkan produksi air susu ibu, perlambatan penyembuhan luka, peningkatan resiko mastitis, duktitis, dan infeksi saluran kemih.

Secara umum, kehilangan darah hingga 30% dari volume total darah (sekitar 15 ml/kg berat badan) dapat dikompensasi oleh tubuh. Kehilangan darah sebanyak 1000 ml atau lebih dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas maternal. Perdarahan pasca salin adalah salah satu penyebab terbanyak mortalitas maternal, terutama di negara berkembang. Kematian ibu akibat perdarahan dapat dicegah dengan manajemen aktif kala 3, pemberian agen uterotonika dan resusitasi cairan, intervensi bedah, dan ketersediaan darah untuk transfusi.^{9,10} Jumlah darah yang hilang dapat diperkirakan dengan beberapa metode termasuk pengukuran secara langsung, dan menggunakan selisih nilai hematokrit atau konsentrasi hemoglobin. (Wibowo, Rima and Rabbania, 2021; Estiningtyas *et al.*, 2023)

Kematian ibu di masa nifas menempati urutan kedua setelah masa persalinan, sehingga ibu masih perlu mendapat perhatian setelah melahirkan. Masa nifas masih berisiko mengalami pendarahan atau infeksi yang dapat mengakibatkan kematian ibu. Salah satu masalah yang di hadapi oleh ibu nifas adalah anemia. Anemia pada masa nifas ditandai dengan kadar Hemoglobin (Hb) kurang dari 11 gr%. Kondisi ini tentu akan berdampak buruk bagi ibu nifas jika tidak segera ditangani, seperti terjadinya subinvluasi uteri yang menyebabkan perdarahan post-partum, memudahkan terjadinya infeksi puerperium, pengeluaran ASI berkurang dan mudah terjadi infeksi pada payudara. Faktor penyebab terjadinya anemia pada masa nifas diantaranya adalah kehilangan darah pada saat proses persalinan, dimana persalinan dengan cara sectio cesarea (SC) menyebabkan ibu kehilangan darah lebih banyak dibanding dengan persalinan normal terlebih lagi jika terjadi perdarahan saat persalinan yang membuat ibu kehilangan darah dalam jumlah banyak. (Yuanti and Rusmiati, 2021)

Program pemerintah yang sudah diberlakukan dalam memberikan tablet besi (Fe) kepada ibu hamil masih belum mencapai target nasional dan tingkat kepatuhan yang diharapkan. Kebiasaan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet Fe masih tergolong rendah, sehingga penurunan kejadian anemia di Indonesia belum terlihat. Untuk mencegah anemia pada ibu hamil, dianjurkan pemberian suplemen

tambahan yang mengandung fruktosa dari buah-buahan. Kesehatan dan kondisi gizi yang buruk dapat menghambat kualitas sumber daya manusia. Tingkat kejadian anemia masih tinggi, terutama pada wanita, khususnya remaja perempuan yang sedang dalam masa transisi dan mengalami menstruasi. Anemia disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, kurangnya pengetahuan tentang anemia, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya zat besi. Zat besi dapat dipenuhi dengan mengonsumsi suplemen yang mengandung zat besi, namun konsumsi dalam jumlah berlebihan bisa merusak lapisan usus. Alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan zat besi adalah dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, seperti kacang hijau dan buah naga. Salah satu cara untuk meningkatkan kadar zat besi dalam darah adalah dengan mengonsumsi buah-buahan yang kaya akan zat besi dan vitamin C. Salah satu buah yang mengandung zat besi serta vitamin C cukup tinggi adalah buah naga, dengan kandungan zat besi sekitar 0,16–0,20 mg, serta vitamin B1, vitamin B2, dan vitamin C. (Sulastri *et al.*, 2023)

E. Nyeri Pascapersalinan

Nyeri perineum dan dispareunia merupakan masalah umum postpartum yang mengganggu fungsi seksual normal dan biasanya disebabkan oleh trauma pada perineum, episiotomi, dan alat persalinan. Ruptur perineum yang terjadi saat persalinan juga dapat menyebabkan penurunan kekuatan otot dasar panggul sehingga dapat memengaruhi fungsi seksual ibu postpartum. Nyeri yang dirasakan tiap individu sangat bervariasi dan unik. Pengalaman dan pola nyeri sangat bervariasi baik nulipara maupun multipara dan berhubungan dengan rangsangan nyeri dari pengalaman sebelumnya. Selain paritas, derajat nyeri juga sangat berpengaruh terhadap nyeri. Gangguan rasa nyeri pada ibu postpartum banyak dialami meskipun pada persalinan normal tanpa komplikasi.

Gangguan rasa nyeri pada masa nifas banyak dialami meskipun pada persalinan normal tanpa komplikasi. Hal tersebut menimbulkan tidak nyaman pada ibu, ibu diharapkan dapat mengatasi gangguan ini dan member kenyamanan pada ibu. Gangguan rasa nyeri yang dialami ibu antara lain after pains/keram perut. Hal ini disebabkan kontraksi dalam relaksasi yang terus menerus pada uterus. Banyak terjadi pada multipara. Anjurkan untuk mengosongkan kandung kemih, tidur tengkurap dengan bantal di bawah perut bila analgestik, pembengkakan payudara, nyeri perineum, konstipasi, haemoroid, deuresis.

Adapun potensial terjadi nyeri pada ibu nifas ialah mules-mules sesudah partus, berlangsung 2-3 hari post partum, lebih terasa saat menyusui, timbul bila terdapat sisa-sisa selaput ketuban, sisa plasenta, gumpalan darah dalam cavum

uteri. Gangguan rasa nyeri yang umum pada masa nifas diantaranya sub involusi uterus, pembengkakan payudara, infeksi luka jahitan, masalah menyusui.

Involusi adalah keadaan uterus mengecil oleh kontraksi rahim dimana berat rahim dari 1000 gram saat setelah bersalin, menjadi 40-60 mg pada 6 minggu kemudian. Bila pengecilan ini kurang baik atau terganggu di sebut sub involusi. Faktor penyebab sub involusi, antara lain: sisa plasenta dalam uterus, endometritis, adanya mioma uteri. Pada keadaan sub involusi, pemeriksaan bimanual di temukan uterus lebih besar dan lebih lembek dari seharusnya, fundus masih tinggi, lochea banyak dan berbau, dan tidak jarang terdapat pula perdarahan.

Pada beberapa hari pertama menyusui karena ASI belum keluar dengan lancar, atau terjadi ketika bayi mulai tidur lebih lama di malam hari yang membuat payudara penuh, bengkak, keras dan terasa sakit. Produksi ASI semakin hari akan semakin banyak, hal tersebut membuat penghisapan yang teratur dari bayi sejak lahir, yakni dengan inisiasi menyusui dini.

Nyeri perineum merupakan nyeri yang diakibatkan oleh robekan yang terjadi pada perineum, vagina, serviks, atau uterus dapat terjadi secara spontan maupun akibat tindakan manipulatif pada pertolongan persalinan. Nyeri perineum sebagai manifestasi dari luka bekas penjahitan yang dirasakan pasien akibat ruptur perineum pada kala pengeluaran.

Pada kondisi bengkak atau lecet pada sekitar vagina akan membuat rasa kurang nyaman pada ibu. Keadaan bengkak pada vagina secara perlahan akan kembali ke bentuk semula. Ibu perlu memperhatikan personal hygiene dengan menggunakan pembalut yang tepat. Pada saat ibu mengejan tak jarang menimbulkan hemoroid yang diderita ibu sebelumnya menjadi keluar dari dubur dan terasa nyeri. Tetap menjaga kebersihan area sekitar dubur dan jangan takut untuk buang air besar atau mengejan. (Wijaya, Limbong and Yulianti, 2023)

F. Nyeri Pascapersalinan Akibat Infeksi

Beberapa bakteri dapat menyebabkan infeksi setelah persalinan, Infeksi masa nifas masih merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas ibu. Infeksi alat genital merupakan komplikasi masa nifas. Infeksi yang meluas kesaluran urinari, payudara, dan pasca pembedahan merupakan salah satu penyebab terjadinya AKI tinggi. Gejala umum infeksi berupa suhu badan panas, malaise, denyut nadi cepat. Gejala lokal dapat berupa uterus lembek, kemerahan dan rasa nyeri pada payudara atau adanya disuria.

Infeksi luka jahitan atau luka perineum terjadi akibat robekan jalan lahir baik karena ruptur maupun karena tindakan episiotomi pada waktu melahirkan janin. Ruptur perineum merupakan robekan yang terjadi pada perineum sewaktu

persalinan. Robekan jalan lahir merupakan luka atau robekan jaringan yang tidak teratur.

Jenis luka perineum berupa ruptur dan episiotomi. Ruptur adalah luka pada perineum yang diakibatkan oleh rusaknya jaringan secara alamiah karena proses desakan kepala janin atau bahu pada saat proses persalinan. Banyak rupture biasanya tidak teratur sehingga jaringan yang robek sulit dilakukan penjahitan. Episiotomi adalah Episiotomi adalah suatu tindakan insisi bedah yang dilakukan pada perineum untuk memudahkan kelahiran pada bagian presentase janin, praktik ini harus dibatasi sesuai kebutuhan klinis.

Derajat Perlukaan pada Perineum

1. Derajat I: mukosa vagina, fauchette posterior, kulit perineum.
2. Derajat II: mukosa vagina, fauchette posterior, kulit perineum, otot perineum.
3. Derajat III: mukosa vagina, fauchette posterior, kulit perineum, otot perineum, otot spinter ani eksternal, dinding rectum anterior.

3. Tindakan pada Luka Jahitan Perineum

1. Derajat I: Tidak perlu dijahit jika tidak perdarahan dan posisi luka baik.
2. Derajat II: Jahit dan kemudian luka pada vagina dan kulit perineum ditutup dengan mengikutsertakan jaringan-jaringan di bawahnya.
3. Derajat III dan IV: penolong persalinan merujuk ke fasilitas rujukan.(Wijaya, Limbong and Yulianti, 2023)

G. Asuhan Kebidanan pada Nyeri Pascasalin

Perawatan luka perineum bertujuan untuk mencegah infeksi, meingkatkan rasa nyaman dan mempercepat penyembuhan. Perawatan luka perineum dapat dilakukan dengan cara mencuci daerah genital dengan air dan sabun setiap kali habis BAK/BAB yang mencuci bagian depan, setelah itu daerah anus. Sebelum dan sesudah ibu dianjurkan untuk mencuci tangan. Apabila setelah buang air besar atau buang air kecil perineum dibersihkan secara rutin. Caranya dibersihkan dengan sabun yang lembut minimal sekali sehari. Biasanya ibu merasa takut jahitan akan terlepas serta merasa sakit sehingga perineum tidak dibersihkan. Membersihkan dimulai dari simfisis sampai anal sehingga tidak terjadi infeksi. Ibu dapat diberitahu bagaimana cara mengganti pembalut yang sudah kotor harus diganti minimal 4 kali sehari. Ibu diberitahu tentang jumlah, warna, dan bau lochea sehingga apabila ada kelainan dapat diketahui secara dini. Apabila ibu mempunyai luka episiotomi atau laserasi, sarankan kepada ibu untuk menghindari menyentuh daerah luka.

Ibu nifas pada umumnya merasa nyeri pada waktu awal menyusui. Perasaan sakit ini akan berkurang setelah ASI keluar. Bila posisi mulut bayi dan puting susu

ibu benar, perasaan nyeri akan hilang. Cara menangani yaitu pastikan posisi ibu menyusui sudah benar, mulailah menyusui pada puting susu yang sakit, segera setelah minum, keluarkan sedikit ASI oleskan di puting susu dan biarkan payudara terbuka untuk beberapa waktu sampai puting susu kering.

Nyeri pada masa menyusui bisa terjadi akibat puting susu lecet, mastitis, dan abses payudara. Cara menangani puting susu lecet yaitu bayi harus disusukan terlebih dahulu pada puting yang lecetnya lebih sedikit, menyusui lebih sering dan lebih lama pada payudara yang bengkak untuk melancarkan aliran ASI dan menurunkan tegangan payudara, lalu oleskan ASI setiap sebelum dan sesudah menyusui.

Cara lain yang bisa dilakukan yaitu kompres payudara dengan handuk yang sudah direndam air hangat sebelum menyusui, beri ASI pada payudara yang tak terlalu sakit lebih dulu, hentikan proses menyusui jika payudara terasa terlalu sakit. Jangan menyusui langsung dari puting payudara selama 24 jam, tetapi tetap keluarkan ASI menggunakan pompa lalu berikan ASI dalam botol bayi. Setelah terasa baik, berikan kembali ASI dengan waktu pemberian yang dibatasi tetapi dengan frekuensi sering. Jangan menarik bayi dari payudara secara langsung atau paksa. Buka mulut bayi dengan menarik dagunya menggunakan jari. Jaga kebersihan daerah puting. Ganti bantalan penyerap ASI yang basah sesering mungkin. Oleskan beberapa tetes ASI ke puting payudara setiap selesai menyusui dan biarkan kering di udara untuk mengurangi rasa sakit. Gunakan bra dari bahan yang menyerap, ukuran sesuai, dan ganti bra bila terasa lembab atau basah, bila puting yang lecet terasa sakit berlebihan atau lama, segera konsultasikan kepada dokter.

Cara menangani mastitis yaitu menyusui tetap dilanjutkan. Pertama, bayi disusukan pada payudara yang sakit selama dan sesering mungkin agar payudara kosong, demikian juga lakukan pada payudara normal, beri kompres panas pada payudara, ubah posisi menyusui pada setiap kali menyusui.

Cara menangani abses payudara yaitu perlu antibiotik dosis tinggi dan analgesik. Sementara, susui bayi dengan payudara yang sehat hingga sembuh. Ibu perlu melakukan konsultasi dan merujuk ke rumah sakit. Pengobatan dilakukan dengan memberikan injeksi Methergin setiap hari ditambah dengan Ergometrin peroral. Bila ada sisa plasenta lakukan kuretase. Berikan Antibiotika sebagai pelindung infeksi. Bidan mempunyai peran untuk mendeteksi keadaan ini dan mengambil keputusan untuk merujuk pada fasilitas kesehatan rujukan. (Wijaya, Limbong and Yulianti, 2023)

H. Penutup

Periode pascasalin merupakan masa yang sangat penting dalam kehidupan seorang ibu karena pada masa ini tubuh ibu kembali beradaptasi ke kondisi sebelum kehamilan dan membutuhkan pemulihan yang baik. Salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi adalah anemia setelah melahirkan, yang bisa terjadi karena kehilangan darah selama proses persalinan, kurangnya asupan zat besi, dan pola gizi yang tidak seimbang. Anemia pada ibu setelah melahirkan tidak hanya menyebabkan gejala seperti kelelahan, pusing, dan menghambat proses menyusui dan pemulihan pasca melahirkan. Pemulihan pascapersalinan yang terhambat membuat proses penyembuhan luka perineum maupun luka operasi sukar sembuh. Hambatan dalam penyembuhan luka dapat menyebabkan infeksi sehingga bisa menyebabkan terjadinya nyeri pascasalin yang hebat.

I. Referensi

- Arisani, G. and Seri Wahyuni, Mk. (2024) "Buku Saku Cegah Anemia Dalam kehamilan Cegah Anemia Dalam kehamilan." Palangkaraya: Poltekkes Kemenkes Palangkaraya.
- Estiningtyas, Q. et al. (2023) Ada Apa dengan Anemia. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/370902456>.
- Kementerian Kesehatan RI (2018) Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Anemia pada Rematri dan WUS. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI (2020) Pedoman Teknis Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Jakarta.
- Moya, E. et al. (2022) "Effect of postpartum anaemia on maternal health-related quality of life: a systematic review and meta-analysis," BMC Public Health, 22(1). Available at: <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12710-2>.
- Ririn, T.A. et al. (2023) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Setiani, D.Y. and Yulianti, T.S. (2022) "Scoping review: Faktor Resiko Infeksi Post Partum," Jurnal Ilmu Kesehatan, 10(2).
- Sulastri, M. et al. (2023) "Penatalaksanaan Anemia Pada Ibu Nifas Melalui Terapi Pemberian Buah Naga di Wilayah Kerja Puskesmas Karanganyar," Media Informasi, 19(1), pp. 75–79. Available at: <https://ejurnal2.poltekkestasikmalaya.ac.id/index.php/bmi>.
- Tri Zelharsandy, V., Soleha, M. and Abdurahman Palembang, S. (2023) "Pengaruh Pemberian Tablet Fe terhadap Kejadian Anemia pada Ibu Nifas di PMB Rusmina Banyuasin," Jurnal Kesehatan Abduranham Palembang, 12(1), pp. 1–5.

- Wibowo, N., Rima, I. and Rabbania, H. (2021) *Anemia Defisiensi Besi pada Kehamilan*. Jakarta: UI Publishing.
- Wijaya, W., Limbong, T.O. and Yulianti, D. (2023) *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas*. Pekalongan.
- Yuanti, Y. and Rusmiati, D. (2021) "Kontribusi Jenis Persalinan Terhadap Kejadian Anemia pada Ibu Post-partum," in *Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian Ke-III*.

BAB 4

INISIASI MENYUSU DINI DAN MENYUSUI EKSKLUSIF

A. Pendahuluan

World Health Organization (WHO) menganjurkan bahwa penolong persalinan di ruang bersalin dapat mendukung pemberian ASI segera. Ibu dan bayi diberikan kesempatan untuk melakukan kontak kulit Dimana bayi akan berusaha untuk mencari puting ibunya minimal 30 menit. Ibu dan bayi tidak boleh dipisahkan dan tidak melakukan Tindakan rutin dalam waktu 1 jam yang dikenal dengan istilah inisiasi menyusui dini (IMD).

Bayi menunjukkan kemampuan yang luar biasa Ketika menit-menit pertama IMD. Bayi perlahan-lahan akan merangkak kearah puting susu ibu dan menyusui sendiri Ketika ditengkurapkan di dada ibu. Setiap bayi mempunyai kemampuannya masing-masing untuk mencari payudara ibunya dan menyusui untuk pertama kali.

Manfaat penting yang dapat dirasakan setelah melakukan IMD adalah bayi dapat mendapatkan kolostrum. Kolostrum merupakan ASI yang pertama kali keluar, berwarna kekuning-kuningan dan kental. Kolostrum tinggi akan immunoglobulin A sebagai sumber kekebalan pasif bagi bayi, selain itu bisa menjadi pencakar untuk membersihkan saluran pencernaan bayi.

Air susu ibu adalah makanan tunggal dan terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan tumbuh kembang bayi sampai usia 6 bulan. IMD dapat memunculkan refleks menyusui pada bayi, yang berperan penting dalam pemberian ASI secara eksklusif. Saat melakukan IMD, bayi tidak akan kedinginan. Hal ini disebabkan karena Ketika bayi kedinginan, maka panas tubuh ibu bagian dada akan meningkat 2⁰ C. Namun Ketika bayi kepanasan, secara otomatis suhu dada ibu akan turun sampai 1⁰ C. IMD dapat memberikan motivasi dan mempermudah ibu Ketika menyusui. IMD dapat dilaksanakan pada bayi yang lahir dengan Tindakan seperti Caesar, vakum ekstraksi maupun pada bayi kembar.

ASI merupakan makanan dan minuman pertama untuk bayi. ASI mengandung sumber gizi yang sempurna untuk bayi. Selain itu, ASI mengandung imun alami yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

Tidak ada yang dapat menandingi kualitas ASI, karena ASI merupakan makanan utama bagi bayi. ASI harus diberikan secara eksklusif karena hanya ASI yang dapat diterima system pencernaan bayi. Bayi yang mendapatkan ASI secara

eksklusif akan mengalami pertumbuhan otak yang optimal dan kemampuan berbahasa, motorik serta emosi

ASI merupakan sumber nutrisi yang paling cocok untuk bayi dan sangat diperlukan dalam pembentukan imunitas dini. Setiap komponen berdampak positif bagi Kesehatan manusia, seperti imunitas dini manusia dan pencegahan penyakit.

Menyusui juga bermanfaat bagi ibu yaitu dengan cara membantu Rahim Kembali ke ukuran normal setelah melahirkan, membantu meningkatkan ikatan antara ibu dan bayi, menjarakkan kehamilan serta mengurangi risiko kanker payudara dan ovarium.

B. Pengertian Inisiasi Menyusu Dini

Inisiasi menyusui dini (IMD) adalah proses bayi untuk mulai menyusui setelah lahir, bayi dibiarkan untuk mencari puting susu ibunya. Proses tersebut juga disebut *the breast crawl* atau merangkak mencapai payudara.

Inisiasi menyusui dini (IMD) merupakan salah satu Langkah untuk membantu ibu memulai menyusui bayinya segera setelah lahir dalam waktu kurang dari 1 jam. Salah satu Langkah untuk membantu ibu mewujudkan keberhasilan dalam menyusui dengan perawatan setelah melahirkan maka bidan wajib mendukung ibu untuk menyusui dengan melakukan kontak kulit dini dan inisiasi menyusui dini.

Inisiasi menyusui dini akan mempermudah proses menyusui di bulan-bulan berikutnya. Bayi yang menghisap puting susu akan menyebabkan peningkatan hormon oksitosin yang dilepas ke dalam darah. Hal tersebut dapat membantu proses pelepasan plasenta dan memicu Rahim untuk berkontraksi sehingga dapat mengurangi perdarahan. Inisiasi menyusui dini menjadi salah satu faktor penting pada keberhasilan ASI eksklusif pada ibu.

C. Kebijakan Pemerintah Berkaitan dengan Inisiasi Menyusu Dini

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan menyusui yaitu dilakukan inisiasi menyusui dini (IMD). Hak semua bayi baru lahir adalah untuk mendapatkan ASI salah satunya dengan melakukan IMD. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa IMD dapat mengurangi 22% kematian bayi usia 0-28 hari. Selain itu, IMD dapat menunjang keberhasilan ASI Eksklusif serta memperlama proses menyusui.

Tenaga Kesehatan berperan penting dalam proses terlaksananya IMD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Pasal 9 yang menyebutkan bahwa wajib diberikan kepada Bayi Baru Lahir minimal satu jam dengan meletakkan bayi secara tengkurap di dada ibu sehingga terjadi kontak kulit antara ibu dan bayi.

D. Peran Bidan dalam Mempersiapkan IMD

Diharapkan bidan dapat berperan dalam mempersiapkan proses inisiasi menyusui dini sehingga didapatkan hasil yang sesuai. Persiapan tersebut dimulai dengan memberikan edukasi dari masa kehamilan sampai persalinan. Berikut peran yang dapat dilakukan oleh bidan :

1. Saat Hamil

Ibu hamil siap dari segi fisik maupun psikologis untuk melakukan IMD karena sudah mendapatkan informasi secara detail pada saat hamil. Selain itu, informasi tersebut harus disampaikan kepada suami sehingga dapat memberikan dukungan kepada istrinya.

2. Sebelum Persalinan

- a. Memberikan edukasi tentang IMD pada ibu dan keluarga
- b. Melakukan pengkajian terkait kebersihan diri ibu
- c. Mempersiapkan kain yang lembut dan topi bayi
- d. Membantu ibu untuk meningkatkan rasa percaya diri
- e. Menyiapkan suasana yang nyaman selama proses bersalin
- f. Membantu mobilisasi dan relaksasi untuk mengurangi rasa nyeri pada ibu
- g. Mempersiapkan ibu untuk memilih posisi yang nyaman selama proses persalinan

3. Saat Proses Persalinan

- a. Membantu ibu untuk membuka baju bagian dada dan perut
- b. Menyiapkan kain yang lembut diatas perut ibu
- c. Meletakkan bayi di perut ibu segera setelah lahir
- d. Melakukan penilaian awal pada bayi sembari mengeringkan seluruh tubuh bayi kecuali bagian tangan bayi
- e. Menjepit, memotong dan mengikat tali pusat
- f. Meletakkan bayi diatas dada ibu dengan posisi tengkurap, sehingga terjadi kontak kulit antara ibu dan bayi
- g. Menyelimuti ibu dan bayi, serta memakaikan topi pada bayi
- h. Menganjurkan ibu untuk mengusap secara lembut di punggung bayi
- i. Menganjurkan agar ibu dapat didampingi oleh suami atau keluarga
- j. Memberikan dukungan
- k. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya hingga bayi selesai menyusui dan selama ibu menginginkannya

E. Syarat Melakukan Inisiasi Menyusu Dini

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan inisiasi menyusu dini (Imd), yaitu :

1. Kondisi Ibu Baik/ Sehat Bugar

Dalam keadaan sehat, sadar, selama persalinan tidak ada komplikasi dan tidak terpengaruh pada obat-obatan anastesi.

2. Kondisi Bayi Cukup Bulan

Nilai APGAR sakit dan tidak ada komplikasi apapun

F. Kontra Indikasi Melakukan Inisiasi Menyusu Dini

Berikut beberapa kontraindikasi dalam melakukan inisiasi menyusu dini (IMD) yaitu:

1. Keadaan ibu dan bayi tidak sehat, tidak bugar dan tidak baik
2. Pada menit ke 5 nilai APGAR kurang dari 7
3. Terdapat komplikasi medis pada ibu dan bayi

G. Manfaat Inisiasi Menyusu Dini

Inisiasi menyusu dini (IMD) memiliki banyak manfaat baik untuk bayi maupun untuk ibu. Berikut adalah manfaat yang bisa diperoleh dari melakukan inisiasi menyusu dini (IMD) :

1. Menurunkan risiko kematian akibat hipotermi karena terjadipenyesuaian antara suhu kulit ibu dan bayi
2. Bayi akan lebih tenang dan jarang rewel karena kondisi ini akan membantu pernafasan dan menjaga detak jantung bayi stabil
3. Bayi akan memperoleh kolostrum yang kaya akan zat kekebalan tubuh dan zat lain yang berguna bagi tubuh
4. Meningkatkan keberhasilan pemberian ASI Eksklusif pada bayi yang mendapatkan IMD
5. Sentuhan, kuluman/ emutan dan jilatan pada putting susu akan merangsang pengeluaran hormon oksitosin, manfaat pengeluaran hormon oksitosin yaitu :
 - a. Merangsang kontraksi uterus, membantu pengeluaran plasenta serta mengurangi perdarahan pada ibu bersalin
 - b. Merangsang pengeluaran hormon lain sehingga ibu merasa tenang, cinta pada bayinya, ibu dapat menahan rasa sakit serta muncul kebahagiaan
 - c. Merangsang pengeluaran ASI dari payudara, sehingga hindmilk lebih cepat keluar pada proses menyusui

H. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Inisiasi Menyusu Dini

Melaksanakan inisiasi dini dapat dipengaruhi oleh berbagai fakto, berikut merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terlaksananya inisiasi menyusu dini (IMD):

1. Pengetahuan

Ibu dengan pengetahuanyang kurang maka cenderung semakin jarang melakukan inisiasi menyusu dini (IMD).

2. Sikap

Semakain tinggi Tingkat pengetahuan, maka sikap cenderung akan semakin positif. Perilu seseorang dipengaruhi oleh sikapnya. Ibu dengan sikap yang positif cenderung melakukan inisiasi menyusu dini.

3. Motivasi

Untuk menumbuhkan kesadaran dan kemauan ibu untuk memberikan inisiasi menyusu dini pada bayinya maka ibu perlu diberikan motivasi berupa penyuluhan dari keluarga, Masyarakat serta tenaga Kesehatan.

4. Proses Persalinan

Ibu bersalin tanpa komplikasi serta bayi sehat memiliki kemungkinan keberhasilan dalam inisiasi menyusu dini. Pada ibu dengan operasi bedah secar sering tidak melakukan inisiasi menyusu dini karena ibu merasa ngantuk karena efek anastesi. Sedangkan tenaga Kesehatan di ruang operasi sibuk dengan pekerjaanya. Inisiasi menyusu dini yang ditunda lebih dari satu jam akan berakibat bayi mengalami kesulitan dalam menyusu.

Perempuan yang melahirkan dengan bedah cesar lebih kecil kemungkinannya untuk menyusui dini. Bedah cesar mengakibatkan pemisahan antara ibu dan bayi yang berkepanjangan, perubahan endokrinologis maternal yang disebabkan oleh pembedahan dan kondisi yang menegangkan bagi ibu. Selain itu, ibu juga memerlukan waktu untuk pulih dari efek anastesi.

1. Dukungan Tenaga Kesehatan

Sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif, pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa tenaga kesehatan dan penyeenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusu dini terhadap bayi yang baru dilahirkan kepada ibunya paling singkat selama satu jam. Selain itu, bidan dapat menginformasikan cara melakukan, manfaat serta mendampingi saat pelaksanaan IMD.

2. Dukungan Suami

Seorang suami yang memberikan informasi tentang pentingnya IMD, maka kemungkinan besar ibu mendapatkan dukungan dari suami untuk melakukan IMD. Oleh karena itu, pentingnya membekali suami tentang manfaat menyusui, cara mengatasi masalah menyusui sehingga suami dapat memberikan dukungan kepada istri dan membantu istri mereka untuk melalui kesulitan saat menyusui.

I. Tata Laksana Inisiasi Menyusu Dini Secara Umum

Secara umum berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan Ketika akan melakukan inisiasi menyusui dini :

1. Suami dan keluarga disarankan untuk mendampingi ibu pada saat persalinan
2. Disarankan meminimalkan penggunaan obat kimiawi, disarankan diganti dengan cara non kimiawi
3. Berikan kebebasan pada ibu untuk memilih posisi melahirkan
4. Bersihkan seluruh badan bayi kecuali bagian tangan
5. Posisikan bayi secara tengkurap di dada ibu hingga terjadi kontak kulit antara ibu dan bayi. Selimuti ibu dan bayi serta pakaikan topi pada bayi. Pertahankan posisi tersebut sampai satu jam atau sampai proses menyusui selesai
6. Biarkan bayi untuk mencari puting ibu.
7. Beri dukungan pada Ayah untuk membantu mengenali tanda atau perilaku bayi sebelum menyusui. Proses IMD ini dilakukan selama satu jam walaupun sudah berhasil sebelum satu jam pertama
8. Kontak kulit tersebut dianjurkan untuk tetap diberikan pada ibu yang melahirkan dengan Tindakan
9. Setelah satu jam atau menyusui awal selesai, bayi ditimbang, diukur, dicap dan diberikan vitamin K serta obat tetes mata
10. Lakukan rawat gabung pada ibu dan bayi

J. Langkah-Langkah Inisiasi Menyusu Dini

1. Tahap 1

Tahap pertama juga dapat disebut dengan istirahat siaga. Biasanya bayi akan terdiam pada 30 menit pertama. Apabila selama 30 menit pertama menyusui bayi hanya diam jangan dianggap gagal. Biarkan bayi dalam posisinya selama minimal satu jam.

2. Tahap 2

Pada tahap ini bayi mulai mengeluarkan suara kecap dan menunjukkan Gerakan menghisap padamulutnya. Pada menit ke 30-40 bayi mulai memasukkan tangannya ke mulut.

3. Tahap 3

Pada tahap ke tiga, bayi mengeluarkan air liur. Air liur tersebut jangan dibersihkan. Bau air ketuban pada tangan bayi sama dengan bau puting susu ibu. Jadi bayi akan mencari baunya.

4. Tahap 4

Tahap keempat, bayi mulai menggerakkan kakinya. Kaki bayi akan mulai menghentak untuk membantu bermanuver untuk mencari puting susu. Gerakankaki tersebut dapat membantu proses pengeluaran plasenta.

5. Tahap 5

Tahap ke lima, bayi mulai menjilat kulit ibunya, biarkan bayi melakukan kegiatan tersebut karena bakteri yang masuk lewat mulut akan menjadi bakteri baik.

6. Tahap 6 akan menyusui untuk pertama kalinya.

Tahap ke enam adalah tahap terakhir Dimana bayi sudah dapat menemukan puting susu ibunya. bayi



Gambar 4.1

Langkah-Langkah Inisiasi Menyusu Dini

K. Inisiasi Menyusu Dini pada Operasi Caesar

Inisiasi menyusui dini tidak hanya dilakukan pada ibu dengan persalinan pervaginam saja, namun juga dapat dilaksanakan pada ibu dengan proses persalinan bedah cesar.

1. Selama di ruang operasi atau kamar pemulihan, suami dan keluarga diharapkan untuk menemani ibu
2. Usahakan suhu ruang tidak terlalu dingin
3. Bius epidural lebih disarankan daripada bius total

4. Setelah bayi lahir, bersihkan badan bayi kecuali tangan tanpa menghilangkan vernix. Bagian mulut dan hidung bayi juga dibersihkan
5. Apabila bayi tidak perlu diberikan Tindakan resusitasi, bayi dibedong dan ditengkurapkan di atas dada ibu dengan kulit ibu dan bayi saling bersentuhan. Posisi kaki bayi agak menyerong untuk menghindari luka operasi. Bayi dan ibu diselimuti, serta pakaikan topi pada bayi.
6. Anjurkan ibu untuk menyentuh dan berbicara pada bayi. Biarkan bayi mencari puting ibu
7. Biarkan proses skin to skin berlangsung selama satu jam, apabila proses menyusui awal sudah selesai sebelum satu jam, biarkan bayi tetap di dada ibu sampai minimal satu jam
8. Apabila bayi telah menunjukkan kesiapan untuk minum, bantu ibu mendekatkan puting susu ke bayi tanda memasukkannya ke mulut bayi. Apabila bayi belum bisa menemukan puting ibu dalam kurun waktu satu jam, berikan tambahan waktu tiga puluh menit atau satu jam
9. Apabila operasi sudah selesai, ibu dibersihkan dan bayi tetap ditengkurapkan di dada dan dipeluk oleh ibu. Setelah itu, ibu dipindahkan ke ruang pemulihan dengan bayi tetap di dada ibu
10. Lakukan rawat gabung, yaitu ibu dan bayi dirawat dalam satu ruangan yang sama



Gambar 4.2
Cara IMD Saat Operasi Cesar

L. Inisiasi Menyusu Dini pada Bayi Kembar

Selain pada kelahiran bayi Tunggal, inisiasi dini juga tetap bisa dilaksanakan pada ibu dengan bayi kembar.

1. Pendampingan. Diasarankan kepada suami dan keluarga untuk mendampingi ibu di kamar bersalin

2. Bayi pertama lahir. Setelah bayi pertama lahir, segera keringkan seluruh badan kecuali tangan tanpa menghilangkan vernix. Mulut dan hidung dibersihkan, kemudian ikat tali pusat
3. Bayi tidak memerlukan resusitasi. Apabila bayi tidak perlu dilakukan resusitasi, maka tengkurepkan bayi di dada/perut ibu, sehingga terjadi kontak kulit ibu dan bayi. Mata bayi setinggi puting ibu. Ibu dan bayi diselimuti dan bayi diberikan topi
4. Kelahiran bayi kedua. Apabila ibu merasa ingin melahirkan bayi kedua, maka bayi pertama diberikan kepada ayahnya. Kemudian Ayah harus memeluk anaknya sehingga terjadi kontak kulit antara ayah dan anak seperti saat perawatan metode kanguru. Setelah itu, ditutupi baju ayah.
5. Bayi kedua lahir. Setelah bayi kedua lahir, segera keringkan seluruh badan kecuali tangan tanpa menghilangkan vernix. Mulut dan hidung dibersihkan, kemudian ikat tali pusat
6. Bayi kedua tidak memerlukan resusitasi. Apabila bayi tidak perlu dilakukan resusitasi, maka tengkurepkan bayi di dada/perut ibu, sehingga terjadi kontak kulit ibu dan bayi. Bayi pertama diletakkan Kembali di dada ibu berdampingan dengan bayi kedua. Setelah itu, selimuti ibu dan kedua bayinya. Pakaikan topi padakedua bayinya. Proses selanjutnya sama dengan IMD pada bayi Tunggal.

M. Inisiasi Menyusu Dini yang Kurang Tepat

Seringkali inisiasi menyusui dini dilakukan tidak sesuai dengan aturannya. Berikut beberapa hal yang kurang tepat dilakukan saat melakukan inisiasi menyusui dini :

1. Setelah bayi lahir, diletakkan di atas perut ibu yang dialasi kain
2. Bayi dikeringkan menggunakan kain, kemudian tali pusat dipotong dan diikat
3. Bayi dibungkus/ dibedong dengan selimut untuk mencegah bayi kedinginan
4. Dalam keadaan dibedong, bayi diletakkan selama 10-15 menit diatas perut ibu hingga tenaga kesehatan selesai menjahit perineum
5. Susukan bayi dengan cara memasukkan puting susu ke mulut bayi
6. Setelah itu, bayi ditimbang, diukur, dicap dan diazinkan oleh ayah, disuntik vitamin K dan tetes mata di ruang pemulihan

N. Hambatan Inisiasi Menyusu Dini

Terdapat beberapa hal yang menjadi kepercayaan bagi ibu untuk tidak melakukan inisiasi menyusui dini. Hal tersebut menjadi hambatan Ketika akan dilakukan inisiasi menyusui dini.

1. Bayi Kedinginan (Pendapat ini tidak benar)

Suhu dada seorang ibu yang melahirkan akan naik 1°C . Ketika bayi kepanasan maka suhu dada ibu turun 1°C . apabila bayi kedinginan maka suhu dada ibu naik 2°C . Jadi dada ibu yang baru melahirkan merupakan tempat terbaik bagi bayi baru lahir.

2. Ibu Merasa Lelah untuk Menyusui Anaknya (Pendapat ini tidak benar)

Pada saat melakukan kontak kulit antara ibu dan bayi dan saat menyusui ini akan merangsang pengeluaran hormon oksitosin, akan membantu ibu merasa tenang.

3. Kurang Ketersediaan Tenaga Kesehatan (Hal ini tidak masalah)

Saat bayi diposisikan di atas dada ibu, tenaga Kesehatan akan melanjutkan proses pertolongan persalinan. Bayi akan mencoba mencari puting susu ibu secara mandiri. Ayah atau keluarga dapat membantu menjaga bayi dan memberi dukungan pada ibu.

4. Kamar Bersalin atau Kamar Operasi yang Sibuk (Hal ini tidak masalah)

Ibu dapat dipindahkan ke ruangan pemulihan atau kamar perawatan dengan bayi berada di atas dada ibu. berikan kesempatan kepada bayi untuk melanjutkan mencari puting dan menyusui ini.

5. Ibu yang Harus Dijahit Selama Proses Persalinan (Hal ini tidak masalah)

Proses penjahitan selama persalinan dilakukan di bagian bawah ibu, sedangkan proses IMD dilakukan di bagian dada ibu. Jadi seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak dilakukan IMD.

6. Segera Setelah Lahir Harus Diberikan Vitamin K dan Tetes Mata (Pendapat ini tidak benar)

Pemberian vitamin K dan tetes mata dapat ditunda hingga 1 jam sampai bayi dapat menyusui sendiri tanpa membahayakan bayi.

7. Segera Setelah Lahir Bayi Dibersihkan, Dimandikan, Ditimbang dan Diukur (Pendapat ini tidak benar)

Memandikan bayi dapat ditunda yang berarti akan mencegah bayi kehilangan panas tubuh. Bayi dapat dikeringkan segera setelah lahir. Penimbangan dan pengukuran bayi dapat ditunda sampai bayi dapat menyusui mandiri.

8. Bayi yang Kurang Siaga (Pendapat ini tidak benar)

Pada 1-2 jam pertama kelahiran, bayi dalam keadaan siaga. Setelah itu, bayi akan tidur cukup lama. Apabila bayi mengantuk karena obat yang dikonsumsi ibu, kontak kulit sangat diperlukan karena dapat meningkatkan bonding antara ibu dan bayi.

9. Jumlah Kolostrum Kurang atau Tidak Keluar (Pendapat ini tidak benar)

Kolostrum yang dihasilkan oleh ibu cukup untuk menjadi makanan pertama bagi bayi. Ketika bayi lahir memiliki perbekalan air dan gula yang dapat dimanfaatkan oleh bayi.

10. Kolostrum Berbahaya Bagi Bayi (Pendapat ini tidak benar)

Kolostrum merupakan zat yang diperlukan oleh tumbuh kembang bayi, sebagai imunisasi pertama dan mengurangi kuning pada bayi. Selain itu, kolostrum melindungi dan mematangkan dinding usus yang masih muda.

O. Komplikasi yang Dapat Terjadi Saat Melakukan Inisiasi Menyusu Dini

Komplikasi yang mungkin terjadi Ketika dilakukan IMD adalah *sudden and unexpected post natal collapse* (SUPC). SUPC merupakan kejadian yang tidak diinginkan dan terjadi secara tiba-tiba, dimana terjadi henti nafas pada bayi yang tidak dapat diprediksi. Saat dilakukan kontak kulit dan IMD harus dilakukan pemantauan dan observasi. Sumi dan keluarga harus mendampingi ibu sampai selesai melakukan IMD dan mengawasi kondisi bayi untuk mencegah terjadinya *sudden and unexpected post natal collapse* (SUPC) karena tertutup kulit ibu sehingga menutupi jalan nafas.

P. Pengertian ASI Eksklusif

ASI eksklusif atau pemberian ASI secara eksklusif adalah bayi hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan apapun seperti susu formula, mau, air teh, air putih, pisang, biskuit, bubur nasi dan tim.

Rekomendasi dari WHO menyebutkan bahwa bayi mendapatkan ASI secara eksklusif sampai usia 6 bulan. Makanan padat mulai diberikan pada usia 6 bulan seperti buah dan sayuran yang dihaluskan untuk mendampingi ASI sampai anak berusia 2 tahun.

1. Segera setelah lahir, dalam waktu satu jam pertama harus segera menyusui bayinya
2. Menyusui sesuai keinginan bayi baik di pagi atau malam hari yang sering disebut "on demand"
3. Dalam proses pemberian ASI disarankan untuk menghindari botol atau dot

Q. Manfaat ASI Eksklusif

ASI eksklusif memiliki banyak manfaat baik bagi bayi maupun bagi ibu. Manfaat ASI bagi bayi adalah ASI dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi sehingga mampu mencegah bayi untuk terserang penyakit. Kandungan

kolostrum pada ASI dapat melindungi bayi dari infeksi. Selain itu pemberian ASI dapat mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Manfaat pemberian ASI pada ibu adalah dapat meningkatkan binding antara ibu dan bayi. Selain itu juga dapat mengurangi trauma persalinan dan mencegah dari kanker payudara.

R. Peraturan Tentang ASI Eksklusif

Kesakitan dan kematian bayi salah satunya dapat dicegah dengan pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan, kemudian pemberian ASI dapat diteruskan sampai anak berusia 2 tahun. Pemberian ASI eksklusif harus mendapatkan dukungan dari tenaga Kesehatan.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Anak RI No. 03 Tahun 2010 tentang penerapan sepuluh Langkah menuju keberhasilan menyusui, dibuat untuk melindungi, mempromosikan dan mendukung pemberian ASI. Peraturan tersebut sebagai dasar bagi rumah sakit sayung bayi, dan sarana pelayanan Kesehatan yang dinyatakan sebagai sayung bayi untuk melaksanakan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui.

Selain itu pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yaitu PP No. 33 Tahun 2012 membahas tentang pemberian ASI eksklusif. Peraturan tersebut sebagai bukti konsistensi pemerintah dalam menjamin pemberian ASI pada bayi.

Ada banyak sekali manfaat ASI eksklusif, namun ibu mudah putus asa sehingga tidak memberikan ASI Ketika terdapat permasalahan. Dukungan, perlindungan dan pemenuhan ASI eksklusif pada bayi dan ibu menyusui dari berbagai pihak. Dukungan pemberian ASI eksklusif pada ibu yang bekerja tertuang pada Permenkes No. 15 Tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI.

S. Pentingnya ASI Eksklusif bagi Pertumbuhan dan Perkembangan Anak

Golden age adalah masa dimana pertumbuhan dan perkembangan anak dapat tumbuh dengan optimal. *Golden age* terjadi pada lima tahun pertama anak. Selama masa golden age, asupan gizi yang optimal dapat menghasilkan tumbuh kembang secara optimal dan dapat menurunkan risiko anak untuk menderita penyakit kronis. ASI eksklusif merupakan salah satu aspek yang dapat mendukung periode golden age pada anak.

Berdasarkan penelitian, anak yang mendapatkan ASI eksklusif dapat tumbuh dengan optimal. Hal ini terjadi karena ASI mengandung DHA dan AA yang merupakan asam lemak rantai Panjang tak jenuh yang berasal dari membrane lipid dan mempengaruhi pertumbuhan bayi. Selain itu, anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif berpeluang lebih tinggi untuk mengalami stunting. Anak yang tidak

mendapatkan ASI eksklusif memiliki kekebalan tubuh yang lebih rentan dan sehingga energi yang seharusnya digunakan untuk proses pertumbuhan justru digunakan untuk melawan penyakit.

ASI merupakan suatu system yang sangat kompleks yang terdiri dari berbagai komponen bioaktif. ASI merupakan sumber nutrisi yang paling cocok untuk bayi dan sangat diperlukan dalam pembentukan imunitas dini. Setiap komponen berdampak positif bagi Kesehatan manusia, seperti imunitas dini manusia dan pencegahan penyakit.

Pemberian ASI secara eksklusif dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang seorang anak, sehingga tercipta ikatan antara ibu dan anak. Pemenuhan kebutuhan kasih sayang tersebut akan berpengaruh di kemudian hari, menstimulus otak, dan menumbuhkan rasa percaya diri seorang anak.

Pemberian ASI eksklusif dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan usianya. Anak yang mendapatkan ASI eksklusif akan mengalami perkembangan yang lebih baik dibandingkan pada anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Anak yang mendapatkan ASI eksklusif jarang mengalami keterlambatan berbicara dan keterlambatan motorik. Selain itu, pemberian ASI secara eksklusif berperan pada Tingkat kecerdasan anak. Anak yang mendapatkan ASI eksklusif cenderung mempunyai IQ yang lebih tinggi.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa pemberian ASI secara eksklusif berkaitan dengan peningkatan perkembangan otak dan fungsi kognitif pada bayi dibandingkan dengan pemberian susu formula. Bayi yang mendapatkan ASI secara eksklusif menunjukkan perkembangan saraf yang lebih kuat serta kinerja kognitif yang baik. Temuan tersebut menggarisbawahi bahwa pemberian ASI akan mendukung perkembangan saraf otak secara optimal.

T. Peran Tenaga Kesehatan dalam Meningkatkan Pemberian ASI Eksklusif

Tenaga Kesehatan memiliki peranan penting pada keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Peran dari tenaga Kesehatan dapat dimulai dari ibu hamil sampai setelah ibu melahirkan.

1. Pada Kehamilan

- a. Menjelaskan tentang perubahan fisik, yaitu pembesaran pada payudara, areola berwarna kehitaman dan puting susu yang tegak.
- b. Menjelaskan peningkatan hormon yang mempengaruhi selama masa laktasi yaitu hormon prolactin dan oksitosin
- c. Menjelaskan kepada suami dan keluarga tentang ASI eksklusif
- d. Menjelaskan keuntungan pemberian ASI
- e. Menjelaskan kepada ibu dan suami tentang persiapan menyusui

- f. Menjelaskan tentang komposisi ASI
 - g. Mengajarkan cara menjaga kebersihan diri, terutama yang berkaitan dengan proses laktasi
 - h. Menjelaskan tentang inisiasi menyusui dini
 - i. Menjelaskan tentang pemeriksaan kehamilan secara rutin
 - j. Menjelaskan tentang kebutuhan untuk persiapan menyusui seperti pakaian menyusui, tempat penyimpanan dan pemerahan ASI
2. Saat Segera Setelah Bayi Lahir
 - a. Melakukan inisiasi menyusui dini (IMD)
 - b. Melakukan rawat gabung
 3. Masa Nifas
 - a. Tidak memberikan makanan dan minuman selain ASI pada bayi
 - b. Tidak memberikan dot atau empeng kepada bayi
 - c. Mengajarkan ibu cara menyusui yang benar
 - d. Mengajarkan ibu cara pemerahan ASI
 - e. Membantu ibu dalam mengatasi permasalahan tentang menyusui
 - f. Menjelaskan tentang kebutuhan nutrisi pada ibu menyusui
 - g. Menjelaskan tentang bagaimana produksi ASI dapat meningkat dan menurun
 - h. Menjelaskan frekuensi dan durasi menyusui
 - i. Menjelaskan tentang tanda kecukupan ASI pada bayi
 - j. Mengajarkan kepada ibu dan keluarga tentang pijat oksitosin
 - k. Menjelaskan cara penyimpanan dan pemberian ASI pada ibu bekerja

U. Penyebab Kegagalan ASI Eksklusif

Tidak semua bayi mendapatkan asi eksklusif, berikut beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab kegagalan pemberian ASI eksklusif :

1. Anggapan ASI tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ASI
2. Anggapan susu formula lebih baik daripada ASI
3. Kekhawatiran ibu terhadap kenaikan berat badannya
4. Ibu bekerja
5. Cara menyusui yang salah
6. Tidak dilakukan IMD Ketika bayi baru lahir
7. Kurangnya dukungan dari tenaga Kesehatan
8. Rendahnya pengetahuan ibu tentang manfaat ASI dan proses menyusui
9. Persiapan fisik dan psikologi ibu yang kurang
10. Dukungan yang kurang dari suami dan keluarga
11. Dukungan yang kurang dari tempat bekerja selama menyusui
12. Mitos yang merugikan tentang ASI

V. Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi. Kandungan gizi yang dimiliki ASI adalah paling ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Perkembangan otak dimulai selama kehamilan dan mencapai kematangan sekitar usia tiga tahun. Nutrisi yang tepat sangat penting untuk perkembangan otak yang sehat di awal kehidupan dan dapat memiliki efek jangka Panjang pada Kesehatan kognitif dan mental.

WHO merekomendasikan agar bayi disusui secara eksklusif yaitu hanya mendapatkan ASI saja tanpa tambahan apapun sampai usia 6 bulan. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi pemberian ASI secara eksklusif salah satunya adalah inisiasi menyusui dini (IMD). Berdasarkan hasil penelitian, IMD menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif, namun bukan satu-satunya faktor karena ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi. Sehingga diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas IMD untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif.

Penelitian lain juga menjelaskan bahwa praktik inisiasi menyusui dini memiliki pengaruh yang kuat terhadap pemberian ASI eksklusif. Sikap seorang ibu yang telah melakukan inisiasi menyusui dini berkaitan dengan keinginan ibu untuk menyusui. Ibu yang melakukan inisiasi menyusui dini memiliki kemungkinan untuk dapat memberikan ASI secara eksklusif tiga kali lebih besar daripada ibu yang tidak melakukan IMD.

Tenaga Kesehatan menjadi salah satu unsur untuk percepatan Pembangunan pelayanan Kesehatan. Peran petugas Kesehatan menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan cakupan IMD dan secara tidak langsung menjadi salah satu faktor untuk mendukung pemberian ASI eksklusif.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Pasal 9 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tenaga Kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusui dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama satu jam. (Pemerintah Republik Indonesia, 2012) Dukungan tenaga Kesehatan sangat besar perannya dalam membantu pelaksanaan IMD. Komitmen tinggi dan sikap positif dari tenaga Kesehatan disertai dengan SOP tentang IMD adalah salah satu Upaya untuk mensukseskan pemberian ASI yang dimulai dengan pelaksanaan IMD.

Inisiasi menyusui dini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti Riwayat persalinan, kemampuan tenaga Kesehatan dalam menolong persalinan, dukungan tenaga Kesehatan, dll.

W. Penutup

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif merupakan dua hal yang saling berkaitan dan berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang optimal bayi sejak awal kehidupan. IMD menjadi langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan pemberian ASI eksklusif, karena melalui kontak kulit antara ibu dan bayi, terbentuk ikatan emosional yang kuat serta merangsang keluarnya hormon oksitosin yang berperan dalam proses laktasi.

Pelaksanaan IMD dan keberhasilan ASI eksklusif tidak hanya bergantung pada ibu, tetapi juga memerlukan dukungan dari tenaga kesehatan, keluarga, serta lingkungan kerja. Dukungan kebijakan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 dan berbagai peraturan turunannya menjadi landasan penting dalam menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI sejak lahir.

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat IMD dan ASI eksklusif harus terus digalakkan melalui edukasi berkelanjutan, terutama oleh tenaga kesehatan di lini terdepan. Dengan pelaksanaan IMD yang tepat dan dukungan menyeluruh terhadap pemberian ASI eksklusif, diharapkan angka kesakitan dan kematian bayi dapat ditekan serta tercipta generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan.

X. DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, N. (2020). Dukungan Tenaga Kesehatan Terhadap Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini. *Jurnal Kebidanan*, 6(4), 421–426. <https://doi.org/10.33024/jkm.v6i4.3349>
- Astuti, A., Judistiani, T. D., Rahmiati, L., & Susanti, A. I. (2015). *Asuhan Kebidanan Nifas & Menyusui*. Erlangga.
- Chade, E. S., Júnior, O. R., Souza, N. M. P., da Silva, A. J. de O. K., Ferreira, L. M., Reolon, J. B., Bonini, J. S., Rego, F. G. de M., & Sari, M. H. M. (2024). The Influence of Nutritional Status on Brain Development: Benefits of Exclusive Breastfeeding. *Pediatric Reports*, 16(3), 724–735. <https://doi.org/10.3390/pediatric16030061>
- Gayatri, M. (2021). Exclusive Breastfeeding Practice in Indonesia: A Population-Based Study. *Korean Journal of Family Medicine*, 42(5), 395–402. <https://doi.org/10.4082/kjfm.20.0131>
- Gayatri, M., & Dasvarma, G. L. (2020). Predictors of early initiation of breastfeeding in Indonesia: A population-based crosssectional survey. *PLoS ONE*, 15(9 September). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239446>
- Gunarmi, Merida, Y., Fatmawati, R., Sari, T. P., Murniati, & Widiyanti, R. (2023). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas dan Menyusui*. NEM.

- Idayanti, T., Herlina, Dewi, V. N. L., Suhaid, D. N., Arifi, Y., Ringgi, M. S. I. N., Widowati, L. P., Wardani, D. W. K. K., Rosdiana, Pratiwi, A. I., & Suhartini. (2023). *Pentingnya ASI Eksklusif dan MP-ASI di Masa Pertumbuhan Golden Period*. Media Sains Indonesia.
- Nidaa, I., & Hadi, E. N. (2022). Inisiasi menyusui dini (IMD) sebagai upaya awal pemberian ASI eksklusif: scoping review. *Jurnal Riset Kebidanan Indonesia*, 6(2), 58–67. <https://doi.org/10.32536/jrki.v6i2.221>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012*.
- Roesli, U. (2008). *Inisiasi Menyusui Dini Plus ASI Eksklusif*. Pustaka Bunda.
- Sabrida, O., Susanti, D., Winanda, M., Yusuf, N., Rahmadhan, N., Marissa, N., Septivera, Y., Ramli, N., Phonna, S. S., Ariani, P., ZB, C. R., Aslinar, Fajri, N., & Ardilla, A. (2023). *Evidence Based: Kupas Tuntas ASI dan Menyusui*. Media Sains Indonesia.
- Sudargo, T., & Kusmayanti, N. A. (2023). *Pemberian ASI Eksklusif*. Gadjah Mada University Press.
- Yi, D. Y., & Kim, S. Y. (2021). Human breast milk composition and function in human health: From nutritional components to microbiome and micrnas. *Nutrients*, 13(9). <https://doi.org/10.3390/nu13093094>

BAB 5

MASALAH LAKTASI DAN SOLUSI BERBASIS BUKTI

A. Pendahuluan

ASI (Air Susu Ibu) merupakan sumber nutrisi terbaik bagi bayi, menyediakan zat gizi, antibodi, serta faktor pertumbuhan yang tidak dapat digantikan oleh susu formula. WHO dan UNICEF (2023) merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi dan dilanjutkan hingga usia dua tahun dengan makanan pendamping yang sesuai.

Di Indonesia, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menunjukkan bahwa cakupan pemberian ASI eksklusif meningkat menjadi 72,4%. Walaupun angka ini menunjukkan kemajuan, masih terdapat tantangan dalam mempertahankan pemberian ASI hingga usia dua tahun. Sebagian besar kendala disebabkan oleh masalah laktasi, kurangnya dukungan keluarga, serta informasi yang tidak akurat mengenai proses menyusui.

Laktasi merupakan proses fisiologis yang melibatkan kerja sama kompleks antara sistem hormon, refleks tubuh, dan kondisi psikologis ibu. Hormon prolaktin dan oksitosin memiliki peran utama dalam produksi dan pengeluaran ASI. Namun, berbagai faktor seperti stres, kelelahan, nyeri payudara, atau teknik menyusui yang kurang tepat dapat menghambat proses ini.

Masalah laktasi dapat berdampak luas, tidak hanya pada keberhasilan menyusui, tetapi juga pada kesehatan mental ibu dan tumbuh kembang bayi. Dalam praktik kebidanan, pendekatan berbasis bukti (*evidence-based practice*) menjadi penting untuk memberikan intervensi yang efektif dan aman. Misalnya, WHO (2023) menekankan pentingnya *early initiation of breastfeeding* (Inisiasi Menyusui Dini) dan *rooming-in* untuk mendukung refleks laktasi alami.

Selain faktor biologis, aspek sosial budaya turut memengaruhi keberhasilan laktasi. Norma, mitos, serta tekanan lingkungan sering kali membuat ibu merasa ragu terhadap kemampuannya sendiri. Karena itu, dukungan dari tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang ramah menyusui.

Bab ini akan membahas secara rinci berbagai masalah umum dalam laktasi, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta solusi berbasis bukti ilmiah yang dapat diterapkan oleh tenaga kesehatan dan masyarakat. Harapannya, pembaca dapat memahami bahwa menyusui bukan sekadar tanggung jawab ibu, melainkan tanggung jawab bersama dalam membangun generasi yang sehat dan berkualitas.

B. Konsep Dasar Laktasi

Laktasi merupakan proses fisiologis kompleks yang mencakup produksi, sekresi, dan pengeluaran Air Susu Ibu (ASI). Proses ini melibatkan interaksi antara sistem endokrin, refleks neurohormonal, serta kondisi emosional ibu. Dalam literatur medis, laktasi dianggap sebagai hasil sinergi antara hormon, rangsangan sensorik dari puting, serta faktor psikologis yang mendukung terciptanya hubungan erat antara ibu dan bayi.

1. Tahapan Laktasi

Proses laktasi dibagi menjadi tiga fase utama:

- Laktogenesis I terjadi pada akhir masa kehamilan, ketika hormon prolaktin mulai merangsang sel-sel alveoli di payudara untuk memproduksi kolostrum.
- Laktogenesis II dimulai sekitar 30–72 jam setelah persalinan, ditandai dengan peningkatan volume ASI akibat penurunan kadar progesteron dan peningkatan prolaktin.
- Laktogenesis III adalah fase pemeliharaan produksi ASI, di mana frekuensi dan efektivitas bayi menyusu menjadi faktor utama keberlanjutan produksi susu (Geddes & Perrella, 2019).

2. Peran Hormon dalam Laktasi

Dua hormon utama berperan penting dalam laktasi, yaitu prolaktin dan oksitosin.

- Prolaktin disekresikan oleh kelenjar hipofisis anterior dan berfungsi menstimulasi produksi ASI.
- Oksitosin, yang dilepaskan oleh hipofisis posterior, memicu kontraksi sel mioepitelial di sekitar alveoli payudara sehingga ASI terdorong keluar melalui ductus laktiferus dikenal sebagai *let-down reflex*.

Keseimbangan kedua hormon ini sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional ibu. Stres dan kelelahan terbukti dapat menurunkan refleks oksitosin, sehingga menghambat pengeluaran ASI (Lawrence & Lawrence, 2021).

1. Faktor yang Memengaruhi Produksi ASI

Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI meliputi:

- Frekuensi Menyusui: Semakin sering bayi menyusu, semakin tinggi produksi ASI karena stimulasi refleks prolaktin meningkat.
- Nutrisi dan Hidrasi Ibu: Asupan kalori, cairan, dan protein yang cukup penting untuk mendukung produksi susu.
- Kondisi Psikologis: Dukungan emosional dari keluarga dan tenaga kesehatan dapat meningkatkan refleks pengeluaran ASI.

- d. Teknik Menyusui: Posisi dan perlekatan yang benar membantu pengosongan payudara optimal, yang merangsang produksi susu lebih lanjut (Riordan & Wambach, 2019).

2. Komposisi ASI

ASI mengandung kombinasi unik zat gizi dan faktor imunologis yang tidak dapat ditiru oleh susu formula.

- a. Kolostrum mengandung protein tinggi, terutama imunoglobulin A (IgA), yang berfungsi melindungi bayi dari infeksi saluran pencernaan.
- b. ASI matang memiliki rasio lemak, karbohidrat, dan protein yang ideal untuk kebutuhan tumbuh kembang bayi. Selain itu, ASI juga mengandung faktor pertumbuhan, hormon, dan enzim yang berperan dalam perkembangan sistem imun dan saraf bayi (Ballard & Morrow, 2013).

3. Refleks Laktasi

Dua refleks utama mengatur proses laktasi:

- a. Refleks prolaktin: Terjadi saat bayi menyusui, menstimulasi produksi ASI baru.
- b. Refleks let-down: Digerakkan oleh oksitosin, memungkinkan ASI keluar dari payudara.

Refleks ini dapat terganggu bila ibu mengalami stres, rasa sakit, atau kecemasan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang tenang, nyaman, dan mendukung bagi ibu menyusui.

C. Masalah Umum Laktasi

Setiap ibu memiliki pengalaman menyusui yang berbeda. Ada yang berjalan lancar sejak awal, namun banyak juga yang menghadapi berbagai kendala. Masalah-masalah laktasi umumnya terjadi pada minggu pertama pascapersalinan, saat proses adaptasi fisiologis dan psikologis masih berlangsung. Pengetahuan yang baik tentang penyebab, gejala, dan cara penanganan setiap masalah menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan menyusui. Masalah laktasi dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek utama:

- 1. Masalah produksi ASI (kuantitas dan kualitas).
- 2. Masalah anatomi dan nyeri pada payudara.
- 3. Masalah psikologis dan dukungan sosial.

Berikut uraian masing-masing aspek beserta solusi berbasis bukti ilmiah.

1. Produksi ASI Rendah (*Hipogalaktia*)

Produksi ASI rendah merupakan keluhan paling umum di minggu-minggu pertama setelah melahirkan. Sebagian besar kasus sebenarnya bukan disebabkan oleh masalah fisiologis, melainkan oleh persepsi ibu yang salah terhadap jumlah

ASI yang cukup. Menurut Geddes & Perrella (2019), penyebab *hipogalaktia* dibedakan menjadi dua:

- a. Primer (akibat gangguan hormonal, kelainan payudara, atau komplikasi medis).
- b. Sekunder (akibat frekuensi menyusui tidak cukup, bayi tidak mengisap efektif, atau stres ibu).

Pendekatan berbasis bukti yang disarankan:

- a. Menyusui sesering mungkin tanpa jadwal kaku (*on-demand feeding*).
- b. *Skin-to-skin contact* segera setelah lahir untuk merangsang refleks prolaktin.
- c. Penggunaan teknik *power pumping* jika diperlukan, dengan pengawasan tenaga kesehatan.

2. Bendungan ASI (*Engorgement*)

Bendungan ASI terjadi ketika payudara terisi penuh karena pengeluaran tidak seimbang dengan produksi. Kondisi ini menyebabkan pembengkakan, nyeri, bahkan demam ringan. WHO (2023) menegaskan bahwa penyebab utama bendungan adalah pemberian ASI yang tertunda, penggunaan botol susu terlalu dini, atau posisi menyusui yang salah.

Solusi berbasis bukti:

- a. Kompres hangat sebelum menyusui dan kompres dingin setelahnya.
- b. Pastikan posisi dan pelekatan mulut bayi benar.
- c. Menyusui secara bergantian di kedua payudara

3. Puting Lecet (*Cracked Nipples*)

Puting lecet sering kali menjadi alasan ibu menghentikan pemberian ASI. Luka ini dapat terjadi akibat posisi menyusui yang tidak tepat atau infeksi jamur (*Candida albicans*). Menurut penelitian oleh Lawrence & Lawrence (2022), koreksi teknik menyusui merupakan langkah utama. ASI sendiri dapat digunakan sebagai "obat alami" karena mengandung zat antibakteri dan penyembuh luka.

Pendekatan berbasis bukti:

- a. Perbaiki posisi dan pelekatan bayi.
- b. Hindari mencuci puting dengan sabun keras.
- c. Gunakan beberapa tetes ASI untuk melumasi puting setelah menyusui.

Jika ada tanda infeksi, lakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan

4. Mastitis dan Abses Payudara

Mastitis adalah peradangan jaringan payudara yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri *Staphylococcus aureus*. Gejalanya termasuk nyeri, kemerahan, dan demam. Jika tidak tertangani, dapat berkembang menjadi abses. Penanganan modern tidak lagi menganjurkan penghentian menyusui. Berdasarkan pedoman

Academy of Breastfeeding Medicine (ABM, 2022), menyusui justru membantu mengosongkan payudara dan mempercepat penyembuhan.

Solusi berbasis bukti:

- a. Teruskan menyusui dengan posisi yang tidak menekan bagian nyeri.
- b. Berikan antibiotik yang sesuai jika infeksi bakteri terkonfirmasi.
- c. Kompres hangat dan istirahat cukup.

5. Refleks Let-Down Terhambat (Milk Ejection Reflex Delay)

Refleks *let-down* yang tidak lancar sering disebabkan oleh stres atau kecemasan. Hormon oksitosin yang berperan dalam pengeluaran ASI sangat sensitif terhadap kondisi emosional ibu. Dukungan emosional dan lingkungan yang nyaman terbukti meningkatkan keberhasilan menyusui. Studi oleh Ueda et al. (2018) menunjukkan bahwa pijatan lembut, musik relaksasi, dan aroma terapi tertentu dapat membantu meningkatkan refleks oksitosin.

6. Faktor Psikologis dan Sosial

Masalah psikologis seperti *baby blues*, kecemasan, atau kurangnya dukungan keluarga dapat memengaruhi produksi dan pengeluaran ASI. Lingkungan yang tidak mendukung sering kali menyebabkan ibu berhenti menyusui lebih awal.

Intervensi yang efektif meliputi:

- a. Dukungan konseling laktasi.
- b. Pendampingan oleh tenaga kesehatan terlatih.
- c. Edukasi keluarga dan suami untuk turut berperan aktif.

Tabel 5.1.
Masalah Umum Laktasi dan Solusi Berbasis Bukti

Masalah Laktasi	Penyebab Utama	Solusi Berbasis Bukti (Evidence-Based)	Sumber Ilmiah
Produksi ASI rendah	Frekuensi menyusui tidak cukup, stres	Menyusui on-demand, kontak kulit-ke-kulit, <i>power pumping</i>	Geddes & Perrella (2019)
Bendungan ASI	Pengosongan payudara tidak optimal	Kompres hangat/dingin, posisi menyusui benar	WHO (2023)
Puting lecet	Posisi salah, infeksi jamur	Koreksi posisi, olesi ASI, perawatan kebersihan	Lawrence & Lawrence (2022)
Mastitis	Infeksi bakteri, saluran tersumbat	Lanjut menyusui, antibiotik sesuai indikasi	ABM (2022)

Masalah Laktasi	Penyebab Utama	Solusi Berbasis Bukti (Evidence-Based)	Sumber Ilmiah
Refleks let-down terhambat	Stres, kecemasan	Relaksasi, pijat oksitosin, lingkungan nyaman	Ueda et al. (2018)
Faktor sosial	Kurangnya dukungan	Edukasi keluarga, konseling laktasi	UNICEF (2023)

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Laktasi

Keberhasilan menyusui tidak hanya bergantung pada kemampuan fisiologis tubuh ibu, tetapi juga pada banyak faktor yang saling berinteraksi. Menurut Victora et al. (2016) dan WHO (2023), faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga dimensi besar, yaitu: biologis, psikologis, dan sosial-kultural. Ketiganya membentuk satu kesatuan sistem yang menentukan seberapa optimal proses produksi dan pengeluaran ASI berlangsung.

1. Faktor Biologis

Faktor biologis meliputi kondisi fisik, hormonal, dan anatomi payudara yang memengaruhi proses produksi ASI. Beberapa aspek penting di antaranya:

a. Hormon prolaktin dan oksitosin.

Prolaktin berfungsi merangsang produksi ASI di alveoli payudara, sementara oksitosin berperan dalam refleks pengeluaran ASI. Produksi kedua hormon ini sangat dipengaruhi oleh frekuensi dan efektivitas hisapan bayi. Semakin sering bayi menyusui, semakin tinggi kadar prolaktin dan oksitosin yang dilepaskan (Geddes & Perrella, 2019).

b. Kesehatan ibu.

Kondisi medis seperti anemia, diabetes, gangguan tiroid, atau infeksi dapat menghambat laktasi. Asupan gizi seimbang, hidrasi cukup, dan istirahat menjadi prasyarat utama untuk mempertahankan produksi ASI yang optimal (Lawrence & Lawrence, 2022).

c. Kelahiran prematur dan kondisi bayi.

Bayi prematur sering memiliki kekuatan hisap yang lemah sehingga tidak mampu menstimulasi refleks laktasi secara optimal. Pendampingan dengan teknik kangaroo mother care dan pemberian ASI perah menjadi solusi efektif berbasis bukti (UNICEF, 2023).

2. Faktor Psikologis

Kondisi emosional ibu berperan penting dalam kelancaran menyusui. Stres, kecemasan, dan kelelahan dapat menekan pelepasan oksitosin, yang berakibat pada hambatan refleks pengeluaran ASI (*let-down reflex*). Ueda et al. (2018)

menemukan bahwa ibu yang mendapat dukungan emosional dan lingkungan positif memiliki kadar oksitosin plasma yang lebih tinggi dan refleks *let-down* yang lebih cepat.

Beberapa strategi psikologis yang terbukti membantu:

- a. Relaksasi dan pernapasan dalam saat menyusui.
- b. Dukungan verbal dan emosional dari pasangan.
- c. Konseling pascapersalinan oleh tenaga kesehatan.

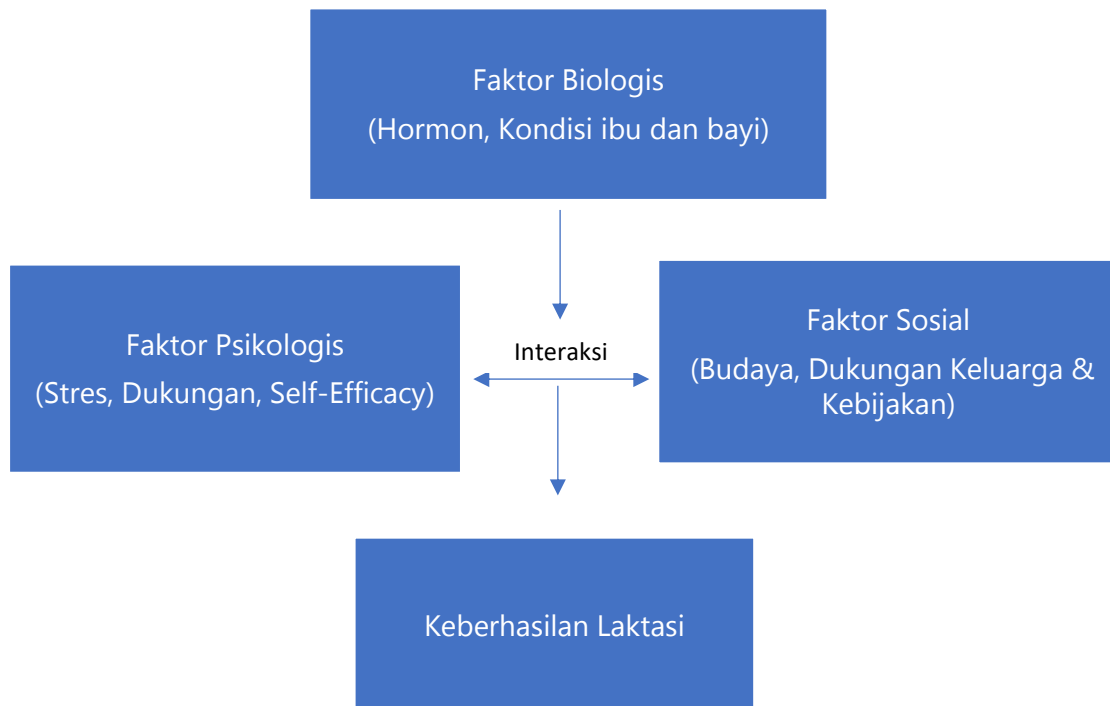
Selain itu, kepercayaan diri ibu terhadap kemampuannya menyusui yang dikenal sebagai *breastfeeding self-efficacy* terbukti menjadi prediktor penting keberhasilan laktasi. Ibu yang merasa yakin akan kemampuannya lebih konsisten dalam memberikan ASI eksklusif (Dennis, 2017).

3. Faktor Sosial dan Kultural

Kebiasaan, norma, dan nilai budaya memiliki pengaruh besar terhadap pola menyusui. Di beberapa daerah, misalnya, masih terdapat mitos bahwa ASI pertama (*kolostrum*) tidak baik untuk bayi, sehingga pemberian ASI sering ditunda. Padahal kolostrum kaya antibodi dan protein pelindung (WHO, 2023).

Selain itu, dukungan keluarga terutama pasangan menjadi kunci. Studi oleh Susiloretni et al. (2020) di Indonesia menunjukkan bahwa ibu yang mendapat dukungan aktif dari suami memiliki peluang 1,8 kali lebih besar untuk berhasil menyusui eksklusif dibandingkan yang tidak mendapat dukungan.

Kebijakan sosial seperti cuti melahirkan, ruang laktasi di tempat kerja, dan dukungan komunitas ibu menyusui juga sangat memengaruhi keberhasilan laktasi. Lingkungan kerja yang tidak ramah terhadap ibu menyusui sering kali menjadi penghalang utama bagi keberlanjutan pemberian ASI.



Gambar 5.1.
Diagram Keberhasilan Laktasi

Diagram ini menggambarkan bahwa keberhasilan menyusui merupakan hasil dari interaksi dinamis antara faktor biologis, psikologis, dan sosial. Semua faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mendukung untuk menciptakan kondisi optimal bagi ibu dan bayi.

Laktasi yang berhasil tidak hanya bergantung pada tubuh ibu, tetapi juga kondisi emosional dan dukungan lingkungan. Pendekatan holistik berbasis bukti yang menggabungkan aspek medis, psikologis, dan sosial diperlukan untuk memastikan setiap ibu mendapatkan kesempatan terbaik untuk menyusui dengan bahagia dan berkelanjutan.

E. Dukungan Laktasi Berbasis Bukti (Intervensi Klinis dan Komunitas)

Keberhasilan menyusui tidak hanya ditentukan oleh kemauan ibu, tetapi juga oleh sistem dukungan yang mengelilinginya. Pendekatan berbasis bukti menekankan pentingnya kolaborasi antara tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ibu menyusui.

Berdasarkan tinjauan sistematis oleh Rollins et al. (2016) dan pedoman WHO (2023), dukungan laktasi terbukti paling efektif bila mencakup tiga level:

1. Dukungan klinis oleh tenaga kesehatan.
2. Dukungan psikososial oleh keluarga dan komunitas.
3. Dukungan kebijakan dan fasilitas public

1. Dukungan Klinis

Dukungan klinis melibatkan bantuan langsung dari tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, atau konselor laktasi. Pendekatan ini berfokus pada deteksi dini masalah, edukasi menyusui, serta pendampingan pascapersalinan.

Praktik klinis berbasis bukti meliputi:

a. Inisiasi Menyusu Dini (IMD).

Dilakukan dalam satu jam pertama setelah kelahiran untuk merangsang refleks prolaktin dan oksitosin. Bayi yang segera menyusui memiliki peluang lebih tinggi untuk keberhasilan ASI eksklusif (WHO, 2023).

b. Rooming-In.

Ibu dan bayi dirawat dalam satu ruangan untuk memfasilitasi kontak terus-menerus dan menyusui tanpa jadwal ketat.

c. Koreksi posisi dan perlekatan.

Penelitian oleh Colson (2019) menunjukkan bahwa posisi *biological nurturing* (ibu setengah berbaring, bayi diletakkan di dada) meningkatkan keberhasilan perlekatan dan menurunkan risiko nyeri puting.

d. Konseling Laktasi Terstruktur.

Intervensi yang melibatkan sesi tatap muka atau telekonseling oleh tenaga terlatih. Studi Haroon et al. (2018) menemukan bahwa konseling minimal empat kali selama masa nifas meningkatkan angka ASI eksklusif hingga 30%.

2. Dukungan Psikososial dan Keluarga

Dukungan emosional dan sosial terbukti sama pentingnya dengan dukungan medis. Ibu yang merasa didukung oleh pasangan dan lingkungan memiliki tingkat keberhasilan menyusui yang lebih tinggi.

Strategi berbasis bukti:

a. Pelibatan suami dan anggota keluarga dalam edukasi menyusui (Susiloretni et al., 2020).

b. Pembentukan kelompok pendukung ibu menyusui (*breastfeeding support group*) di masyarakat.

c. Program "Ibu Pendamping ASI" yang dilakukan oleh kader kesehatan atau ibu yang telah berhasil menyusui.

Pendekatan ini terbukti meningkatkan rasa percaya diri ibu dan mengurangi stres yang dapat menghambat refleks oksitosin (Dennis, 2017).

3. Dukungan Komunitas dan Kebijakan Publik

Kebijakan publik berperan menciptakan sistem sosial yang mendukung keberlanjutan laktasi. Program pemerintah dan lembaga kesehatan dunia telah

menetapkan sejumlah intervensi berbasis bukti untuk meningkatkan praktik menyusui.

Contoh kebijakan dan program:

a. Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI).

Diterapkan WHO dan UNICEF sejak 1991. Rumah sakit yang memenuhi 10 langkah keberhasilan menyusui terbukti meningkatkan angka ASI eksklusif (UNICEF, 2023).

b. Ruang laktasi di tempat kerja

Sesuai Permenkes RI No. 15 Tahun 2013, tempat kerja wajib menyediakan ruang laktasi dan waktu istirahat menyusui.

c. Kampanye "Pekan ASI Sedunia".

Program edukatif global setiap bulan Agustus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat menyusui.

Tabel 5.2
Intervensi Dukungan Laktasi Berbasis Bukti

Jenis Dukungan	Deskripsi Intervensi	Dampak Terbukti	Sumber Ilmiah
Dukungan Klinis	IMD, rooming-in, konseling oleh tenaga kesehatan	Meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif hingga 30%	WHO (2023); Haroon et al. (2018)
Dukungan Psikologis	Edukasi dan konseling laktasi untuk ibu dan suami	Menurunkan stres dan meningkatkan <i>self-efficacy</i>	Dennis (2017); Susiloretni et al. (2020)
Dukungan Sosial	Kelompok ibu menyusui di komunitas	Meningkatkan keberlanjutan menyusui >6 bulan	UNICEF (2023)
Dukungan Kebijakan	BFHI, ruang laktasi, cuti melahirkan	Meningkatkan cakupan ASI eksklusif secara nasional	Kemenkes RI (2023); Rollins et al. (2016)

4. Teknologi dan Inovasi dalam Dukungan Laktasi

Perkembangan teknologi juga berperan besar dalam memperluas akses edukasi menyusui. Aplikasi digital seperti *LactaHub* dan platform telekonseling kini digunakan secara global untuk membantu ibu di daerah terpencil. Menurut Brown & Shenker (2022), pendekatan digital terbukti meningkatkan keterlibatan ibu dalam program laktasi dan memperluas jangkauan edukasi berbasis bukti tanpa batas geografis.

Dukungan laktasi berbasis bukti merupakan kombinasi intervensi yang menyentuh aspek klinis, emosional, dan sosial. Keberhasilan menyusui akan meningkat secara signifikan bila tenaga kesehatan memberikan pendampingan aktif, keluarga memberikan dukungan emosional, dan pemerintah memastikan adanya kebijakan yang melindungi hak ibu menyusui.

F. Tantangan Kontemporer dan Strategi Inovatif dalam Dukungan Laktasi

Dalam dua dekade terakhir, pola kehidupan masyarakat mengalami perubahan signifikan terutama akibat globalisasi, kemajuan teknologi, dan meningkatnya partisipasi perempuan di dunia kerja. Perubahan ini membawa dampak besar terhadap praktik menyusui, baik dari sisi tantangan maupun peluang.

Meskipun kesadaran masyarakat tentang pentingnya ASI meningkat, data menunjukkan bahwa banyak ibu masih kesulitan mempertahankan pemberian ASI eksklusif hingga enam bulan. Tantangan kontemporer dalam laktasi kini tidak hanya mencakup aspek fisiologis, tetapi juga sosial, ekonomi, dan digital.

1. Tantangan Ibu Bekerja dan Kebijakan Kerja yang Belum Ramah Laktasi

Salah satu tantangan terbesar bagi ibu masa kini adalah menyeimbangkan antara tanggung jawab pekerjaan dan pemberian ASI. Menurut data *International Labour Organization* (ILO, 2022), lebih dari 45% perempuan di Asia Tenggara merupakan bagian dari angkatan kerja formal. Sayangnya, banyak perusahaan yang belum menyediakan fasilitas memadai untuk mendukung kegiatan memerah ASI. Kendala yang sering muncul meliputi:

- a. Waktu istirahat menyusui yang terbatas.
- b. Tidak tersedianya ruang laktasi yang nyaman dan higienis.
- c. Kurangnya pemahaman pimpinan atau rekan kerja tentang pentingnya menyusui.

Penelitian oleh Abdulraheem et al. (2020) menunjukkan bahwa ibu bekerja dengan akses ke ruang laktasi memiliki kemungkinan dua kali lipat lebih besar untuk berhasil mempertahankan ASI eksklusif dibandingkan yang tidak memiliki fasilitas tersebut.

Strategi berbasis bukti:

- a. Penyediaan *lactation room* di tempat kerja sesuai Permenkes No. 15 Tahun 2013.
- b. Fleksibilitas jam kerja dan kebijakan *work from home* untuk ibu menyusui.
- c. Edukasi manajer dan HRD tentang manfaat dukungan menyusui di lingkungan kerja.

2. Pengaruh Media Sosial dan Informasi yang Menyesatkan

Era digital membawa kemudahan dalam berbagi informasi, termasuk mengenai ASI dan menyusui. Namun, tidak semua informasi di internet dapat dipercaya. Banyak mitos, kesalahpahaman, atau promosi produk susu formula yang menyesatkan. Menurut Victora et al. (2021), paparan iklan susu formula secara daring meningkat 30% dalam lima tahun terakhir, dan hal ini berhubungan dengan menurunnya durasi menyusui di beberapa negara berkembang.

Solusi berbasis bukti:

- a. Edukasi publik melalui akun resmi lembaga kesehatan seperti Kemenkes RI, WHO, dan UNICEF.
- b. Pembuatan konten digital edukatif oleh bidan dan konselor laktasi untuk menandingi informasi menyesatkan.
- c. Penguatan literasi digital masyarakat agar mampu membedakan sumber yang kredibel dan tidak.

Contoh praktik baik:

Program “ASI Cerdas Digital” di Indonesia yang digagas oleh Perinasia bekerja sama dengan Kemenkes, terbukti meningkatkan pengetahuan ibu muda tentang menyusui sebesar 42% setelah mengikuti pelatihan daring selama satu bulan (Kemenkes, 2023).

3. Perubahan Gaya Hidup dan Tantangan Emosional

Gaya hidup modern sering kali membuat ibu menghadapi stres dan tekanan sosial yang tinggi. Tekanan untuk “menjadi ibu sempurna” yang sering diperkuat oleh media sosial dapat menimbulkan rasa bersalah ketika menghadapi masalah menyusui. Menurut Brown (2021), dukungan psikologis memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan laktasi, bahkan lebih kuat dibandingkan faktor ekonomi. Program *mindfulness for mothers* dan dukungan kelompok daring terbukti menurunkan stres serta meningkatkan kepuasan dalam proses menyusui.

Strategi efektif:

- a. Mendorong praktik *self-compassion* dan kesadaran diri ibu melalui bimbingan bidan.
 - b. Pembentukan online *peer support group* untuk berbagi pengalaman tanpa stigma.
 - c. Pelatihan tenaga kesehatan agar sensitif terhadap isu kesehatan mental ibu.
- ## 4. Teknologi Digital sebagai Solusi Inovatif

Teknologi kini menjadi alat pendukung penting dalam promosi dan pemantauan laktasi. Aplikasi digital, konseling virtual, dan platform media sosial memberikan jembatan antara ibu dan tenaga profesional tanpa batas waktu dan jarak. Contohnya, aplikasi LactaHub dan MamaCare Indonesia menawarkan fitur

pemantauan frekuensi menyusui, jadwal memerah ASI, serta konsultasi daring dengan konselor laktasi.

Penelitian oleh Chowdhury et al. (2022) menemukan bahwa penggunaan aplikasi digital laktasi meningkatkan tingkat keberhasilan ASI eksklusif hingga 25% di wilayah perkotaan Asia Selatan. Selain itu, penggunaan telelaktasi (telehealth untuk menyusui) menjadi solusi bagi ibu di daerah terpencil yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan.

Tabel 5.3
Tantangan dan Solusi Inovatif dalam Laktasi Modern

Tantangan	Dampak terhadap Laktasi	Solusi Berbasis Bukti/Inovatif	Sumber
Ibu bekerja tanpa fasilitas menyusui	Produksi ASI menurun, stres meningkat	Ruang laktasi di tempat kerja, kebijakan jam fleksibel	ILO (2022); Abdulraheem et al. (2020)
Informasi keliru di media sosial	Ibu salah persepsi tentang ASI	Literasi digital, edukasi berbasis bukti di media resmi	Victora et al. (2021); Kemenkes (2023)
Tekanan sosial dan emosional	Rasa bersalah, depresi postpartum	Dukungan kelompok daring, mindfulness ibu	Brown (2021)
Akses terbatas ke tenaga ahli	Ibu berhenti menyusui dini	Konseling virtual, aplikasi digital laktasi	Chowdhury et al. (2022)

Tantangan laktasi di era modern bersifat multidimensi, mencakup tekanan sosial, dinamika pekerjaan, serta perubahan pola hidup. Namun, inovasi berbasis teknologi dan pendekatan komunitas membuktikan bahwa solusi selalu ada ketika ilmu dan empati berjalan bersama. Ke depan, tenaga kesehatan perlu mengintegrasikan pendekatan digital, dukungan emosional, dan kebijakan publik yang ramah ibu dalam strategi promosi laktasi nasional.

G. Penutup

Menyusui bukan sekadar tindakan fisiologis untuk memberi makan bayi, tetapi juga merupakan fondasi kesehatan, kasih sayang, dan kedekatan emosional antara ibu dan anak. Proses laktasi menggambarkan keajaiban tubuh manusia yang diatur oleh keseimbangan antara hormon, perasaan, dan dukungan lingkungan. Namun, sebagaimana telah dibahas dalam bab ini, perjalanan menyusui tidak selalu mudah. Banyak ibu menghadapi berbagai kendala mulai dari masalah medis seperti puting

lecet atau bendungan ASI, hingga tantangan emosional, sosial, dan ekonomi. Tantangan-tantangan ini menuntut pemahaman yang tidak hanya ilmiah, tetapi juga empatik dan manusiawi.

Dari berbagai kajian dan bukti ilmiah yang telah diuraikan, terdapat beberapa prinsip penting dalam mendukung keberhasilan laktasi:

1. Menyusui adalah hak dan potensi alami setiap ibu, tetapi membutuhkan dukungan nyata. Dukungan dari tenaga kesehatan, pasangan, keluarga, dan masyarakat adalah penentu utama keberhasilan menyusui.
2. Pendekatan berbasis bukti meningkatkan efektivitas intervensi.

Tindakan seperti Inisiasi Menyusu Dini (IMD), *rooming-in*, dan konseling laktasi terstruktur terbukti meningkatkan angka keberhasilan ASI eksklusif secara signifikan (WHO, 2023; Haroon et al., 2018).

3. Dukungan psikologis dan sosial sama pentingnya dengan dukungan klinis.

Ibu yang merasa diterima, dipahami, dan tidak dihakimi memiliki tingkat keberhasilan menyusui yang lebih tinggi (Dennis, 2017; Brown, 2021).

4. Teknologi dapat menjadi alat bantu, bukan pengganti.

Platform digital, aplikasi laktasi, dan telekonseling dapat memperluas jangkauan edukasi, terutama di daerah dengan keterbatasan tenaga kesehatan (Chowdhury et al., 2022).

Rekomendasi

1. Untuk Ibu dan Keluarga

- a. Jadikan menyusui sebagai pengalaman yang alami dan menyenangkan, bukan beban.
- b. Berikan ruang bagi ibu untuk beristirahat dan menikmati prosesnya tanpa tekanan.
- c. Libatkan pasangan dalam setiap tahap mulai dari edukasi hingga praktik menyusui.
- d. Hindari membandingkan diri dengan ibu lain; setiap pengalaman menyusui itu unik.

2. Untuk Tenaga Kesehatan

- a. Terapkan prinsip *woman-centered care* dengan mendengarkan pengalaman ibu secara empatik.
- b. Berikan informasi yang berbasis bukti dan sesuai konteks budaya lokal.
- c. Gunakan pendekatan kolaboratif lintas profesi: bidan, perawat, konselor laktasi, dan psikolog.
- d. Manfaatkan teknologi digital untuk melakukan edukasi berkelanjutan (telelaktasi, webinar, aplikasi edukatif).

3. Untuk Pembuat Kebijakan dan Institusi

- a. Perkuat regulasi penyediaan ruang laktasi dan waktu istirahat menyusui di tempat kerja.
- b. Dukung kampanye masyarakat ramah ASI melalui media massa dan kegiatan komunitas.
- c. Tingkatkan pelatihan tenaga kesehatan dalam konseling laktasi berbasis bukti.
- d. Bangun jaringan data nasional tentang praktik menyusui untuk pemantauan dan evaluasi kebijakan.

Menatap masa depan, keberhasilan laktasi tidak hanya diukur dari durasi pemberian ASI, tetapi juga dari kualitas pengalaman menyusui itu sendiri. Dalam era digital dan urbanisasi yang cepat, pendekatan yang berkelanjutan dan manusiawi menjadi kunci. Masyarakat perlu mengubah cara pandangnya terhadap menyusui dari sekadar tanggung jawab ibu menjadi tanggung jawab sosial bersama. Dukungan keluarga, kebijakan publik, dan teknologi harus bersatu dalam satu tujuan: menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan penuh kasih sayang. Sebagaimana diungkapkan oleh UNICEF (2023), “Menyusui adalah investasi kecil bagi keluarga, tetapi memberikan dampak besar bagi masa depan bangsa.”

H. Referensi

- Abdulraheem, I. S., Salami, A. A., & Adeoye, O. A. (2020). Workplace support and exclusive breastfeeding among employed mothers in Nigeria. *International Breastfeeding Journal*, 15(1), 12. <https://doi.org/10.1186/s13006-020-00271-8>
- Academy of Breastfeeding Medicine (ABM). (2022). Clinical Protocol #36: The Mastitis Spectrum, Revised 2022. *Breastfeeding Medicine*, 17(5), 360–376. <https://doi.org/10.1089/bfm.2022.29207.abm>
- Ballard, O., & Morrow, A. L. (2013). Human milk composition: Nutrients and bioactive factors. *Pediatric Clinics of North America*, 60(1), 49–74. <https://doi.org/10.1016/j.pcl.2012.10.002>
- Brown, A. (2021). Breastfeeding and mental health: The role of maternal psychological wellbeing in lactation success. *Maternal & Child Health Journal*, 25(6), 843–852. <https://doi.org/10.1007/s10995-021-03146-2>
- Brown, A., & Shenker, N. (2022). Digital health interventions to support breastfeeding: Systematic review and meta-analysis. *Maternal & Child Nutrition*, 18(2), e13320. <https://doi.org/10.1111/mcn.13320>
- Chowdhury, S., Rahman, M., & Hossain, M. (2022). Mobile app-based breastfeeding support in South Asia: A randomized controlled trial. *Journal of Telemedicine and Telecare*, 28(9), 689–698. <https://doi.org/10.1177/1357633X221094621>
- Colson, S. D. (2019). *Biological nurturing: The laid-back breastfeeding revolution*. Pinter & Martin.

- Dennis, C. L. (2017). Theoretical underpinnings of breastfeeding confidence: A self-efficacy framework. *Journal of Human Lactation*, 33(2), 295–298. <https://doi.org/10.1177/0890334417691257>
- Geddes, D. T., & Perrella, S. L. (2019). Breastfeeding and human lactation: Physiological aspects. *Journal of Pediatric and Child Health*, 55(10), 1152–1157. <https://doi.org/10.1111/jpc.14674>
- Haroon, S., Das, J. K., Salam, R. A., Imdad, A., & Bhutta, Z. A. (2018). Breastfeeding promotion interventions and breastfeeding practices: A systematic review. *BMC Public Health*, 13(Suppl 3), S20. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-S3-S20>
- International Labour Organization (ILO). (2022). Maternity protection and breastfeeding support in the workplace: Global review. Geneva: ILO. <https://www.ilo.org>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Permenkes Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Menyusui dan/atau Memerah ASI di Tempat Kerja. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Program ASI Cerdas Digital: Laporan Hasil Evaluasi 2023. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022: Laporan Nasional. Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. <https://www.kemkes.go.id>
- Lawrence, R. A., & Lawrence, R. M. (2022). *Breastfeeding: A guide for the medical profession* (9th ed.). Elsevier.
- Riordan, J., & Wambach, K. (2019). *Breastfeeding and Human Lactation* (6th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Rollins, N. C., Bhandari, N., Hajeebhoy, N., Horton, S., Lutter, C. K., Martines, J. C., & Victora, C. G. (2016). Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practices? *The Lancet*, 387(10017), 491–504. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)01044-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01044-2)
- Susiloretni, K. A., Krisnana, I., Paramastri, I., Rahmawati, A., & Suryawan, A. (2020). The role of husband's support in exclusive breastfeeding practice among Indonesian mothers. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 20(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12884-020-02847-0>
- Ueda, T., Yokoyama, Y., Irahara, M., & Aono, T. (2018). Influence of psychological stress on suckling-induced oxytocin release and milk ejection reflex in women. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 87(4), 1764–1768. <https://doi.org/10.1210/jcem.87.4.839>
- UNICEF. (2023). *Breastfeeding: A Mother's Gift for Every Child*. New York: UNICEF. <https://www.unicef.org/breastfeeding>
- Victora, C. G., Bahl, R., Barros, A. J. D., França, G. V. A., Horton, S., Krasevec, J., & Rollins, N. C. (2016). Breastfeeding in the 21st century: Epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. *The Lancet*, 387(10017), 475–490. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)01024-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01024-7)
- Victora, C. G., Bahl, R., Barros, A. J., & Horton, S. (2021). *Breastfeeding in the 21st century*:

Epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. The Lancet, 397(10284), 475–490. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00130-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00130-6)

World Health Organization (WHO). (2023). Infant and Young Child Feeding: Guideline on Breastfeeding Support. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240075790>

I. Glosarium

B

Baby blues: adalah kondisi emosional yang umum dialami oleh ibu setelah melahirkan, ditandai dengan perasaan sedih, mudah menangis, cemas, dan perubahan suasana hati yang muncul dalam beberapa hari pertama pascapersalinan. Kondisi ini biasanya bersifat sementara dan dapat membaik tanpa intervensi medis dengan dukungan emosional dari keluarga dan tenaga kesehatan.

Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI): adalah program global yang diluncurkan oleh World Health Organization (WHO) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) untuk mempromosikan, melindungi, dan mendukung praktik menyusui di fasilitas kesehatan melalui penerapan Ten Steps to Successful Breastfeeding atau Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui.

Biological nurturing: adalah pendekatan menyusui yang menekankan posisi alami antara ibu dan bayi, di mana ibu berada dalam posisi setengah berbaring dan bayi diletakkan di atas tubuh ibu sehingga refleks menyusu bayi dapat bekerja secara optimal. Metode ini membantu meningkatkan keberhasilan pelekatan dan kenyamanan selama menyusui.

Breastfeeding self-efficacy: adalah keyakinan seorang ibu terhadap kemampuannya untuk menyusui bayinya secara efektif dan berkelanjutan. Konsep ini berperan penting dalam menentukan keberhasilan menyusui, karena semakin tinggi tingkat self-efficacy ibu, semakin besar kemungkinan ia mempertahankan praktik menyusui eksklusif.

Breastfeeding support group: adalah kelompok pendukung yang terdiri dari para ibu menyusui, konselor laktasi, dan tenaga kesehatan yang bertujuan memberikan dukungan emosional, informasi, serta berbagi pengalaman terkait menyusui. Keberadaan kelompok ini terbukti membantu meningkatkan durasi dan keberhasilan menyusui melalui penguatan jejaring sosial dan motivasi ibu.

C

Candida albicans: adalah jenis jamur oportunistik yang dapat menyebabkan infeksi pada puting dan areola ibu menyusui, dikenal sebagai kandidiasis payudara. Infeksi

ini sering menimbulkan rasa nyeri, terbakar, dan gatal pada puting, serta dapat menyebar ke mulut bayi sebagai oral thrush. Faktor risiko meliputi penggunaan antibiotik, kelembapan tinggi di area payudara, dan kebersihan yang kurang optimal.

Cracked Nipples: adalah kondisi di mana kulit puting mengalami luka atau retakan akibat teknik pelekatan bayi yang kurang tepat saat menyusui, penggunaan pompa ASI yang tidak sesuai, atau gesekan berlebih. Kondisi ini dapat menimbulkan nyeri hebat, perdarahan, dan meningkatkan risiko infeksi. Penanganan mencakup koreksi posisi menyusui, perawatan lokal dengan ASI, serta menjaga kebersihan dan kelembapan puting.

E

Evidence-based practice: adalah pendekatan dalam pelayanan kebidanan dan keperawatan yang didasarkan pada penggunaan bukti ilmiah terkini yang valid dan relevan untuk pengambilan keputusan klinis. Praktik ini mengintegrasikan hasil penelitian terbaik dengan keahlian profesional tenaga kesehatan serta nilai dan preferensi pasien guna meningkatkan mutu dan efektivitas asuhan kebidanan.

H

Hipogalaktia: adalah kondisi berkurangnya atau tidak mencukupinya produksi Air Susu Ibu (ASI) untuk memenuhi kebutuhan bayi. Penyebabnya dapat bersifat fisiologis (misalnya akibat insufisiensi jaringan kelenjar payudara) atau nonfisiologis (seperti stres, teknik menyusui yang salah, dan frekuensi menyusui yang jarang). Penanganan dilakukan melalui evaluasi teknik menyusui, peningkatan stimulasi payudara, serta dukungan laktasi intensif.

I

Inisiasi Menyusu Dini: adalah proses membiarkan bayi menyusui sendiri segera setelah lahir, biasanya dalam waktu satu jam pertama kehidupan, dengan menempatkan bayi di dada atau perut ibu untuk mencari puting dan mulai menyusui. Praktik ini mendukung keberhasilan menyusui eksklusif, memperkuat ikatan ibu dan bayi, serta menstimulasi pengeluaran hormon oksitosin yang membantu kontraksi uterus dan pengeluaran ASI.

K

Kolostrum: adalah cairan kental berwarna kekuningan yang diproduksi oleh payudara ibu pada hari-hari pertama setelah melahirkan. Kolostrum mengandung kadar tinggi protein, antibodi (terutama imunoglobulin A), dan faktor imunologis

yang penting untuk membentuk kekebalan awal bayi terhadap infeksi. Karena nilai gizinya yang tinggi, kolostrum disebut juga “emas cair” bagi bayi baru lahir.

L

LactaHub: adalah platform digital yang menyediakan informasi, edukasi, dan dukungan bagi ibu menyusui serta tenaga kesehatan melalui fitur interaktif seperti konsultasi laktasi, panduan menyusui, dan forum komunitas. Aplikasi ini berfungsi sebagai media promosi kesehatan berbasis teknologi yang mendukung peningkatan pengetahuan dan praktik menyusui berbasis bukti.

Lactation room: adalah ruangan yang disediakan di tempat kerja, fasilitas umum, atau institusi pendidikan bagi ibu menyusui untuk memerah, menyimpan, dan memberikan ASI secara nyaman, bersih, dan privat. Fasilitas ini merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan ramah ibu dan bayi guna meningkatkan keberlanjutan pemberian ASI eksklusif.

O

Oksitosin: adalah hormon yang diproduksi oleh hipotalamus dan disekresikan oleh kelenjar hipofisis posterior, berperan penting dalam kontraksi otot uterus saat persalinan serta refleks pengeluaran ASI (*let-down reflex*) selama menyusui. Stimulasi puting oleh hisapan bayi meningkatkan sekresi oksitosin, sehingga memperlancar aliran ASI dan memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi.

On-demand feeding: adalah metode pemberian ASI yang dilakukan berdasarkan keinginan dan kebutuhan bayi tanpa jadwal yang kaku. Pendekatan ini memungkinkan bayi menyusui kapan pun ia menunjukkan tanda lapar, membantu menjaga produksi ASI tetap optimal, serta mendukung terciptanya kedekatan emosional ibu dan bayi melalui interaksi alami.

P

Prolaktin: adalah hormon yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis anterior dan berperan utama dalam merangsang produksi Air Susu Ibu (ASI) setelah persalinan. Sekresi prolaktin meningkat sebagai respons terhadap hisapan bayi pada puting, dan kadar hormon ini mempengaruhi volume serta kelangsungan laktasi.

Peer support group: adalah kelompok pendamping sebaya yang terdiri dari para ibu atau individu dengan pengalaman serupa dalam menyusui, yang saling memberikan dukungan emosional, motivasi, dan berbagi informasi praktis terkait laktasi. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan keberhasilan menyusui eksklusif dan memperkuat rasa percaya diri ibu.

Power pumping: adalah teknik memompa ASI dengan pola terstruktur dan frekuensi tinggi untuk meniru pola menyusui intens bayi dalam upaya meningkatkan produksi ASI. Biasanya dilakukan dengan metode *interval pumping* (misalnya 20 menit memompa – 10 menit istirahat – 10 menit memompa – 10 menit istirahat – 10 menit memompa) selama satu jam. Teknik ini bekerja melalui peningkatan stimulasi hormonal, terutama prolaktin dan oksitosin.

Program “Ibu Pendamping ASI: adalah program pendampingan berbasis komunitas yang melibatkan para ibu dengan pengalaman menyusui untuk memberikan bimbingan, edukasi, dan dukungan langsung kepada ibu menyusui lainnya. Tujuan program ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi ibu dalam memberikan ASI eksklusif, sekaligus membangun jejaring sosial pendukung laktasi di masyarakat.

Program mindfulness for mothers: adalah intervensi psikologis berbasis kesadaran penuh (*mindfulness-based intervention*) yang dirancang untuk membantu ibu mengelola stres, kelelahan emosional, dan tekanan selama masa menyusui atau pengasuhan. Praktik ini melatih fokus pada saat ini tanpa penilaian, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mental, memperkuat ikatan ibu-bayi, dan mendukung keberhasilan menyusui.

S

Self-compassion: adalah kemampuan individu untuk bersikap lembut, memahami, dan tidak menghakimi diri sendiri ketika menghadapi kesulitan atau kegagalan. Dalam konteks ibu menyusui, *self-compassion* membantu mengurangi stres dan rasa bersalah ketika mengalami hambatan laktasi, serta meningkatkan kesehatan mental dan motivasi untuk terus menyusui.

Skin-to-skin contact: adalah praktik menempatkan bayi tanpa pakaian langsung di dada atau perut ibu segera setelah lahir atau selama periode menyusui. Kontak kulit dengan kulit ini memberikan kehangatan, menstabilkan suhu tubuh dan detak jantung bayi, serta merangsang refleks menyusui alami yang mendukung keberhasilan Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian ASI eksklusif.

Staphylococcus aureus: adalah bakteri patogen yang sering menjadi penyebab utama infeksi pada payudara ibu menyusui, seperti mastitis dan abses payudara. Bakteri ini dapat masuk melalui retakan pada puting dan berkembang biak di jaringan payudara, menyebabkan peradangan, nyeri, kemerahan, dan demam. Penanganan mencakup terapi antibiotik dan perawatan laktasi yang tepat.

W

Woman-centered care: adalah pendekatan pelayanan kebidanan yang berfokus pada kebutuhan, nilai, dan preferensi perempuan sebagai pusat asuhan. Prinsip ini menekankan penghormatan terhadap otonomi, partisipasi aktif, serta pengambilan keputusan bersama antara ibu dan tenaga kesehatan untuk menciptakan pengalaman asuhan yang aman, bermartabat, dan memberdayakan.

Work from home: adalah sistem kerja yang memungkinkan individu melaksanakan tugas profesional dari rumah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Dalam konteks ibu menyusui, *work from home* dapat menjadi strategi pendukung keberlanjutan menyusui karena memberikan fleksibilitas waktu dan kesempatan lebih besar bagi ibu untuk menyusui langsung atau memerah ASI secara teratur.

BAB 6

KONTRASEPSI PASCA PERSALINAN

A. Pendahuluan

Untuk menurunkan angka kematian maternal, program Keluarga Berencana (KB) masih perlu ditingkatkan dan memenuhi permintaan ber-KB terutama pada perempuan usia subur berisiko, termasuk perempuan usia 15-19 tahun dan 35-49 tahun, perempuan dengan paritas 4 atau lebih dan ibu setelah melahirkan. Penggunaan kontrasepsi bertujuan untuk memenuhi hak reproduksi setiap orang, membantu merencanakan kapan dan berapa jumlah anak yang diinginkan, dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, penggunaan alat kontrasepsi secara tepat juga dapat mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, pemenuhan akses dan kualitas program Keluarga Berencana (KB) sudah seharusnya menjadi prioritas dalam pelayanan kesehatan. (BKKBN, 2021)

Berdasarkan hasil penelitian Sepertiga angka kematian ibu dan 10% angka kematian bayi menurun sebagai hasil pemakaian kontrasepsi, dimana kehamilan berjarak minimal 2 tahun (lucksom et al. 2015 dalam Beru, Ivana, 2024).

Dalam bab ini membahas tentang kontrasepsi pasca persalinan, hal ini merupakan program pemerintah yang sangat penting sekali, untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, dengan cara memberikan edukasi dan pemahaman kepada para ibu sejak masa kehamilan sehingga dapat mengambil keputusan terhadap kontrasepsi yang akan digunakan pada saat pasca persalinan dan segera menjadi akseptor KB saat pasca persalinan. Hal ini bertujuan untuk memberikan jarak kehamilan berikutnya, sehingga ibu fokus untuk pemulihan pasca persalinan dan memberikan pemenuhan nutrisi pada bayinya dengan memberikan ASI eksklusif. Hal ini bertujuan untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas pada ibu dan bayi.

B. Pengertian Kontrasepsi Pasca Persalinan

Kontrasepsi pasca persalinan adalah metode kontrasepsi yang diberikan sebagai upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat/obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai kurun waktu 42 hari (6 minggu) setelah melahirkan, dengan tujuan mengatur jarak kehamilan/kelahiran, dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehamilan yang aman dan sehat. (KemenKes, 2021)

KB pasca persalinan merupakan pelayanan kontrasepsi yang diberikan kepada ibu yang baru melahirkan. Tidak semua jenis kontrasepsi dapat diberikan jenis kontrasepsi dapat diberikan karena ada kondisi khusus yang dapat mengganggu kesehatan atau kepentingan ibu maupun bayi. Pelayanan KB pasca persalinan adalah upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat/obat kontrasepsi (alokon) dan metode tertentu dengan segera setelah melahirkan sampai kurun waktu 42 hari/ 6 minggu setelah melahirkan. WHO bahkan menetapkan KB pasca persalinan sampai dengan 12 bulan pertama pasca persalinan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi perempuan yang berubah selama periode tersebut antara lain seperti status ibu menyusui. (BKKBN, 2021).

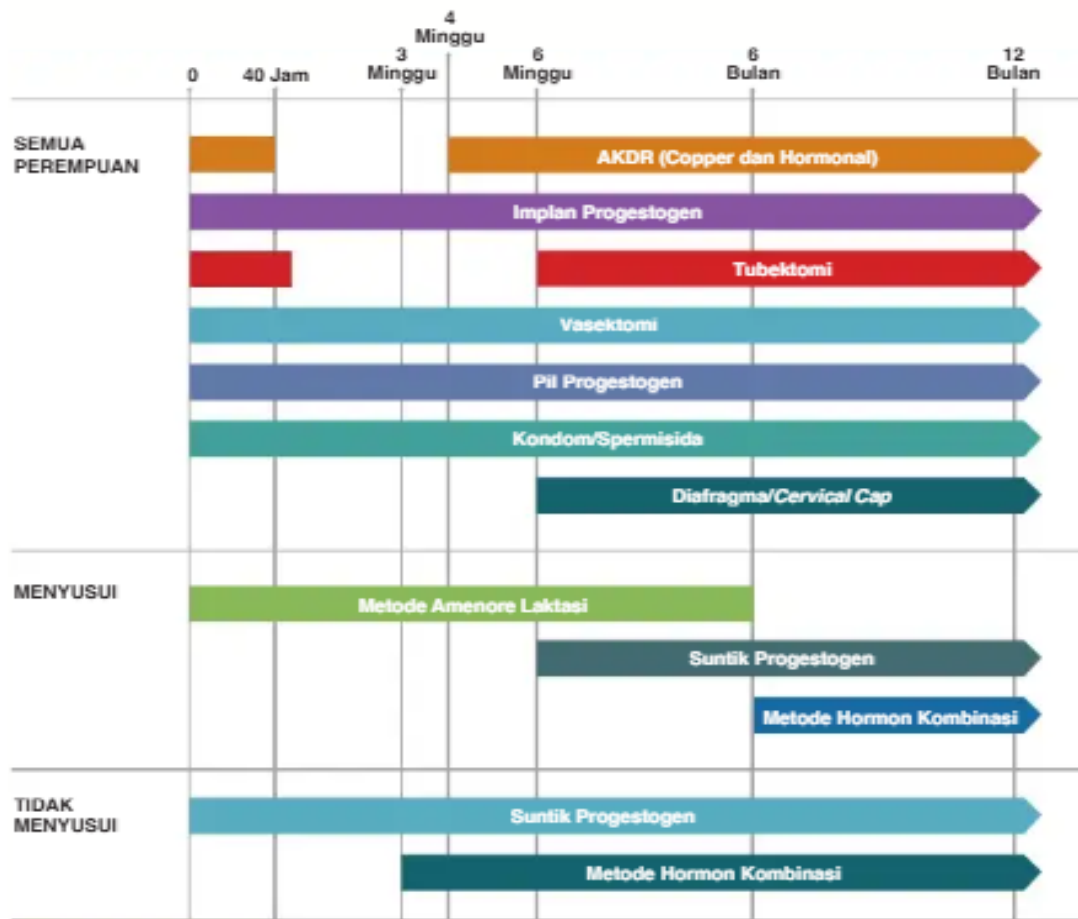
C. Tujuan KB Pasca Persalinan

Pelayanan KB pasca persalinan bertujuan:

1. Menurunkan kehilangan kesempatan (*missed opportunity*) ber-KB pada klien yang sudah berkontak dengan petugas kesehatan sejak ANC, bersalin dan masa nifas.
2. Membantu menciptakan jarak ideal antar kehamilan dan menghindari kehamilan tidak direncanakan, sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehamilan yang aman dan sehat.
3. Meningkatkan kepesertaan baru KB.
4. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan keluarga

D. Waktu penggunaan metode kontrasepsi pasca persalinan.

Ada 3 kondisi yang memerlukan penyesuaian jenis kontrasepsi yang diberikan kepada ibu pasca melahirkan, yaitu: untuk semua perempuan, perempuan yang menyusui dan perempuan yang tidak menyusui.



Gambar 6.1
Waktu penggunaan metode Kontrasepsi Pascapersalinan

E. Pentingnya KB Pasca Persalinan

Pelayanan KB selama tahun pertama pasca persalinan berdampak pada komponen pelayanan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi. Alasan pentingnya penggunaan KB pasca persalinan, yaitu:

1. Periode paling reseptif dalam menerima kontrasepsi perempuan lebih reseptif menerima metode kontrasepsi hanya setelah melahirkan terutama pada 48 jam pertama dengan penyedia layanan kesehatan yang ada memberikan kesempatan untuk konseling dan menyediakan metode kontrasepsi yang aman dan sesuai pilihan mereka sebelum meninggalkan rumah.
2. Risiko kehamilan setelah melahirkan untuk perempuan yang tidak menyusui, kehamilan dapat segera terjadi setelah 4 minggu kelahiran. Tetapi untuk perempuan yang tidak menggunakan metode LAM, kemungkinan akan menjadi subur sebelum menstruasi. Untuk perempuan yang menggunakan metode lam kemungkinan bisa hamil setelah 6 bulan melahirkan.
3. *Unmet need* pada sebuah penelitian oleh Ross dan Frankenberg (1993) mengungkapkan bahwa perempuan dalam periode postpartum memiliki risiko

unmet need dari semua wanita selama usia reproduksi pada umumnya selama periode postpartum.

4. Memastikan waktu yang sehat dan jarak kehamilan interval kehamilan kurang dari 24 bulan dengan risiko tinggi berdampak buruk pada ibu, janin dan bayinya. Penyediaan konseling KB dan pelayanan setelah melahirkan dapat memastikan waktu yang sehat dan jarak kehamilan.
5. Memastikan waktu kehamilan yang aman setelah keguguran jarak kurang dari 6 bulan antara keguguran dan kehamilan berikutnya berhubungan dengan tingginya risiko dampak buruk pada kesehatan ibu, janin dan bayi. Penyediaan konseling kb dan pelayanan setelah aborsi dapat memastikan jarak kurang dari 6 bulan untuk kehamilan berikutnya.

F. Manfaat KB Pasca Persalinan

Menurut USAID (2011:4) penggunaan KB pada perempuan postpartum dapat berdampak signifikan pada:

1. Mengurangi angka kematian dan kesakitan pada ibu
2. Mengurangi angka kematian dan kesakitan pada bayi
3. Mencegah risiko atau kehamilan yang tidak diinginkan
4. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan pada perempuan muda dan tua, ketika besarnya risiko kematian ibu dan bayi.
5. Mengurangi kejadian aborsi, khususnya aborsi tidak aman.
6. Memungkinkan perempuan untuk mengatur jarak kehamilan
7. Mengurangi kasus penularan HIV/AIDS dari ibu ke janin

G. Konseling KB Pasca Persalinan

Konsep Dasar Konseling

Konseling merupakan aspek yang sangat penting dalam memberikan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Konseling yang baik dapat membuat klien merasa puas, membantu klien dalam menggunakan kontrasepsinya lebih lama dan meningkatkan keberhasilan kontrasepsi yang digunakan.

1. Pengertian Konseling

Konseling adalah proses komunikasi antara seseorang (konselor) dengan orang lain (pasien), dimana konselor sengaja membantu klien dengan menyediakan waktu, keahlian, pengetahuan dan informasi tentang akses pada sumber-sumber lain. Konselor membantu klien membuat keputusan atas masalah yang ada, proses ini dilaksanakan secara terus menerus. (Depkes, 2002)

Konseling merupakan komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap (*attitude change*) pada orang yang terlihat dalam komunikasi. Tujuan

komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima, sehingga Bahasa lebih jelas, lengkap, pengiriman dan umpan balik seimbang, dan melatih penggunaan bahasa nonverbal secara baik. Konseling merupakan unsur yang penting dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi karena melalui konseling klien dapat memilih dan memutuskan jenis kontrasepsi yang akan digunakan sesuai dengan pilihannya serta meningkatkan keberhasilan KB.

Konseling adalah proses yang berjalan dan menyatu dengan semua aspek pelayanan keluarga berencana dan bukan hanya informasi yang diberikan pada satu kesempatan yakni pada saat pemberian pelayanan. Teknik konseling yang baik dan informasi yang memadai harus diterapkan dan dibicarakan secara interaktif sepanjang kunjungan klien dengan cara yang sesuai dengan budaya yang ada.

2. Tujuan Konseling

Konseling KB bertujuan membantu klien dalam hal:

- a. Menyampaikan informasi dari pilihan pola reproduksi.
- b. Memilih metode KB yang diyakini
- c. Menggunakan metode KB yang dipilih secara aman dan efektif
- d. Memulai dan melanjutkan KB
- e. Mempelajari tujuan, ketidaksiaran informasi tentang metode KB yang tersedia.
- f. Memecahkan masalah, meningkatkan keefektifan individu dalam pengambilan keputusan secara tepat
- g. Membantu pemenuhan kebutuhan klien meliputi menghilangkan perasaan yang menekan/mengganggu dan mencapai kesehatan mental yang positif.
- h. Mengubah sikap dan tingkah laku yang negatif menjadi positif dan yang merugikan klien menjadi menguntungkan klien.
- i. Meningkatkan penerimaan
- j. Menjamin pilihan yang cocok
- k. Menjamin penggunaan cara yang efektif
- l. Menjamin kelangsungan yang lama

3. Manfaat Konseling

Konseling KB yang diberikan pada klien memberikan keuntungan kepada pelaksana kesehatan maupun penerima layanan KB. Adapun keuntungannya adalah:

- a. Klien dapat memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Puas terhadap pilihannya dan mengurangi keluhan atau penyesalan.
- c. Cara dan lama penggunaan yang sesuai serta efektif.

- d. Membangun rasa saling percaya
- e. Menghormati hak klien dan petugas
- f. Menambah dukungan terhadap pelayanan KB
- g. Menghilangkan rumor dan konsep yang salah

4. Prinsip Konseling KB

Prinsip konseling KB meliputi: percaya diri, tidak memaksa, informed consent (ada persetujuan dari klien); hak klien dan kewenangan. Kemampuan menolong orang lain digambarkan dalam sejumlah keterampilan yang digunakan seseorang sesuai dengan profesinya yang meliputi:

- a. Pengajaran
- b. Nasehat dan bimbingan
- c. Pengambilan tindakan langsung
- d. Pengelolaan
- e. Konseling

5. Hak Klien

Dalam memberikan pelayanan kebidanan bidan harus memahami benar hak calon akseptor KB. Hak-hak akseptor KB adalah sebagai berikut:

- a. Terjaga harga diri dan martabatnya
- b. Dilayani secara pribadi (privasi) dan terpeliharanya kerahasiaan.
- c. Memperoleh informasi tentang kondisi dan tindakan yang akan dilaksanakan
- d. Mendapat kenyamanan dan pelayanan terbaik
- e. Menerima atau menolak pelayanan atau tindakan yang akan dilakukan.
- f. Kebebasan dalam memilih metode yang akan digunakan.

6. Peran Konselor KB

Peran konseling dalam praktik pelayanan kebidanan terutama pada pelayanan keluarga berencana, tidak terlepas dari peran konselor. Tugas seorang konselor adalah sebagai berikut:

- a. Sahabat, pembimbing dan memberdayakan klien untuk membuat pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Memberi informasi yang objektif, lengkap, jujur dan akurat tentang berbagai metode kontrasepsi yang tersedia.
- c. Membangun rasa saling percaya, termasuk dalam proses pembuatan persetujuan tindakan medik.

7. LANGKAH-LANGKAH KONSELING KELUARGA BERENCANA

Sebelum menerapkan langkah-langkah konseling KB, konselor hendanya memperhatikan beberapa sikap yang baik selama konseling, sikap ini dikenal sebagai **SOLER** yaitu:

S	Face your clients squarely (menghadap ke klien) dan Smile /not at client (senyum/mengangguk ke klien)
O	Open and non-judgemental facial expression (ekspresi muka menunjukkan sikap terbuka dan tidak menilai)
L	Lean towards client (tubuh condong ke klien)
E	Eye contact in a culturally-acceptable manner (kontak mata/tatap mata sesuai cara yang diterima budaya setempat)
R	Relaxed and friendly manner (santai dan sikap bersahabat)

Pada konseling KB terdapat enam langkah konseling yang sudah dikenal dengan kata kunci **SATU TUJU**. Penerapan langkah konseling **KB SATU TUJU** tersebut tidak perlu dilakukan secara berurutan karena petugas harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan klien. Beberapa klien membutuhkan lebih banyak perhatian pada langkah yang satu dibanding dengan langkah yang lainnya. Langkah konseling **KB SATU TUJU** yang dimaksud adalah sebagai berikut:

SA	S Apa dan S Alam kepada klien secara terbuka dan sopan. Berikan perhatian sepenuhnya kepada mereka dan berbicara ditempat yang nyaman serta terjamin privasinya. Yakinkan klien untuk membangun rasa percaya diri. Tanyakan kepada klien apa yang dapat dibantu serta jelaskan pelayanan apa yang dapat diperoleh.
T	T anyakan pada klien informasi tentang dirinya. Bantu klien untuk berbicara mengenai pengalaman KB dan kesehatan reproduksi serta yang lainnya. Tanyakan kontrasepsi yang diinginkan oleh klien. Dengan memahami kebutuhan, pengetahuan dan keinginan klien, kita dapat membantunya.
U	U raikan kepada klien mengenai pilihannya dan jelaskan mengenai kontrasepsi yang mungkin diinginkan oleh klien dan jenis kontrasepsi.
TU	banT Ulah klien menentukan pilihannya. Bantulah klien berfikir mengenai apa yang paling sesuai dengan keadaan kebutuhannya. Dorong klien untuk menunjukkan keinginannya dan mengajukan pertanyaan. Tanggapi secara terbuka dan petugas mempertimbangkan kriteria dan keinginan klien terhadap setiap jenis kontrasepsi. Tanyakan apakah pasangannya akan memberikan dukungan dengan pilihannya tersebut
J	J elaskan secara lengkap bagaimana menggunakan kontrasepsi pilihannya. Setelah klien memilih jenis kontrasepsinya, jika diperlukan, perlihatkan alat/obat kontrasepsinya. Jelaskan bagaimana alat/obat

	tersebut digunakan dan cara penggunaannya. Lalu pastikan klien untuk bertanya atau menjawab secara terbuka.
U	Perlunya dilakukan kunjungan U lang. Bicarakan dan buat perjanjian kepada klien untuk kembali lagi melakukan pemeriksaan lanjutan atau permintaan kontrasepsi jika dibutuhkan.

8. Hal Penting Dalam Konseling Kb Pasca Persalinan

Teknik konseling yang baik dan informasi yang memadai harus diterapkan dan dibicarakan secara interaktif sepanjang kunjungan klien dengan cara yang sesuai dengan budaya yang ada. Dengan adanya informasi yang lengkap dan cukup akan memberikan keleluasaan kepada klien dalam memutuskan untuk memilih kontrasepsi (*informed choice*) yang akan digunakannya.

Konseling KB pasca persalinan sebaiknya dilaksanakan sejak awal masa kehamilan sehingga ibu sudah mempunyai perencanaan menggunakan KB pasca persalinan, baik pada pelayanan antenatal maupun pada kelas ibu hamil. Konseling dapat menggunakan informasi yang terdapat dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), sebelum menjelang masa persalinan, klien perlu di dorong untuk memutuskan metode kontrasepsi pasca persalinan (diutamakan kontrasepsi jangka panjang).

Proses konseling dapat dilanjutkan selama proses menjelang persalinan dan masa pasca persalinan dini, yaitu ketika ibu masih dirawat di ruang nifas atau rawat gabung. Dengan konseling yang berkualitas dan berkesinambungan. Diharapkan klien sudah menggunakan metode kontrasepsi pasca persalinan sebelum pulang dari fasilitas kesehatan.

9. Tempat dan Waktu Konseling Pasca Persalinan

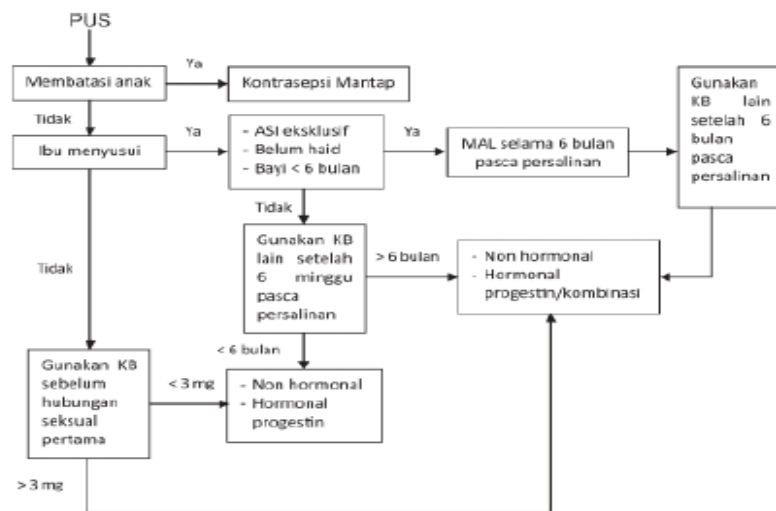
Konseling pasca persalinan dapat dilakukan di semua tempat yang memenuhi syarat yaitu ruangan tertutup yang dapat menjamin kerahasiaan dan keleluasaan dalam menyampaikan pemikiran dan perasaan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi klien.

10. Poin Kunci dalam Pelayanan Kb Pasca Salin

- a. Tetap mempromosikan ASI eksklusif
- b. Memberikan informasi tentang waktu dan jarak kelahiran yang baik
- c. Memastikan tujuan klien berKB apakah untuk membatasi jumlah anak atau mengatur jarak kehamilan.

Informasi penting yang harus diberikan dalam konseling KB pasca persalinan:

- Efektivitas dari metode kontrasepsi
- Keuntungan dan keterbatasan dari metode kontrasepsi
- Kembalinya kesuburan setelah melahirkan
- Efek samping jangka panjang dan jangka pendek
- Gejala dan tanda yang membahayakan
- Kebutuhan untuk pencegahan terhadap infeksi menular seksual
- Waktu dimulainya kontrasepsi pasca persalinan didasarkan pada:
 - Status menyusui
 - Metode kontrasepsi yang dipilih
 - Tujuan reproduksi, membatasi atau hanya memberi jarak



Gambar 6.2
Algoritme pemilihan kontrasepsi pasca persalinan

11. Penapisan Kelayakan Medis Dalam Penggunaan Kontrasepsi Pasca Persalinan

Proses konseling kontrasepsi pasca persalinan perlu dilanjutkan dengan kelayakan medis dalam penggunaan kontrasepsi pasca persalinan harus dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi kesehatan. Artinya, metode kontrasepsi pasca persalinan yang akan digunakan oleh pasangan suami istri harus mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, serta kondisi kesehatan klien.

Oleh karena itu, petugas kesehatan perlu mengetahui kondisi medis dan karakteristik khusus sebelum klien menggunakan kontrasepsi pasca persalinan. Hal ini dikarenakan pada klien dengan kondisi medis atau karakteristik khusus, terdapat metode kontrasepsi yang mungkin dapat memperburuk kondisi medis atau membuat risiko kesehatan tambahan. Contohnya seperti: klien dengan

hipertensi, diabetes, HIV. Terdapat juga kondisi medis atau karakteristik klien yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi metode kontrasepsi, seperti: usia, ibu menyusui. Contohnya : bagi ibu tidak direkomendasikan metode kontrasepsi hormonal kombinasi yang dapat mempengaruhi produksi ASI.

Dalam melakukan penapisan kelayakan medis sebelum penggunaan kontrasepsi pasca persalinan, petugas kesehatan dapat menggunakan alat bantu berupa diagram Lingkaran Kriteria Medis Penggunaan Kontrasepsi (Roda KLOP) (WHO,2015).

H. Jenis-jenis Metode Kontrasepsi Pasca Persalinan

Proses konseling dan penapisan kelayakan medis diharapkan berujung pada keputusan klien untuk menggunakan salah satu metode kontrasepsi pasca persalinan. Secara umum, hampir semua metode kontrasepsi dapat digunakan sebagai metode KB pasca persalinan. Sesuai dengan *Health Technology Assessment* (HTA) Indonesia yang telah dikeluarkan tahun 2009 oleh Kementerian Kesehatan tentang KB pada periode menyusui, beberapa metode kontrasepsi yang efektif dalam mencegah kehamilan pada periode menyusui. Menyusui memberikan banyak dampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi, sehingga dalam pemilihan kontrasepsi pasca persalinan harus menggunakan metode kontrasepsi yang tidak mengganggu produksi ASI. Berikut ini jenis-jenis metode kontrasepsi pasca persalinan:

1. Kontrasepsi Metode Amenorea Laktasi (MAL)

a. Definisi

Metode Amenorea Laktasi (MAL) atau *Lactational Amenorrhea Method* (LAM) adalah metode kontrasepsi sementara yang mengandalkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan dan minuman lainnya. Metode Amenorea Laktasi (MAL) atau *Lactational Amenorrhea Method* (LAM) dapat dikatakan sebagai metode keluarga berencana alamiah (KBA) atau *Natural Family Planning*, apabila tidak dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain.

Meskipun penelitian telah membuktikan bahwa menyusui dapat menekan kesuburan, namun banyak wanita yang hamil kembali ketika sedang masa menyusui. Oleh karena itu, selain menggunakan Metode Amenorea Laktasi juga harus menggunakan metode kontrasepsi lain seperti metode barrier (diafragma, kondom, spermisida), kontra sepsi hormonal (suntik, pil menyusui, AKBK) maupun IUD.

Metode Amenorea Laktasi (MAL) dapat di gunakan sebagai alat kontrasepsi, apabila:

- 1) Menyusui secara penuh (*full breast feeding*), lebih efektif bila diberikan minimal 8 kali sehari.
 - 2) Belum mendapat haid.
 - 3) Umur bayi kurang dari 6 bulan.
- b. Waktu mulai penggunaan
- 1) Segera pasca persalinan
 - 2) Efektivitas tinggi sampai 6 bulan pasca persalinan dan belum dapat haid
 - 3) Jika menyusui:
- c. Cara kerja
- Cara kerja dari Metode Amenorea Laktasi (MAL) adalah menunda atau menekan terjadinya ovulasi. Pada saat laktasi/menyusui, hormon yang berperan adalah prolaktin dan oksitosin. Semakin sering menyusui, maka kadar prolaktin meningkat dan hormon gonadotropin melepaskan hormon penghambat (inhibitor). Hormon penghambat akan mengurangi kadar estrogen, sehingga tidak terjadi ovulasi.
- d. Efektifitas
- Efektifitas MAL sangat tinggi, sekitar 98% apabila digunakan secara benar dan memenuhi persyaratan sebagai berikut : digunakan selama enam bulan pertama setelah melahirkan, belum mendapatkan haid pasca melahirkan dan menyusui secara eksklusif (tanpa memberikan makanan atau minuman tambahan). Efektifitas dari metode ini juga sangat tergantung pada frekuensi dan intensitas menyusui.
- e. Manfaat
- Metode Amenorea Laktasi (MAL) memberikan manfaat kontrasepsi non kontrasepsi.
- Manfaat kontrasepsi dari MAL antara lain:
- 1) Efektifitas tinggi (98%) apabila digunakan selama enam bulan pertama setelah melahirkan, belum mendapat haid dan menyusui eksklusif.
 - 2) Dapat segera dimulai setelah melahirkan
 - 3) Tidak memerlukan prosedur khusus, alat maupun obat
 - 4) Tidak melakukan pengawasan medis.
 - 5) Tidak mengganggu senggama.
 - 6) Mudah digunakan.
 - 7) Tidak perlu biaya.
 - 8) Tidak menimbulkan efek samping sistemik.
 - 9) Tidak bertentangan dengan budaya maupun agama.

Manfaat non kontrasepsi dari MAL antara lain:

Untuk bayi :

- 1) Mendapatkan kekebalan pasif
- 2) Peningkatan gizi
- 3) Mengurangi risiko penyakit menular
- 4) Terhindar dari keterpaparan terhadap kontaminasi air, susu formula atau alat minum yang dipakai.

Untuk ibu:

- 1) Mengurangi perdarahan postpartum / setelah melahirkan
- 2) Membantu proses involusi uteri (uterus kembali normal)
- 3) Mengurangi risiko anemia
- 4) Meningkatkan hubungan psikologi antara ibu dan bayi

2. Kontrasepsi Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)

a. Definisi

IUD adalah alat kontrasepsi dalam Rahim (AKDR) yang dapat diberikan segera setelah lahir sampai dengan 48 jam. Jenis kontrasepsi IUD yang digunakan dapat berupa iud dengan inserter biasa maupun iud dengan inserter Panjang.

b. Jenis AKDR Copper:

1) Waktu mulai penggunaan:

- a) Dapat dipasang maksimal dalam 10 menit setelah plasenta lahir (AKDR pasca plasenta) atau setelah 10 menit sampai 48 jam pasca persalinan (AKDR pasca persalinan dini) atau saat operasi sesar setelah plasenta lahir (AKDR trans sesaria).
- b) Jika tidak, pemasangan harus ditunda sampai 4 hingga 6 minggu pasca persalinan (dianjurkan 6 minggu pasca persalinan).
- c) Jika menyusui atau sudah dapat haid, insersi dilakukan setelah yakin klien tidak hamil.

2) Ciri-ciri khusus:

- a) Tidak ada pengaruh terhadap ASI
- b) Efek samping lebih sedikit pada klien yang menyusui

3) Catatan:

- a) Konseling dilakukan sewaktu asuhan antenatal
- b) Teknik pemasangan pasca plasenta persalinan dini berbeda dengan pemasangan interval.
- c) Pemasangan 4-6 minggu pasca persalinan sama dengan interval.

c. Mekanisme kerja

- 1) Munculnya reaksi radang lokal non spesifik di dalam cavum uteri sehingga mengganggu implantasi sel telur yang telah dibuahi. Selain itu, dengan munculnya leukosit PMN, makrofag, foreign body giant cells, sel mononuclear serta sel plasma yang dapat mengakibatkan lisis dari spermatozoa atau ovum dan blastokista
- 2) Meningkatnya produksi lokal prostaglandin sehingga menyebabkan terhambatnya implantasi.
- 3) Terlepasnya atau terjadinya gangguan pada blastokista yang telah berimplantasi di dalam endometrium.
- 4) Pergerakan ovum di dalam tuba fallopi yang bertambah cepat
- 5) Imobilisasi spermatozoa saat melewati cavum uteri.

d. Jangka waktu pemakaian

Tingkat efektifitas penggunaan sampai 99,4%, IUD/AKDR dapat digunakan untuk jangka waktu pemakaian 3-5 tahun untuk AKDR jenis hormon dan 5-10 tahun untuk AKDR jenis tembaga.

e. Batas usia pemakaian

Dapat digunakan oleh semua wanita usia produktif

f. Efektifitas

Efektifitas IUD/AKDR sangat baik yaitu 98%. Jika suatu hari nanti pasangan menginginkan keturunan kembali, IUD/AKDR dapat segera dilepas. Dengan melepas IUD/AKDR, kesuburan akan kembali dengan cepat.

g. Kembalinya kesuburan

Setelah IUD/AKDR dicabut, kesuburan akan kembali.

h. Keuntungan :

- 1) Setelah IUD/AKDR dipasang, langsung bekerja secara efektif
- 2) Tidak mempengaruhi produksi dan kualitas ASI
- 3) Tidak memiliki efek samping hormonal
- 4) Dapat dipasang segera setelah post partum dan sesudah abortus dengan tidak ditandai adanya tanda gejala infeksi
- 5) Tidak ada interaksi dengan obat-obatan
- 6) Dapat digunakan hingga usia menopause
- 7) Memiliki efektifitas cukup tinggi

i. Kerugian

- 1) Masih terdapatnya kehamilan dengan AKDR In situ.
- 2) Ditemukan perdarahan seperti: spotting dan metroragia
- 3) Leukorea sehingga menguras protein tubuh dan liang senggama yang terasa lebih basah.

- 4) Kemungkinan terjadi infeksi
- 5) Tingkat akhir infeksi menimbulkan kemandulan primer atau sekunder serta kehamilan ektopik.
- 6) Benang AKDR dapat menyebabkan perlukaan portio uteri dan mengganggu hubungan seksual.

j. Kriteria kelayakan medis

Yang boleh menggunakan :

- 1) Usia produktif (15-49 tahun)
- 2) Tidak sedang mengandung
- 3) Menginginkan menggunakan alat kontrasepsi jangka Panjang
- 4) Sedang mengASIhi dan ingin menggunakan alat kontrasepsi
- 5) Setelah mengalami abortus dan tidak terdapat tanda gejala infeksi
- 6) Risiko rendah dari Infeksi Menular Seksual (IMS)
- 7) Tidak menginginkan alat kontrasepsi hormonal

Yang tidak boleh menggunakan:

- 1) Diduga hamil atau sedang hamil
- 2) Klien menderita infeksi alat kelamin atau sejenisnya
- 3) Klien mempunyai riwayat radang panggul
- 4) Klien merupakan post partum hemoragi
- 5) Klien memiliki riwayat kehamilan diluar kandungan
- 6) Klien memiliki tumor ganas pada alat genetaliaanya

k. Waktu pemasangan

- 1) Setiap waktu selama siklus haid agar dapat dipastikan sedang tidak hamil.
- 2) Siklus haid pada hari pertama sampai hari ke tujuh
- 3) Segera setelah post partum, selama 48 jam pertama atau setelah 4 minggu post partum, setelah 6 bulan apabila menggunakan MAL
- 4) Setelah menderita abortus jika tidak ada tanda gejala terjadinya infeksi

l. Komplikasi

- 1) Merasakan sakit dan kejang selama kurang lebih 3-5 hari pasca pemasangan.
- 2) Perdarahan berat yang memungkinkan menyebabkan anemia pada waktu haid atau diantara haid
- 3) Perforasi dinding uterus (sangat jarang terjadi jika pemasangan tepat)

m. Keunggulan AKDR Pasca Plasenta:

- 1) Mengurangi rasa sakit saat dipasang karena ostium masih terbuka.
- 2) Merupakan kesempatan terbaik untuk memperoleh kontrasepsi karena klien mempunyai waktu terbatas untuk bertemu petugas kesehatan setelah itu.

- 3) Tidak meningkatkan risiko infeksi ataupun perforasi uterus
- 4) Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI sehingga aman untuk ibu menyusui.
- 5) Sebagai pilihan kontrasepsi bila klien belum dapat memutuskan apakah ingin menambah anak setelah melahirkan.
- 6) Kejadian ekspulsi yang rendah hamper sama dengan pemasangan 6 minggu pasca persalinan selama Teknik dilakukan dengan benar.

Waktu Pemasangan	Definisi	Angka Ekspulsi	Observasi
Pasca plasenta	Dalam 10 menit setelah plasenta lahir	9,5-12,5%	Ideal : angka ekspulsi rendah
Pascapersalinan Dini	10 menit – 48 jam Pascapersalinan	25-37 %	Cukup aman
Pascapersalinan lanjut	>48 jam – 4 minggu Pascapersalinan	Tidak direkomendasikan	Risiko tinggi perforasi, ekspulsi dan infeksi
Interval	>4minggu Pascapersalinan	3-13%	Aman

Gambar 6.3
Waktu Pemasangan AKDR. (HTA, 2009)

3. Kontrasepsi Implan

a. Definisi

Implant adalah alat kontrasepsi di bawah kulit (AKBK) atau lebih dikenal dengan susuk kb. Tidak ada kontraindikasi implant untuk KB pasca persalinan (KBPP). Jadi, implant 2 batang maupun 1 batang dapat diberikan segera pada ibu pascapersalinan.

b. Jenis implan:

- 1) Implan 2 batang mengandung 75mg levonorgestrel dengan lama kerja 4 tahun.
- 2) Implan 1 batang mengandung 68mg hormon etonogestrel dengan lama kerja 3 tahun.

c. Cara kerja :

- 1) Mencegah ovulasi (sel telur dari ovarium dicegah pelepasannya)
- 2) Sel telur dan sel sperma dihambat pertemuannya oleh lendir serviks (lendir serviks mengalami pengentalan).
- 3) Lapisan Rahim menipis sehingga sperma sulit membuahi sel telur.

d. Efektivitas:

Jika pemasangan kontrasepsi implant dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar pelayanan, memberikan efektivitas hingga 99% dalam mencegah kehamilan. Kontrasepsi implan dapat digunakan selama 3-5 tahun. Setelah dilakukan pelepasan implan, kesuburan akan segera kembali.

e. Keuntungan

- 1) Efektif mencegah kehamilan
- 2) Perlindungan selama 5 tahun
- 3) Kesuburan cepat kembali setelah pencabutan
- 4) Tidak memerlukan pemeriksaan dalam
- 5) Tidak mengganggu senggama
- 6) Dapat digunakan ibu menyusui, karena tidak mengganggu produksi ASI.
- 7) Dapat cabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan
- 8) Mengurangi jumlah darah haid sehingga dapat mencegah anemia

f. Kerugian

- 1) Inseri dan pengeluaran harus dilakukan tenaga terlatih
- 2) Tidak dapat mencegah Infeksi Menular Seksual (IMS)
- 3) Dapat mengakibatkan perubahan pola menstruasi

g. Klien yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan menjadi akseptor kontrasepsi implan:

- 1) Klien yang diperbolehkan menjadi akseptor kontrasepsi implan:
 - a) Dalam usia reproduksi
 - b) Telah memiliki anak maupun belum memiliki anak
 - c) Menghendaki kontrasepsi jangka panjang
 - d) Sedang menyusui dan membutuhkan kontrasepsi
 - e) Pasca keguguran atau memiliki riwayat kehamilan ektopik
 - f) Memiliki riwayat anemia atau sedang menderita anemia
- 2) Klien yang diperbolehkan menjadi akseptor kontrasepsi implan:
 - a) Perempuan dengan perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya.
 - b) Perempuan yang tidak dapat menerima perubahan pola haid yang sedang dialaminya
 - c) Perempuan dengan benjolan/kanker payudara atau riwayat kanker payudara.

h. Waktu pemasangan

- 1) Menstruasi teratur atau berganti dari metode kontrasepsi hormonal:
 - a) Dapat dilakukan pemasangan pada bulan tersebut

- b) Jika mulai dalam 7 hari setelah permulaan menstruasi, tidak perlu metode kontrasepsi tambahan.
- c) Jika mulai dari 7 hari setelah permulaan menstruasi, implan dapat dipasang kapan saja jika yakin tidak hamil. Perlu menggunakan metode kontrasepsi tambahan untuk 7 hari pertama setelah pemasangan.
- 2) Berganti metode kontrasepsi hormonal lainnya
 Segera, jika klien konsisten dan benar menggunakan metode hormonal atau klien yakin tidak hamil. Tidak perlu menunggu menstruasi bulan berikutnya. Tidak perlu metode kontrasepsi tambahan.
- 3) ASI eksklusif/hampir eksklusif <6 bulan setelah melahirkan:
 - a) Jika belum menstruasi, implan dapat dipasang kapan saja diantara waktu melahirkan sampai dengan 6 bulan. Tidak perlu menggunakan metode kontrasepsi tambahan.
 - b) Jika telah menstruasi, implan dapat dipasang seperti yang dianjurkan pada perempuan yang memiliki siklus menstruasi.
- 4) ASI eksklusif :
 - a) Jika belum menstruasi, implan dapat dipasang kapan saja jika yakin tidak hamil. Perlu metode kontrasepsi tambahan untuk 7 hari pertama setelah pemasangan.
 - b) Jika telah menstruasi, implan dapat dipasang seperti yang dianjurkan pada perempuan yang memiliki siklus menstruasi.
- 5) ASI tidak eksklusif jika belum menstruasi
 Jika belum menstruasi, implan dapat dipasang kapan saja yakin tidak hamil. Perlu metode kontrasepsi tambahan untuk 7 hari pertama setelah pemasangan.
- 6) ASI tidak eksklusif jika telah menstruasi
 Jika telah menstruasi, implan dapat dipasang seperti yang dianjurkan pada perempuan yang memiliki siklus menstruasi
- 7) Tidak menyusui < 4 minggu setelah melahirkan
 Implan dapat dipasang kapan saja. Tidak perlu metode kontrasepsi tambahan.
- 8) Tidak menyusui > 4 minggu setelah melahirkan:
 - a) Jika belum menstruasi, implan dapat dipasang kapan saja, jika yakin tidak hamil. Perlu menggunakan metode kontrasepsi tambahan untuk 7 hari pertama setelah pemasangan.
 - b) Jika telah menstruasi, implan dapat dipasang seperti yang dianjurkan pada perempuan yang memiliki siklus menstruasi.

- 9) Tidak menstruasi (tidak berhubungan dengan melahirkan dan menyusui)
Implan dapat dipasang kapan saja jika yakin tidak hamil. Perlu metode kontrasepsi tambahan untuk 7 hari pertama setelah pemasangan.

i. Efek samping

- 1) Gangguan haid: klien mengalami amenore (tidak haid), bercak-bercak haid, menoragia (siklus haid yang berkepanjangan). Hal ini umumnya terjadi dalam 3-6 bulan setelah pemasangan dan secara bertahap akan hilang.
- 2) Kenaikan berat badan: akseptor kontrasepsi implant sering mengalami gangguan kenaikan berat badan karena hormone yang terkandung dalam kontrasepsi implant bisa meningkatkan nafsu makan dan penumpukan cairan tubuh yang menyebabkan kenaikan berat badan.
- 3) Nyeri payudara: disebabkan karena adanya ketidakseimbangan hormon, kondisi seperti ini akan hilang setelah 6 bulan pemasangan.
- 4) Jerawat: terjadinya banyak jerawat pada wajah akseptor kontrasepsi implant terjadi karena pengaruh hormon progesteron. Hal ini mempengaruhi kepercayaan diri akseptor kontrasepsi implan.

j. Komplikasi :

- 1) Infeksi pada tempat insersi
- 2) Ekspulsi
- 3) Nyeri hebat di bawah perut
- 4) Sakit kepala hebat

4. Kontrasepsi Tubektomi

Tubektomi merupakan metode permanen yang melibatkan prosedur pembedahan yang dilakukan pada bagian kedua saluran telur wanita yang mengakibatkan wanita tersebut tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Pada persalinan pervaginam dapat dilakukan hingga 48 jam pasca persalinan dengan minilaparotomi (jika tidak bisa dalam waktu 2 hari pasca persalinan, ditunda sampai 4-6 minggu). Sedangkan persalinan dengan seksio sesaria di laksanakan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKTRL). Jenis kontrasepsi ini tidak memerlukan lagi alat-alat kontrasepsi konvensional. Cara kontrasepsi ini baik sekali, karena kemungkinan untuk mengalami kehamilan kecil sekali. Kontrasepsi tubektomi tidak ada pengaruh terhadap ASI dan tumbuh kembang bayi

Faktor yang paling penting dalam pelaksanaan sterilisasi tidak boleh dilakukan pada:

- a. Wanita belum/tidak menikah, pasangan yang tidak harmonis atau hubungan perkawinan yang sewaktu-waktu terancam perceraian.
- b. Pasangan yang masih ragu menerima sterilisasi

Perlu dijadikan tolak ukur untuk mengambil keputusan untuk sterilisasi adalah jumlah anak dan usia istri.

5. Kontrasepsi Vasektomi

Vasektomi adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan oklusi vasa deferensia alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi tidak terjadi.

- a. Waktu mulai penggunaan: dapat dilakukan setiap saat
- b. Ciri-ciri khusus: tidak segera efektif karena perlu paling sedikit 20 ejakulasi (± 3 bulan) sampai benar-benar steril.
- c. Catatan: metode KB pria
- d. Indikasi kontrasepsi vasektomi :

Vasektomi merupakan upaya untuk menghentikan fertilis dimana fungsi reproduksi merupakan ancaman atau gangguan terhadap kesehatan pria dan pasangannya serta melemahkan ketahanan dan kualitas keluarga.

- a. Kondisi yang memerlukan perhatian khusus bagi tindakan vasektomi :
 - 1) Infeksi kulit pada daerah operasi
 - 2) Infeksi sistemik yang sangat mengganggu kondisi kesehatan klien
 - 3) Hidrokokel atau verikokel
 - 4) Hernia inguinalis
 - 5) Filariasis (elephantiasis)
 - 6) Undescensus testikularis
 - 7) Masa intraskotalis
 - 8) Anemia berat, gangguan pembekuan darah atau sedang menggunakan antikoagulasi

6. Kontrasepsi Pil

Merupakan metode kontrasepsi hormonal yang terdiri dari pil progestin (pil mini) dan pil kombinasi (estrogen+progesteron). Pil ini mengandung dosis kecil, bahan progestin sintesis dan memiliki sifat pencegahan kehamilan, terutama dengan mengubah mukosa leher rahim (merubah sekresi pada leher rahim), sehingga mempersulit pengangkutan sperma. Selain itu, juga mengubah endometrium (lapisan dalam rahim), sehingga menghambat perletakkan sel telur yang telah dibuahi.

- a. Waktu mulai penggunaan:
 - 1) Sebelum 6 minggu pasca persalinan, klien menyusui jangan menggunakan kontrasepsi progestin.
 - 2) Jika memakai MAL, tunda dulu hingga 6 bulan.
 - 3) Jika tidak menyusui, dapat segera dimulai

4) Jika tidak menyusui, lebih dari 6 minggu pasca persalinan atau sudah dapat haid, kontrasepsi progestin dapat dimulai setelah yakin klien tidak ada kehamilan.

b. Kontra indikasi pemakaian kontrasepsi pil:

Kontrasepsi pil tidak boleh diberikan pada wanita penderita hepatitis, radang pembuluh darah, kanker payudara atau kanker rahim, hipertensi, gangguan jantung, varises, perdarahan abnormal melalui vagina, diabetes, pembesaran kelenjar gondok (struma), penderita sesak napas, eksim dan migraine (sakit kepala yang berat pada sebelah kepala).

c. Efek samping pemakaian pil:

Pemakaian pil dapat menimbulkan efek samping berupa perdarahan diluar haid, rasa mual, bercak hitam di pipi (hiperpigmentasi), jerawat, penyakit jamur pada liang vagina (candidiasis), nyeri kepala dan penambahan berat badan.

7. Kontrasepsi Suntik

Merupakan metode kontrasepsi hormonal yang terdiri dari suntik progestin (suntikan 3 bulanan) dan suntikan kombinasi (suntikan 1 bulanan). Pada ibu yang tidak menyusui, suntikan progestin dapat diberikan segera setelah persalinan, dan suntik kombinasi dapat diberikan setelah 3 minggu pasca persalinan. Sedangkan bagi ibu yang menyusui, suntik progestin hanya bisa diberikan setelah 6 minggu pasca persalinan dan suntik kombinasi hanya bisa diberikan ketika bayi berusia 6 bulan atau lebih.

a. Keuntungan kontrasepsi suntik 3 bulan:

- 1) Risiko terhadap kesehatan kecil
- 2) Tidak berpengaruh pada hubungan suami istri
- 3) Tidak diperlukan pemeriksaan dalam
- 4) dapat digunakan jangka Panjang
- 5) efek samping sangat kecil
- 6) klien tidak perlu menyimpan obat suntik

b. Kerugian kontrasepsi suntik 3 bulan:

- 1) Gangguan haid. Siklus haid memendek atau memanjang, perdarahan banyak atau sedikit, spotting, tidak haid sama sekali.
- 2) Tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu
- 3) Permasalahan berat badan merupakan efek samping tersering
- 4) Terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian
- 5) Terjadi perubahan pada lipid serum pada penggunaan jangka Panjang
- 6) Pada penggunaan jangka panjang dapat menurunkan densitas tulang

7) Pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan pada vagina, menurunkan libido, gangguan emosi, sakit kepala, nervositas dan jerawat.

8. Kontrasepsi kondom:

Adalah penggunaan selubung/sarung karet untuk menghalangi sperma masuk ke uterus. Kondom dapat digunakan kapanpun atau sebagai kontrasepsi pasca persalinan sementara bila kontrasepsi lain harus ditunda. Apabila ibu atau pasangan HIV positif, maka apapun jenis kontrasepsi pasca persalinan yang dipilih harus dibarengi dengan pemakaian kondom sebagai pelindung ganda, karena kondom dapat mencegah kehamilan sekaligus mencegah penularan HIV dan IMS. Kontrasepsi kondom tidak ada pengaruh terhadap ASI atau tumbuh kembang bayi, sebaiknya gunakan kondom yang diberi pelicin

I. Penutup

Kontrasepsi pasca persalinan merupakan hal yang sangat penting yang harus diberikan pada ibu pasca persalinan, bertujuan untuk menurunkan angka mortalitas dan morbiditas pada ibu dan bayi. Akseptor kontrasepsi pasca persalinan, harus dipersiapkan sedini mungkin yaitu di mulai dari pemberian pengetahuan dan konseling mengenai kontrasepsi pasca persalinan pada ibu hamil trimester 3 pada saat ibu hamil memeriksakan kehamilannya di pelayanan kesehatan. saat ini lah ibu hamil memperoleh pengetahuan mengenai kontrasepsi pasca persalinan, diharapkan setelah diberikan konseling oleh petugas kesehatan, ibu dan suami saling berkomunikasi aktif mengenai kontrasepsi pasca persalinan, sehingga sudah dipersiapkan lebih matang lagi mengenai metode kontrasepsi apa yang akan digunakan pasca persalinan nanti. Hal ini membuat mudah dijalankannya proses pemasangan atau penggunaan kontrasepsi pasca persalinan. Pentingnya pengetahuan ibu mengenai kontrasepsi pasca persalinan, hal ini dapat meningkatkan minat ibu dalam penggunaan kontrasepsi pasca persalinan. Sehingga ibu pasca persalinan dapat mempersiapkan kehamilan berikutnya. (Wanda, 2025)

J. Referensi

- BKKBN. (2021). *Pedoman Pelayanan Kontrasepsi Dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI.
- Brahmana, I. B. (2024). *Risiko Kejadian Ekspulsi Pada Akseptor Kb Pascapersalinan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Direktorat Kesehatan Keluarga, D. J. (2021). *Pelayanan Kontrasepsi Bagi Dokter Dan Bidan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI.

- Fatonah, S., Fitriani, Sari, H., Insani, S. D., & Savita, R. (2023). *Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana*. Jakarta: Nuansa Fajar Cemerlang.
- Matahari, R., Utami, F. P., & Sugiharti, S. (2018). *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- RI, Kementrian. Kesehatan. (2019). *Panduan Pelayanan Pasca Persalinan Bagi Ibu Dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI.
- Roswandi, D. A., Widagda, M. E., & Dwiastuti, A. (2021). *Pendampingan Keluarga Ibu Hamil Dan Pasca Melahirkan*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kependudukan Dan Keluarga Berencana BKKBN.
- Wanda, & Nisa, Q. (2025). Hubungan Pengetahuan Dengan Minat Ibu Dalam Penggunaan Kontrasepsi Pasca Persalinan Di TPMB Sri Wahyuni. *Politeknik Kesehatan Surabaya*. <https://repo.poltekkes-surabaya.ac.id/10359/> <http://repo.poltekkes-surabaya.ac.id/id/eprint/10359>

BAB 7

INDIKATOR LUARAN IBU BAYI DAN AUDIT MUTU

A. Pendahuluan

Kualitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem kesehatan suatu negara. Upaya peningkatan kesehatan ibu dan bayi baru lahir tidak hanya berfokus pada proses pelayanan, tetapi juga pada luaran (outcome) yang dihasilkan, baik bagi ibu maupun bayinya. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi terhadap indikator luaran ibu–bayi menjadi komponen esensial dalam menjaga mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan yang aman, efektif, dan berkesinambungan.

Secara global, masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) menjadi tantangan serius bagi pelayanan kesehatan maternal. Menurut World Health Organization (WHO, 2023), lebih dari 95% kematian ibu dan bayi baru lahir terjadi di negara berpenghasilan menengah ke bawah, dan sebagian besar dapat dicegah melalui intervensi berbasis bukti yang efektif (WHO, 2023). Di Indonesia, meskipun terjadi penurunan AKI dan AKB dalam satu dekade terakhir, angka tersebut masih di atas target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, yaitu AKI <70 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB <12 per 1.000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya sistem pemantauan mutu pelayanan yang terintegrasi dengan analisis luaran ibu–bayi.

Konsep mutu pelayanan kesehatan maternal dan neonatal mencakup dimensi keamanan (*safety*), efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kesetaraan (*equity*), ketepatan waktu (*timeliness*), dan responsivitas terhadap kebutuhan ibu dan bayi. Dalam konteks keperawatan dan kebidanan, mutu pelayanan tidak hanya diukur dari proses klinis, tetapi juga dari luaran klinis dan non-klinis yang mencerminkan pengalaman, kenyamanan, serta kepuasan ibu dan keluarga.

Hubungan antara luaran klinis dan mutu pelayanan bersifat timbal balik: luaran yang baik menunjukkan keberhasilan penerapan praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*), sementara luaran yang buruk dapat menjadi sinyal adanya masalah dalam sistem pelayanan, kompetensi tenaga kesehatan, atau efektivitas intervensi. Oleh karena itu, pemantauan luaran ibu–bayi harus dilakukan secara sistematis menggunakan indikator yang valid, reliabel, dan sesuai konteks nasional maupun global.

Penerapan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based approach*) dalam menentukan indikator luaran menjadi kunci dalam meningkatkan mutu pelayanan maternal dan neonatal. Melalui integrasi data riset, audit klinis, dan praktik terbaik, tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi kesenjangan pelayanan, menilai efektivitas intervensi, serta merancang strategi perbaikan mutu yang berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi. Pendekatan ini juga memperkuat budaya reflektif di kalangan tenaga kesehatan untuk selalu meninjau dan memperbarui praktik klinis sesuai dengan bukti terbaru.

Dengan demikian, pembahasan dalam bab ini akan menyoroti konsep indikator luaran ibu dan bayi, hubungannya dengan mutu pelayanan, serta penerapan audit mutu berbasis bukti ilmiah. Melalui pemahaman ini, diharapkan pembaca dapat mengembangkan kemampuan analisis dalam menilai keberhasilan asuhan persalinan dan menyusui, serta berkontribusi pada peningkatan mutu pelayanan maternal dan neonatal secara berkelanjutan.

B. Indikator Luaran Ibu

Evaluasi terhadap keberhasilan pelayanan pascapersalinan tidak hanya diukur melalui proses asuhan, tetapi juga melalui indikator luaran (*outcome indicators*) yang mencerminkan hasil nyata dari intervensi yang diberikan kepada ibu. Indikator luaran berfungsi sebagai ukuran objektif terhadap efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan keperawatan serta kebidanan, sekaligus menjadi dasar dalam audit mutu dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

Menurut World Health Organization (WHO, 2022), indikator luaran maternal mencakup berbagai dimensi, mulai dari status kesehatan fisik dan psikologis ibu, kemampuan fungsional dalam merawat diri dan bayinya, hingga kepuasan terhadap pelayanan yang diterima. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan pascapersalinan tidak hanya diukur dari penurunan angka kematian atau morbiditas, tetapi juga dari sejauh mana ibu dapat mencapai pemulihan menyeluruh secara biologis, emosional, sosial, dan spiritual.

1. Indikator Klinis

Luaran klinis ibu merupakan ukuran keberhasilan asuhan persalinan dan masa nifas yang mencerminkan kondisi kesehatan fisik dan psikologis ibu setelah melahirkan. Pemantauan indikator klinis dilakukan untuk menilai efektivitas pelayanan maternal, mendeteksi komplikasi secara dini, serta memastikan bahwa intervensi yang diberikan telah sesuai dengan standar dan prinsip berbasis bukti (*evidence-based practice*). Evaluasi terhadap indikator ini menjadi bagian penting dalam sistem audit mutu pelayanan kesehatan maternal, dengan tujuan utama meningkatkan keselamatan serta kesejahteraan ibu pascapersalinan.

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu merupakan indikator utama yang mencerminkan mutu pelayanan kesehatan maternal di suatu wilayah (Syairaji *et al.*, 2024). AKI didefinisikan sebagai jumlah kematian perempuan yang terjadi selama kehamilan, persalinan, dan dalam waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, tanpa memperhitungkan lama dan tempat kehamilan, per 100.000 kelahiran hidup (Chen, Shiels and Uribe-Leitz, 2025)

Penyebab utama kematian ibu antara lain perdarahan postpartum, preeklamsia dan eklamsia, infeksi, serta komplikasi obstetri lainnya (Aukes *et al.*, 2021). Faktor tidak langsung seperti anemia berat dan penyakit penyerta juga berkontribusi terhadap tingginya AKI. Penurunan angka ini menunjukkan efektivitas sistem pelayanan yang responsif, keterjangkauan fasilitas kesehatan, serta kompetensi tenaga kesehatan yang baik.

Pemantauan AKI dilakukan melalui sistem informasi kesehatan maternal dan neonatal, serta ditindaklanjuti dengan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan merumuskan langkah-langkah perbaikan pelayanan.

b. Angka Morbiditas Maternal

Selain angka kematian, morbiditas maternal menjadi indikator penting dalam menilai mutu pelayanan persalinan. Morbiditas maternal menggambarkan adanya komplikasi atau gangguan kesehatan yang dialami ibu selama dan setelah persalinan, yang dapat memengaruhi kualitas hidup serta menimbulkan risiko terhadap keselamatan. Beberapa kondisi yang termasuk dalam morbiditas maternal meliputi (Amanuel, Dache and Dona, 2021):

- 1) Perdarahan postpartum, sebagai penyebab utama kematian ibu, umumnya disebabkan oleh atonia uteri, retensi jaringan plasenta, atau gangguan koagulasi.
- 2) Preeklamsia dan eklamsia, yang ditandai dengan hipertensi, proteinuria, serta manifestasi gangguan organ akibat peningkatan tekanan darah selama kehamilan.
- 3) Infeksi puerperium, yaitu infeksi yang terjadi setelah persalinan akibat ketidaksempurnaan prosedur aseptis atau retensi jaringan.
- 4) Komplikasi obstetri lain, seperti ruptur uteri, emboli air ketuban, serta komplikasi anestesi.

Pemantauan angka morbiditas dilakukan melalui pencatatan kasus rawat inap dan audit klinis maternal secara berkala. Evaluasi hasil audit digunakan untuk menilai efektivitas deteksi dini, penatalaksanaan, serta penerapan pedoman pelayanan maternal berbasis bukti.

c. Tingkat Anemia Postpartum

Anemia postpartum merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering dijumpai pada ibu pascapersalinan dan berdampak terhadap proses pemulihan, energi, serta produksi air susu ibu (ASI). Anemia postpartum adalah kondisi kadar hemoglobin <12 g/dL dalam 6 minggu setelah persalinan (Neef *et al.*, 2024).

Penyebab utama anemia postpartum meliputi kehilangan darah berlebih saat persalinan, kekurangan zat besi selama kehamilan, serta asupan gizi yang tidak memadai. Pemantauan kadar hemoglobin dan status nutrisi ibu perlu dilakukan secara berkala sebagai bagian dari perawatan pascapersalinan. Intervensi berbasis bukti mencakup suplementasi zat besi dan asam folat, peningkatan konsumsi makanan bergizi seimbang, serta pemantauan kepatuhan ibu terhadap terapi nutrisi.

d. Status Involusi Uterus dan Penyembuhan Luka Perineum atau Luka Sectio Caesarea

Proses involusi uterus merupakan indikator fisiologis penting yang menunjukkan pemulihan organ reproduksi setelah melahirkan. Involusi normal ditandai dengan penurunan tinggi fundus uteri sekitar 1 cm per hari dan kembali ke ukuran sebelum hamil dalam waktu 6 minggu pascapersalinan (Paliulyte *et al.*, 2017).

Selain involusi uterus, keberhasilan penyembuhan luka perineum atau luka operasi *sectio caesarea* (SC) juga menjadi bagian dari luaran klinis ibu. Penyembuhan luka yang baik mencerminkan pelaksanaan prinsip asepsis yang tepat, perawatan luka yang adekuat, serta status nutrisi dan imunitas ibu yang optimal. Penilaian penyembuhan luka dapat menggunakan **skala REEDA** (Redness, Edema, Ecchymosis, Discharge, Approximation) untuk mengevaluasi tingkat peradangan, pembengkakan, perdarahan, dan integritas jahitan (Alvarenga *et al.*, 2015).

e. Status Psikologis Ibu

Aspek psikologis merupakan bagian integral dari kesehatan ibu pascapersalinan yang perlu diperhatikan secara serius. Gangguan psikologis seperti depresi postpartum, kecemasan, dan stres emosional dapat memengaruhi proses menyusui, hubungan ibu dengan bayi, serta pemulihan kondisi fisik.

Depresi postpartum terjadi pada sekitar 10–20% ibu melahirkan (Abenova *et al.*, 2022). Kondisi ini dapat dipicu oleh perubahan hormonal, kelelahan, trauma persalinan, dan kurangnya dukungan sosial. Skrining kesehatan mental ibu nifas dianjurkan dilakukan menggunakan instrumen terstandar seperti

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) atau Postpartum Depression Screening Scale (PDSS) (Beck, 2024).

Pendekatan berbasis bukti menekankan pentingnya integrasi skrining psikologis dalam pelayanan pascapersalinan serta kolaborasi dengan psikolog, konselor, atau tenaga kesehatan jiwa untuk memberikan dukungan psikososial yang tepat.

2. Indikator Fungsional

Indikator fungsional merupakan ukuran keberhasilan asuhan yang menilai kemampuan ibu dalam menjalankan fungsi fisiologis dan peran sosialnya setelah melahirkan. Berbeda dengan indikator klinis yang menitikberatkan pada status kesehatan fisik, indikator fungsional lebih menekankan pada pemulihan fungsi adaptif, peran keibuan, dan kemampuan ibu untuk mempertahankan kesejahteraan diri serta bayinya.

Penilaian indikator fungsional dilakukan secara komprehensif untuk menilai keberhasilan praktik berbasis bukti, terutama dalam aspek menyusui, status gizi, serta kemandirian ibu pada periode nifas.

a. Keberhasilan Menyusui (Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif)

Keberhasilan menyusui merupakan indikator fungsional utama yang menggambarkan efektivitas asuhan persalinan dan pascapersalinan. Dua komponen penting dalam indikator ini adalah Inisiasi Menyusu Dini (IMD) **dan** pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah proses menyusui yang dilakukan dalam satu jam pertama setelah kelahiran, di mana bayi dibiarkan melakukan *skin-to-skin contact* dan mencari puting susu ibu secara alami. IMD terbukti dapat menurunkan risiko kematian neonatal hingga 22%, memperkuat ikatan emosional ibu dan bayi, serta mempercepat keluarnya kolostrum yang kaya antibodi (Raihana *et al.*, 2019).

ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain selama enam bulan pertama kehidupan bayi. Keberhasilan pemberian ASI eksklusif dipengaruhi oleh dukungan tenaga kesehatan, kesiapan ibu, dan lingkungan keluarga yang suportif. Indikator keberhasilan menyusui dapat dinilai dari:

- 1) Waktu pelaksanaan IMD (dalam satu jam setelah lahir).
 - 2) Proporsi bayi yang mendapat ASI eksklusif hingga usia enam bulan.
 - 3) Teknik menyusui yang benar (perlekatan, frekuensi, dan durasi).
 - 4) Persepsi ibu terhadap kenyamanan dan kepercayaan diri dalam menyusui.
- Pendekatan berbasis bukti menunjukkan bahwa intervensi edukatif, *lactation counseling*, serta dukungan kelompok sebaya (*peer support group*)

meningkatkan keberhasilan menyusui secara signifikan (Rodríguez-Gallego *et al.*, 2024).

b. Status Nutrisi Ibu

Status nutrisi ibu pascapersalinan merupakan aspek penting yang berpengaruh terhadap pemulihan kondisi tubuh, produksi ASI, serta kualitas hidup ibu secara keseluruhan. Ibu dengan gizi baik akan memiliki energi yang cukup untuk menjalankan aktivitas, mempercepat penyembuhan luka, dan mempertahankan kestabilan psikologis.

Penilaian status nutrisi dilakukan melalui parameter antropometri (berat badan, indeks massa tubuh), pemeriksaan laboratorium (hemoglobin, kadar albumin), serta asupan makanan harian. Kebutuhan energi ibu menyusui meningkat sekitar 500 kkal per hari dibandingkan kebutuhan sebelum hamil, dengan penekanan pada asupan protein, zat besi, kalsium, dan vitamin A (Michelle and Kominiarek, 2016). Indikator status nutrisi ibu dapat diukur melalui:

- 1) Kenaikan atau pemeliharaan berat badan yang adekuat selama masa nifas.
- 2) Kadar hemoglobin ≥ 12 g/dL.
- 3) Frekuensi konsumsi makanan bergizi seimbang minimal tiga kali sehari.
- 4) Kualitas dan kuantitas produksi ASI yang mencukupi kebutuhan bayi.

Pendampingan gizi berbasis bukti (*evidence-based nutritional counseling*) terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan praktik makan sehat ibu menyusui, serta menurunkan risiko anemia postpartum (Dewidar *et al.*, 2023)

c. Kemandirian Ibu dalam Perawatan Diri dan Bayi

Kemandirian ibu merupakan indikator penting yang menunjukkan keberhasilan proses adaptasi fisik dan psikologis setelah persalinan. Ibu yang mandiri mampu melakukan perawatan diri dan bayinya secara optimal, sehingga mengurangi risiko komplikasi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Aspek kemandirian mencakup kemampuan ibu dalam:

- 1) Melakukan aktivitas sehari-hari tanpa ketergantungan (mobilitas, kebersihan diri, nutrisi).
- 2) Melaksanakan perawatan bayi (menyusui, mengganti popok, menjaga kebersihan).
- 3) Mengenali tanda bahaya pada diri dan bayi serta mengambil keputusan untuk mencari pertolongan medis.
- 4) Mengelola waktu istirahat, emosi, dan dukungan sosial dengan baik.

Kemandirian ibu dapat dinilai melalui observasi langsung, wawancara terstruktur, atau penggunaan instrumen seperti *Postpartum Functional Status*

Questionnaire (PFSQ) (Zhao et al., 2024). Bukti ilmiah menunjukkan bahwa intervensi edukasi perinatal dan kunjungan rumah oleh perawat secara signifikan meningkatkan tingkat kemandirian ibu dalam perawatan diri dan bayinya (Mohammed et al., 2025)

3. Indikator Kepuasan

Indikator kepuasan ibu merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai mutu pelayanan kesehatan maternal, terutama pada periode pascapersalinan. Kepuasan mencerminkan pengalaman subjektif ibu terhadap pelayanan yang diterima, baik dari aspek klinis, emosional, maupun sosial. Dalam konteks asuhan berbasis bukti, kepuasan ibu tidak hanya menunjukkan keberhasilan teknis pelayanan, tetapi juga menggambarkan efektivitas komunikasi, empati, dukungan, dan keterlibatan tenaga kesehatan dalam memenuhi kebutuhan ibu secara holistik.

Penilaian indikator kepuasan perlu dilakukan secara sistematis karena berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan ibu terhadap fasilitas kesehatan, kepatuhan terhadap tindak lanjut, dan keberhasilan intervensi seperti menyusui eksklusif.

a. Kepuasan Ibu terhadap Pelayanan Kesehatan Pascapersalinan

Kepuasan ibu terhadap pelayanan pascapersalinan merupakan indikator yang menggambarkan tingkat penerimaan dan pengalaman positif ibu terhadap layanan yang diberikan selama masa nifas. Pelayanan pascapersalinan yang berkualitas harus mencakup aspek *continuity of care*, keterjangkauan, kompetensi tenaga kesehatan, serta penghormatan terhadap hak dan martabat ibu. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan ibu meliputi:

- 1) Kualitas komunikasi dan empati tenaga kesehatan. Ibu merasa puas bila petugas memberikan penjelasan yang jelas, mendengarkan keluhan, serta memperlakukan pasien dengan penuh hormat.
- 2) Keterlibatan ibu dalam pengambilan keputusan. Pelayanan yang menghargai otonomi ibu meningkatkan rasa percaya diri dan tanggung jawab terhadap kesehatannya.
- 3) Kenyamanan fasilitas dan aksesibilitas layanan. Lingkungan yang aman, bersih, serta kemudahan dalam memperoleh layanan turut meningkatkan kepuasan.
- 4) Keterpaduan layanan pascapersalinan. Adanya tindak lanjut melalui kunjungan rumah atau konsultasi daring menjadi salah satu bentuk dukungan berkelanjutan yang dihargai oleh ibu.

Kepuasan ibu dapat diukur menggunakan kuesioner terstandar seperti Maternal Satisfaction Questionnaire (MSQ) atau Client Satisfaction Survey

(CSS) (Mocumbi S et al., 2019). Dalam audit mutu pelayanan, indikator ini menjadi bahan evaluasi penting untuk peningkatan mutu komunikasi terapeutik, sistem rujukan, serta pengembangan pelayanan ramah ibu dan bayi.

b. Persepsi Ibu tentang Dukungan Menyusui dari Tenaga Kesehatan

Dukungan menyusui dari tenaga kesehatan merupakan determinan penting keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Persepsi ibu terhadap dukungan tersebut menjadi bagian dari indikator kepuasan yang mencerminkan efektivitas interaksi antara tenaga kesehatan dan ibu selama periode menyusui. Dukungan ini dapat berupa dukungan informasional, emosional, dan praktis, yang diberikan oleh tenaga kesehatan melalui edukasi, demonstrasi teknik menyusui, serta pemecahan masalah yang dihadapi ibu. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung ibu menyusui melalui implementasi *Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI)* dan konseling laktasi berbasis bukti (Walsh et al., 2023). Persepsi positif ibu terhadap dukungan menyusui dapat diidentifikasi melalui:

- 1) Penerimaan informasi yang jelas dan konsisten mengenai manfaat ASI dan teknik menyusui.
- 2) Adanya dukungan emosional saat menghadapi kesulitan (seperti nyeri payudara atau kekhawatiran produksi ASI).
- 3) Sikap tenaga kesehatan yang sabar, menghargai pilihan ibu, dan memberikan pendampingan berkelanjutan.
- 4) Akses terhadap konselor laktasi atau fasilitas *lactation corner* di layanan kesehatan.

Penelitian menunjukkan bahwa ibu yang merasa didukung oleh tenaga kesehatan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mempertahankan ASI eksklusif hingga enam bulan (Bengough et al., 2022). Dengan demikian, kepuasan terhadap dukungan menyusui merupakan indikator kunci dalam menilai keberhasilan program promosi ASI di fasilitas kesehatan dan komunitas.

C. Indikator Luaran Bayi

Keberhasilan pelayanan pascapersalinan tidak hanya diukur dari kondisi ibu, tetapi juga dari luaran kesehatan bayi sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses asuhan maternal dan neonatal. Indikator luaran bayi merupakan ukuran objektif dan subjektif yang digunakan untuk menilai status kesehatan, pertumbuhan, perkembangan, serta kesejahteraan bayi baru lahir hingga periode neonatal.

Indikator luaran bayi mencakup dimensi klinis, gizi, perkembangan, dan kepuasan keluarga, yang secara keseluruhan mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal di suatu fasilitas maupun wilayah (Muzigaba *et al.*, 2022). Pemantauan indikator ini sangat penting karena sebagian besar penyebab kematian neonatal dapat dicegah melalui asuhan pascapersalinan yang efektif, deteksi dini komplikasi, dan dukungan menyusui yang optimal.

1. Indikator Klinis

Indikator klinis pada bayi merupakan ukuran objektif yang digunakan untuk menilai hasil asuhan selama periode neonatal dan awal kehidupan. Indikator ini mencerminkan efektivitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, serta menjadi dasar dalam evaluasi mutu sistem pelayanan secara menyeluruh. Pemantauan luaran klinis bayi dilakukan secara teratur untuk mendeteksi gangguan kesehatan sedini mungkin, menilai efektivitas intervensi berbasis bukti, dan memastikan setiap bayi memiliki peluang tumbuh serta berkembang secara optimal.

a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. AKB merupakan indikator utama derajat kesehatan masyarakat karena sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan antenatal, perinatal, dan postnatal (Gonzalez and Gilleskie, 2017)

Faktor penyebab tingginya AKB meliputi kondisi gizi dan kesehatan ibu, komplikasi persalinan, infeksi, serta keterlambatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adekuat. Upaya penurunan AKB harus dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan mutu asuhan persalinan, promosi menyusui eksklusif, deteksi dini risiko bayi baru lahir, serta pelaksanaan kunjungan neonatal sesuai standar).

Pemantauan AKB di tingkat fasilitas kesehatan dilakukan melalui sistem pencatatan kelahiran dan kematian bayi, sedangkan di tingkat nasional dilakukan melalui Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak (SIKIA) **dan** Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI).

b. Angka Kematian Neonatal (AKN)

Angka Kematian Neonatal (AKN) menunjukkan jumlah kematian bayi dalam 28 hari pertama kehidupan per 1.000 kelahiran hidup. AKN sering digunakan sebagai indikator keberhasilan asuhan perinatal karena sebagian besar kematian neonatal berkaitan langsung dengan proses persalinan dan kondisi bayi baru lahir (Sampurna *et al.*, 2023)

Penyebab utama kematian neonatal antara lain asfiksia lahir, infeksi neonatal, prematuritas, dan hipotermia. Upaya pencegahan memerlukan penerapan *Essential Newborn Care (ENC)*, termasuk Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pencegahan hipotermia dengan metode *skin-to-skin contact*, serta pemberian ASI eksklusif.

Audit kematian neonatal menjadi bagian penting dari sistem Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk menilai penyebab langsung dan tidak langsung, serta merumuskan tindakan korektif dalam pelayanan kesehatan neonatal. Penurunan AKN menjadi salah satu target utama dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yaitu menurunkan kematian neonatal hingga di bawah 12 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

c. Angka Morbiditas Bayi

Angka morbiditas bayi mencakup kejadian penyakit atau komplikasi yang terjadi pada periode neonatal dan awal kehidupan. Pemantauan morbiditas penting dilakukan karena sebagian besar penyakit neonatal dapat dicegah melalui asuhan berbasis bukti. Jenis morbiditas yang sering terjadi pada bayi baru lahir antara lain:

- 1) Infeksi neonatal, termasuk sepsis, pneumonia, dan infeksi tali pusat. Faktor risiko meliputi persalinan tidak bersih, ketuban pecah dini, dan imunitas rendah.
- 2) Asfiksia neonatorum, yaitu kegagalan bayi untuk bernapas spontan segera setelah lahir, yang menjadi penyebab utama kematian neonatal dini. Pencegahan dilakukan dengan resusitasi neonatus sesuai pedoman *Helping Babies Breathe (HBB)*.
- 3) Hipotermia, yaitu suhu tubuh bayi $<36,5^{\circ}\text{C}$ akibat kehilangan panas yang berlebihan. Pencegahan melalui penghangatan segera setelah lahir, IMD, dan perawatan metode kanguru.
- 4) Ikterus neonatorum, yang dapat bersifat fisiologis atau patologis, perlu dipantau agar tidak berkembang menjadi ensefalopati bilirubin.
- 5) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), yaitu bayi dengan berat lahir <2.500 gram, berisiko tinggi terhadap komplikasi metabolik, infeksi, dan gangguan tumbuh kembang.

Pemantauan angka morbiditas dilakukan melalui catatan rekam medis bayi dan sistem pelaporan nasional. Analisis morbiditas digunakan dalam audit mutu untuk menilai penerapan standar asuhan neonatal dan efektivitas intervensi preventif di fasilitas kesehatan.

d. Status Pertumbuhan Bayi

Status pertumbuhan merupakan indikator penting yang menunjukkan kesehatan dan kesejahteraan bayi dalam jangka pendek maupun panjang. Pertumbuhan yang optimal mencerminkan keberhasilan praktik menyusui, kecukupan nutrisi, serta pengawasan kesehatan yang baik. Pemantauan pertumbuhan dilakukan dengan mengukur:

- 1) Berat badan, sebagai indikator sensitif terhadap status gizi dan kesehatan secara umum.
- 2) Panjang badan, untuk menilai pertumbuhan skeletal bayi.
- 3) Lingkar kepala, untuk memantau pertumbuhan otak dan perkembangan neurologis.

Penilaian dilakukan berdasarkan kurva pertumbuhan WHO (WHO Child Growth Standards) yang membedakan antara bayi laki-laki dan perempuan. Bayi dikatakan tumbuh normal apabila berada antara -2 SD hingga $+2$ SD dari median kurva pertumbuhan (Azriani *et al.*, 2025).

Keterlambatan pertumbuhan (*growth faltering*) dapat disebabkan oleh asupan gizi yang tidak adekuat, infeksi berulang, atau kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung. Pemantauan teratur dan konseling gizi pada ibu menyusui menjadi langkah strategis dalam mencegah gangguan pertumbuhan bayi.

2. Indikator Nutrisi

Indikator nutrisi bayi merupakan ukuran penting dalam menilai keberhasilan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, khususnya dalam memastikan pemenuhan kebutuhan gizi sejak awal kehidupan. Status nutrisi bayi sangat menentukan kualitas tumbuh kembang, ketahanan tubuh terhadap penyakit, serta potensi perkembangan kognitif di masa depan.

Pemantauan indikator nutrisi bayi didasarkan pada praktik menyusui yang optimal dan penilaian status gizi menggunakan parameter pertumbuhan yang terstandar secara internasional. Dalam konteks asuhan berbasis bukti, indikator nutrisi menjadi bagian integral dari audit mutu pelayanan kesehatan bayi baru lahir, yang bertujuan menjamin bayi memperoleh nutrisi terbaik sesuai rekomendasi World Health Organization (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).

a. Proporsi Bayi yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan indikator pertama keberhasilan nutrisi bayi dan menjadi praktik penting dalam asuhan segera setelah lahir. IMD adalah proses membiarkan bayi untuk melakukan kontak kulit dengan kulit (*skin-to-skin contact*) dengan ibunya segera setelah lahir dan mulai menyusui dalam satu jam pertama kehidupan.

IMD berperan penting dalam meningkatkan peluang keberhasilan menyusui eksklusif, menjaga kestabilan suhu tubuh bayi, serta memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi. Selain itu, kolostrum yang diperoleh melalui IMD mengandung antibodi penting untuk melindungi bayi dari infeksi dini. Indikator IMD diukur berdasarkan:

- 1) Persentase bayi yang mendapat IMD dalam waktu ≤ 1 jam setelah lahir.
- 2) Kepatuhan tenaga kesehatan terhadap prosedur IMD sesuai *Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI)*.
- 3) Dokumentasi pelaksanaan IMD dalam rekam medis atau register persalinan. Praktik IMD yang tinggi menunjukkan mutu pelayanan obstetri dan neonatal yang baik serta implementasi kebijakan rumah sakit sayang bayi secara konsisten (Makela *et al.*, 2023).

b. Proporsi Bayi yang Mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif merupakan indikator nutrisi yang paling strategis dalam menilai keberhasilan upaya pemenuhan kebutuhan gizi bayi. ASI eksklusif berarti bayi hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain, termasuk air putih, selama enam bulan pertama kehidupannya, kecuali obat atau vitamin sesuai indikasi medis (WHO, 2022).

ASI mengandung komposisi gizi ideal dan zat kekebalan yang tidak dapat digantikan oleh susu formula. Keberhasilan ASI eksklusif menurunkan risiko diare, infeksi saluran pernapasan, alergi, dan obesitas pada masa kanak-kanak. Indikator keberhasilan ASI eksklusif diukur berdasarkan:

- 1) Proporsi bayi usia 0–6 bulan yang menerima ASI eksklusif.
- 2) Lama durasi pemberian ASI tanpa tambahan makanan/minuman lain.
- 3) Frekuensi dan teknik menyusui yang sesuai dengan pedoman WHO.
- 4) Dukungan keluarga dan tenaga kesehatan terhadap keberlanjutan ASI eksklusif.

Menurut laporan Kemenkes RI (2023), peningkatan angka ASI eksklusif di Indonesia masih menjadi tantangan akibat berbagai faktor seperti kurangnya pengetahuan ibu, dukungan kerja yang terbatas, dan pengaruh pemasaran susu formula. Oleh karena itu, evaluasi indikator ini penting untuk memperkuat kebijakan dan intervensi promosi menyusui berbasis bukti.

c. Status Gizi Bayi Berdasarkan Kurva WHO

Status gizi bayi mencerminkan keseimbangan antara asupan nutrisi dan kebutuhan metabolik tubuh. Penilaian status gizi dilakukan dengan mengacu pada WHO Child Growth Standards (2006), yang menggunakan tiga parameter utama: berat badan menurut umur (BB/U), panjang badan menurut umur

(PB/U), dan berat badan menurut panjang badan (BB/PB). Kategori status gizi bayi menurut WHO, antara lain:

- 1) Gizi baik: berada antara -2 SD hingga $+2$ SD dari median kurva pertumbuhan.
- 2) Gizi kurang: di bawah -2 SD hingga -3 SD.
- 3) Gizi buruk: di bawah -3 SD.
- 4) Gizi lebih: di atas $+2$ SD.

Pemantauan status gizi bayi dilakukan secara rutin di fasilitas pelayanan kesehatan melalui kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi (Posyandu atau kunjungan rumah). Bayi dengan gizi baik menunjukkan keberhasilan praktik menyusui, kecukupan asupan energi, dan lingkungan keluarga yang mendukung. Sebaliknya, gangguan status gizi dapat mengindikasikan adanya masalah menyusui, penyakit infeksi, atau kondisi sosial ekonomi yang perlu ditangani segera. Pendekatan berbasis bukti menekankan pentingnya penggunaan alat ukur yang valid, pelatihan petugas dalam interpretasi kurva pertumbuhan, serta integrasi hasil pemantauan gizi ke dalam sistem audit mutu pelayanan neonatal.

3. Indikator Perkembangan

Indikator perkembangan bayi merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana bayi mencapai kemampuan atau keterampilan yang sesuai dengan usia kronologisnya. Perkembangan mencakup perubahan progresif dalam kemampuan motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional yang terjadi secara bertahap dan berkesinambungan. Pemantauan perkembangan bayi sangat penting karena keterlambatan pada salah satu aspek dapat menjadi tanda awal adanya gangguan neurologis, sensorik, atau stimulasi lingkungan yang tidak adekuat.

Dalam konteks pelayanan berbasis bukti, deteksi dini perkembangan bayi dilakukan secara sistematis dan terstandar untuk memastikan setiap bayi memperoleh intervensi yang tepat waktu dan efektif.

a. Deteksi Dini Perkembangan Bayi

Deteksi dini perkembangan bayi bertujuan untuk mengidentifikasi penyimpangan atau keterlambatan tumbuh kembang sejak dini sehingga dapat dilakukan intervensi segera. Pemeriksaan perkembangan dilakukan secara rutin mulai usia 0–24 bulan pada saat kunjungan neonatal, imunisasi, atau kunjungan ke posyandu.

Penilaian perkembangan mencakup empat domain utama, yaitu motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan sosial-emosional.

1) **Perkembangan Motorik Kasar**

Aspek motorik kasar meliputi kemampuan bayi dalam menggunakan otot-otot besar untuk melakukan gerakan tubuh, seperti mengangkat kepala, berguling, duduk, merangkak, berdiri, dan berjalan. Perkembangan motorik kasar mencerminkan maturasi sistem saraf pusat dan kekuatan otot bayi. Penilaian dilakukan melalui observasi dan stimulasi sederhana sesuai usia, misalnya:

- a) Mengangkat kepala pada usia 3 bulan.
- b) Berguling pada usia 4–6 bulan.
- c) Duduk tanpa bantuan pada usia 7–8 bulan.
- d) Berdiri dan berjalan dengan bantuan pada usia 9–12 bulan.

Keterlambatan motorik kasar dapat menjadi indikator adanya gangguan neurologis, hipotonus, atau kurangnya stimulasi lingkungan.

2) **Perkembangan Motorik Halus**

Motorik halus mencakup kemampuan bayi menggunakan otot-otot kecil untuk aktivitas yang lebih presisi, seperti menggenggam, memegang benda kecil, dan koordinasi mata-tangan. Contoh tahapan perkembangan normal antara lain:

- a) Menggenggam benda dengan refleks palmar pada usia 2–3 bulan.
- b) Memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lain pada usia 6 bulan.
- c) Menunjuk atau memegang benda kecil dengan jari pada usia 9–12 bulan.

Perkembangan motorik halus yang baik menunjukkan koordinasi saraf dan penglihatan yang optimal. Penilaian dilakukan melalui observasi interaksi bayi dengan objek di sekitarnya.

3) **Perkembangan Bahasa**

Kemampuan bahasa meliputi aspek reseptif (pemahaman) dan ekspresif (pengucapan). Tahapan perkembangan bahasa bayi secara umum meliputi:

- a) Mengeluarkan suara refleks seperti menangis pada usia 0–2 bulan.
- b) Mulai mengoceh atau *cooing* pada usia 3–4 bulan.
- c) Merespons suara dan memutar kepala ke arah sumber suara pada usia 5–6 bulan.
- d) Mengucapkan suku kata sederhana seperti “ma-ma” atau “da-da” pada usia 8–10 bulan.

Keterlambatan bicara dapat dipengaruhi oleh gangguan pendengaran, kurangnya stimulasi verbal, atau masalah perkembangan neurologis. Oleh karena itu, komunikasi aktif antara ibu dan bayi sangat penting untuk mendukung perkembangan bahasa.

4) **Perkembangan Sosial-Emosional**

Aspek sosial-emosional mencerminkan kemampuan bayi dalam berinteraksi dengan lingkungan, menunjukkan emosi, dan membangun keterikatan (*bonding*) dengan orang tua. Perkembangan sosial normal meliputi:

- a) Tersenyum sosial pada usia 2 bulan.
- b) Mengenali wajah orang tua dan merespons suara mereka pada usia 3–4 bulan.
- c) Menunjukkan rasa takut terhadap orang asing pada usia 8 bulan.
- d) Meniru ekspresi atau perilaku orang lain pada usia 12 bulan.

Stimulasi sosial-emosional yang baik, terutama melalui sentuhan, pelukan, dan komunikasi, berperan besar dalam pembentukan kelekatan aman (*secure attachment*) antara ibu dan bayi.

1. Instrumen dan Standar Penilaian Perkembangan

Penilaian perkembangan bayi di Indonesia dilakukan dengan menggunakan **Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)** yang direkomendasikan oleh Kemenkes RI. KPSP menilai empat domain perkembangan secara komprehensif sesuai kelompok usia dan dapat digunakan oleh tenaga kesehatan di layanan primer maupun komunitas. Selain KPSP, beberapa instrumen internasional juga digunakan, seperti:

- a. **Denver Developmental Screening Test II (DDST II)**
- b. **Ages and Stages Questionnaire (ASQ)**
- c. **Bayley Scales of Infant Development (BSID)**

Penggunaan instrumen terstandar memastikan penilaian perkembangan dilakukan secara objektif, reliabel, dan dapat dibandingkan antar populasi.

2. Intervensi Berbasis Bukti dalam Stimulasi Perkembangan

Hasil deteksi dini menjadi dasar bagi perawat dan tenaga kesehatan dalam memberikan intervensi stimulasi perkembangan yang tepat. Pendekatan berbasis bukti menekankan pentingnya:

- a. **Stimulasi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)** melalui permainan edukatif, sentuhan, dan komunikasi positif.
- b. **Keterlibatan orang tua** dalam aktivitas harian bayi untuk memperkuat interaksi emosional.
- c. **Kunjungan rumah** oleh tenaga kesehatan untuk memantau perkembangan bayi risiko tinggi.

Program *Early Childhood Development (ECD)* yang direkomendasikan WHO dan UNICEF telah terbukti meningkatkan kemampuan kognitif dan sosial bayi, serta menurunkan risiko keterlambatan perkembangan hingga 30%.

3. **Indikator Kepuasan Keluarga**

Indikator kepuasan keluarga merupakan ukuran penting dalam menilai mutu pelayanan kesehatan maternal dan neonatal secara komprehensif. Kepuasan keluarga mencerminkan sejauh mana pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan harapan, kebutuhan, dan nilai-nilai keluarga terhadap perawatan ibu dan bayi. Dalam konteks pelayanan berbasis bukti, keterlibatan keluarga tidak hanya berfungsi sebagai pendukung emosional, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam proses perawatan. Oleh karena itu, persepsi dan kepuasan keluarga perlu dievaluasi sebagai bagian integral dari **audit mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan**.

a. **Persepsi Keluarga terhadap Kesehatan Bayi**

Persepsi keluarga terhadap kesehatan bayi merupakan gambaran subjektif mengenai kondisi fisik, perilaku, dan kesejahteraan bayi setelah lahir. Persepsi ini dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya, tingkat pengetahuan, nilai budaya, serta komunikasi dengan tenaga kesehatan.

Keluarga dengan pemahaman yang baik tentang kondisi bayi cenderung lebih tenang, percaya diri, dan aktif dalam mendukung perawatan bayi, termasuk praktik menyusui, pemantauan tumbuh kembang, serta imunisasi. Penilaian terhadap persepsi keluarga dapat dilakukan melalui wawancara atau kuesioner terstruktur yang mengevaluasi:

- 1) Pemahaman keluarga tentang tanda-tanda bayi sehat (misalnya refleks aktif, menyusu kuat, warna kulit normal, dan respons terhadap stimulasi).
- 2) Kemampuan keluarga mengenali tanda bahaya pada bayi (seperti demam, sesak napas, muntah berulang, atau tidak mau menyusu).
- 3) Tingkat kepercayaan diri keluarga dalam merawat bayi di rumah.
- 4) Sikap keluarga terhadap edukasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan.

Persepsi positif keluarga terhadap kesehatan bayi akan berhubungan dengan peningkatan kepatuhan terhadap perawatan neonatal, penurunan angka kunjungan ulang ke fasilitas kesehatan, dan peningkatan keberhasilan pemberian ASI eksklusif.

b. **Tingkat Kepuasan Keluarga terhadap Pelayanan Kesehatan Neonatal**

Kepuasan keluarga terhadap pelayanan kesehatan neonatal merupakan refleksi dari pengalaman keluarga dalam menerima layanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan selama periode neonatal. Indikator ini tidak hanya menilai kualitas teknis pelayanan, tetapi juga mencakup aspek komunikasi, empati,

aksesibilitas, serta keterlibatan keluarga dalam proses pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan keluarga meliputi:

- 1) **Kualitas komunikasi dan edukasi.** Keluarga merasa puas apabila tenaga kesehatan memberikan penjelasan yang jelas, mudah dipahami, dan disampaikan dengan sikap empatik.
- 2) **Keterlibatan keluarga dalam perawatan bayi.** Pelayanan yang mendorong partisipasi keluarga, seperti mendampingi bayi selama perawatan atau belajar teknik menyusui, meningkatkan kepuasan dan rasa memiliki terhadap proses asuhan.
- 3) **Ketersediaan dan kenyamanan fasilitas.** Lingkungan yang bersih, aman, serta ramah keluarga mendukung pengalaman positif selama perawatan neonatal.
- 4) **Konsistensi pelayanan.** Keluarga menghargai pelayanan yang terkoordinasi antara bidan, perawat, dan dokter dalam satu sistem yang terintegrasi.

Pengukuran kepuasan keluarga dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen seperti **Family Satisfaction** yang telah diadaptasi untuk konteks pelayanan neonatal, atau **Maternal and Neonatal Care Satisfaction Questionnaire (MNCSQ)** (Gulo et al., 2021). Kepuasan keluarga yang tinggi berkontribusi pada peningkatan kepercayaan terhadap sistem pelayanan kesehatan, memperkuat dukungan sosial terhadap ibu menyusui, serta menurunkan tingkat stres keluarga pada masa perawatan pascapersalinan.

D. Audit Mutu Pelayanan Pascapersalinan dan Menyusui

Audit mutu pelayanan kesehatan merupakan salah satu strategi utama dalam menjamin dan meningkatkan kualitas pelayanan berbasis bukti. Dalam konteks pelayanan pascapersalinan dan menyusui, audit mutu berfungsi sebagai alat evaluasi yang sistematis terhadap proses dan hasil pelayanan untuk memastikan bahwa praktik yang dilakukan telah sesuai dengan standar profesi, pedoman nasional, serta prinsip *evidence-based practice*.

1. Definisi Audit Mutu dalam Kesehatan

Audit mutu dalam bidang kesehatan didefinisikan sebagai proses evaluasi terencana dan sistematis terhadap mutu pelayanan kesehatan dengan membandingkan praktik yang dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan, dengan tujuan mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan langkah perbaikan berkelanjutan.

Audit mutu bukan sekadar penilaian administratif, tetapi merupakan mekanisme reflektif dan pembelajaran profesional yang mendorong peningkatan akuntabilitas, keselamatan pasien, dan efisiensi pelayanan.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI, 2023), audit mutu merupakan bagian integral dari sistem manajemen mutu rumah sakit dan puskesmas, serta digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan maternal–neonatal melalui *Audit Maternal dan Perinatal (AMP)*. Dalam konteks pascapersalinan, audit mutu berfokus pada:

- a. Kesesuaian asuhan ibu dan bayi dengan *Standar Asuhan Keperawatan dan Kebidanan*.
- b. Kepatuhan tenaga kesehatan terhadap pedoman klinis seperti *Pelayanan Nifas, Laktasi, dan Perawatan Bayi Baru Lahir*.
- c. Evaluasi terhadap luaran klinis, fungsional, nutrisi, dan kepuasan pasien serta keluarga.

Audit mutu juga dapat dilakukan melalui pendekatan klinis (clinical audit), proses (process audit), dan hasil (outcome audit), tergantung pada aspek pelayanan yang akan dievaluasi.

2. Tujuan dan Manfaat Audit Mutu pada Pelayanan Ibu dan Bayi

Audit mutu memiliki peran strategis dalam pengembangan sistem pelayanan kesehatan ibu dan bayi, karena memastikan setiap tindakan keperawatan dan kebidanan yang dilakukan bersifat aman, efektif, dan sesuai dengan bukti ilmiah terkini. Secara umum, tujuan audit mutu dalam pelayanan pascapersalinan dan menyusui meliputi:

- a. Menilai kesesuaian pelayanan terhadap standar.
Audit memungkinkan tenaga kesehatan untuk membandingkan praktik aktual dengan pedoman nasional maupun internasional, seperti *Standar Pelayanan Kebidanan (SPK)* dan *WHO Guidelines for Maternal and Newborn Care*.
- b. Mengidentifikasi kesenjangan mutu pelayanan
Audit membantu menemukan penyimpangan atau area yang perlu perbaikan, misalnya keterlambatan dalam IMD, rendahnya angka ASI eksklusif, atau rendahnya kepatuhan dokumentasi asuhan nifas.
- c. Meningkatkan keselamatan ibu dan bayi.
Melalui audit, risiko klinis dapat diidentifikasi lebih awal, sehingga langkah pencegahan dapat diterapkan untuk menghindari komplikasi atau kejadian yang tidak diinginkan (*adverse events*).
- d. Mendorong perbaikan berkelanjutan (continuous quality improvement).
Hasil audit digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana tindakan korektif dan pelatihan tenaga kesehatan, sehingga tercipta budaya kerja yang berorientasi pada mutu.
- e. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan.

Audit mutu memperkuat tanggung jawab profesional tenaga kesehatan dan institusi dalam memberikan pelayanan yang etis dan berkualitas.

Manfaat audit mutu dalam pelayanan ibu dan bayi tidak hanya meningkatkan efektivitas klinis, tetapi juga memperkuat koordinasi antarprofesi, memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

3. Jenis Audit

Audit mutu pelayanan kesehatan memiliki berbagai bentuk sesuai dengan tujuan, lingkup, dan fokus evaluasi yang dilakukan. Dalam pelayanan pascapersalinan dan menyusui, audit dapat dilakukan untuk menilai aspek klinis, keperawatan, sistem, maupun kepuasan pasien. Pemilihan jenis audit yang tepat akan membantu tenaga kesehatan memperoleh gambaran menyeluruh tentang efektivitas pelayanan, efisiensi sumber daya, serta tingkat kepuasan ibu dan keluarga terhadap layanan yang diberikan.

a. Audit Klinis (Clinical Audit)

Audit klinis merupakan bentuk audit yang paling umum dilakukan dalam pelayanan kesehatan, termasuk pada asuhan pascapersalinan dan menyusui. Audit ini berfokus pada evaluasi proses dan hasil pelayanan klinis dengan cara membandingkan praktik aktual terhadap standar atau pedoman klinis yang telah ditetapkan.

Tujuan utama audit klinis adalah meningkatkan kualitas pelayanan melalui identifikasi kesenjangan antara praktik dan standar, serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang terukur. Dalam konteks asuhan ibu dan bayi, audit klinis mencakup:

- 1) Kepatuhan terhadap protokol *Inisiasi Menyusu Dini (IMD)* dan pemberian ASI eksklusif.
- 2) Penatalaksanaan komplikasi pascapersalinan seperti perdarahan, infeksi, atau preeklamsia.
- 3) Evaluasi terhadap manajemen bayi baru lahir (misalnya pencegahan hipotermia, resusitasi neonatus, dan perawatan tali pusat).

Audit klinis dilaksanakan dalam siklus yang berkesinambungan: menetapkan standar → mengumpulkan data → membandingkan dengan standar → melakukan tindakan korektif → meninjau ulang hasil. Dengan demikian, audit klinis berperan sebagai alat pembelajaran profesional untuk meningkatkan keselamatan pasien dan efektivitas praktik berbasis bukti.

b. Audit Maternal dan Perinatal (AMP / MPA)

Audit Maternal dan Perinatal (AMP atau MPA) merupakan audit khusus yang bertujuan untuk menilai mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir dengan menelusuri penyebab kematian dan kesakitan maternal maupun perinatal. Audit ini dilakukan melalui telaah mendalam terhadap kasus kematian atau komplikasi berat yang dialami ibu dan bayi, dengan melibatkan tim multidisiplin yang terdiri dari dokter, bidan, perawat, dan tenaga manajemen.

Tujuan AMP adalah:

- 1) Mengidentifikasi penyebab langsung dan tidak langsung kematian ibu atau bayi.
- 2) Menilai faktor pelayanan dan sistem yang berkontribusi terhadap kejadian tersebut.
- 3) Merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Proses AMP meliputi:

- 1) Pengumpulan dan validasi data kasus.
- 2) Diskusi kasus secara tim (*case review meeting*).
- 3) Identifikasi faktor penyebab klinis dan sistemik.
- 4) Penetapan rekomendasi dan tindak lanjut.

Audit ini tidak bersifat menyalahkan, melainkan mengedepankan prinsip pembelajaran (*non-punitive learning*) untuk memperkuat sistem pelayanan maternal dan neonatal. Pelaksanaan AMP secara rutin dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi di negara berkembang.

c. Audit Keperawatan (Nursing Audit)

Audit keperawatan adalah proses evaluasi sistematis terhadap mutu asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien, dengan tujuan menilai sejauh mana pelaksanaan asuhan sesuai dengan Standar Asuhan Keperawatan (SAK) dan Kode Etik Profesi.

Dalam pelayanan pascapersalinan, audit keperawatan mencakup penilaian terhadap:

- 1) Kualitas pengkajian dan dokumentasi asuhan keperawatan ibu nifas dan bayi baru lahir.
- 2) Ketepatan diagnosis dan intervensi keperawatan terkait nyeri, risiko infeksi, atau masalah menyusui.
- 3) Pelaksanaan edukasi kesehatan dan dukungan psikososial terhadap ibu dan keluarga.

- 4) Efektivitas koordinasi antarprofesi dalam memberikan asuhan komprehensif.

Audit keperawatan dapat dilakukan dalam dua bentuk:

- 1) **Audit retrospektif**, yaitu menilai rekam medis dan catatan keperawatan setelah pelayanan selesai.
- 2) Audit prospektif, yaitu menilai proses keperawatan saat pelayanan sedang berlangsung.

Melalui audit ini, perawat dapat meninjau kembali praktik profesional, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar berbasis bukti.

d. Audit Berbasis Kepuasan Pasien

Audit berbasis kepuasan pasien berfokus pada pengalaman subjektif ibu dan keluarga selama menerima pelayanan kesehatan. Audit ini menilai sejauh mana pelayanan memenuhi kebutuhan, harapan, dan nilai-nilai pasien sebagai pengguna layanan.

Dalam konteks pelayanan pascapersalinan dan menyusui, aspek yang sering dievaluasi meliputi:

- 1) Kepuasan ibu terhadap komunikasi dan sikap tenaga kesehatan.
- 2) Dukungan tenaga kesehatan terhadap praktik menyusui.
- 3) Kenyamanan fasilitas rawat dan aksesibilitas layanan.
- 4) Persepsi keluarga terhadap keterlibatan mereka dalam perawatan bayi.

Instrumen yang dapat digunakan antara lain Maternal and Neonatal Care Satisfaction Questionnaire (MNCSQ) dan Patient Satisfaction Survey (PSS) (Khanam, Syed and Wagh, 2012).

Audit berbasis kepuasan pasien memberikan manfaat besar dalam meningkatkan dimensi humanistik pelayanan kesehatan, memperkuat hubungan terapeutik antara tenaga kesehatan dan pasien, serta menjadi indikator penting dalam sistem penjaminan mutu berbasis pasien (patient-centered quality assurance).

e. Tahapan Audit Mutu

Audit mutu pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui suatu proses yang sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan. Tahapan ini bertujuan untuk menjamin bahwa kegiatan audit tidak hanya menghasilkan evaluasi, tetapi juga menghasilkan perbaikan nyata terhadap mutu pelayanan ibu dan bayi.

Menurut World Health Organization (2021) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023), tahapan audit mutu mencakup enam langkah utama: penetapan standar pelayanan, identifikasi indikator, pengumpulan

data, analisis kesenjangan (gap analysis), perumusan rekomendasi perbaikan, serta implementasi dan monitoring hasil audit.

1) Penetapan Standar Pelayanan

Langkah pertama dalam audit mutu adalah menetapkan **standar pelayanan** sebagai acuan utama untuk menilai kualitas praktik yang dilakukan. Standar pelayanan merupakan pernyataan tertulis mengenai tingkat mutu yang diharapkan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, meliputi aspek struktur, proses, dan hasil (outcome).

Dalam pelayanan pascapersalinan dan menyusui, standar yang digunakan dapat mengacu pada:

- a) Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) dan Standar Pelayanan Kebidanan (SPK) dari Kemenkes RI.
- b) Pedoman WHO tentang Pelayanan Maternal dan Neonatal Berbasis Bukti (WHO, 2022).
- c) Standar Asuhan Keperawatan (PPNI, 2020) untuk konteks keperawatan pascapersalinan.

Penetapan standar memastikan bahwa seluruh anggota tim kesehatan memiliki persepsi yang sama mengenai mutu pelayanan yang diharapkan, serta menjadi dasar untuk menilai kepatuhan terhadap pedoman klinis.

2) Identifikasi Indikator

Tahap berikutnya adalah mengidentifikasi indikator mutu, yaitu ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Indikator berfungsi sebagai alat pengukuran objektif dalam audit, mencakup:

- a) Indikator input: ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas, dan sarana penunjang.
- b) Indikator proses: pelaksanaan prosedur pelayanan, kepatuhan terhadap protokol klinis, dan komunikasi terapeutik.
- c) Indikator output atau hasil: angka kematian ibu dan bayi, tingkat keberhasilan menyusui, status gizi bayi, dan kepuasan keluarga.

Pemilihan indikator harus memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) agar hasil audit dapat diukur dan dibandingkan secara valid.

3) Pengumpulan Data

Tahap ini melibatkan kegiatan pengumpulan dan dokumentasi data terkait pelaksanaan pelayanan di lapangan. Metode pengumpulan data dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif, tergantung pada tujuan audit dan jenis indikator yang dinilai.

Metode umum pengumpulan data meliputi:

- a) Telaah rekam medis dan dokumentasi keperawatan ibu serta bayi.
- b) Observasi langsung terhadap proses pelayanan di ruang rawat atau ruang laktasi.
- c) Wawancara dan kuesioner kepada tenaga kesehatan, ibu, dan keluarga untuk menilai aspek kepuasan atau komunikasi.
- d) Audit data statistik seperti angka kematian, morbiditas, dan capaian ASI eksklusif.

Data yang dikumpulkan harus memenuhi prinsip akurat, lengkap, dan reliabel, serta dijaga kerahasiaannya sesuai etika profesi.

4) Analisis Kesenjangan antara Standar dan Praktik Nyata (Gap Analysis)

Analisis kesenjangan atau *gap analysis* merupakan tahap inti dalam audit mutu. Pada tahap ini, data hasil pelaksanaan pelayanan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi area yang belum sesuai.

Langkah-langkah analisis kesenjangan mencakup:

- a) Membandingkan praktik aktual dengan standar. Misalnya, apakah seluruh bayi telah mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini dalam waktu 1 jam setelah lahir.
- b) Menilai tingkat deviasi atau ketidaksesuaian. Berapa persen praktik yang sudah sesuai dan mana yang perlu diperbaiki.
- c) Menganalisis penyebab kesenjangan. Faktor penyebab dapat berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan, prosedur yang belum efektif, atau kendala komunikasi antarprofesi.

Analisis ini menghasilkan informasi mendalam yang menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan mutu secara spesifik dan terukur.

5) Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan hasil analisis kesenjangan, tim audit menyusun rekomendasi perbaikan yang realistis, terukur, dan sesuai dengan konteks pelayanan. Rekomendasi dapat berupa:

- a) Perbaikan prosedur atau alur kerja (misalnya memperbarui SOP IMD atau pelaporan ASI eksklusif).
- b) Pelatihan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kompetensi klinis dan komunikasi terapeutik.
- c) Penguatan sistem dokumentasi dan koordinasi antarprofesi.
- d) Peningkatan fasilitas pendukung seperti ruang laktasi dan sarana edukasi keluarga.

Rekomendasi yang baik harus berbasis bukti (*evidence-based recommendation*) dan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia agar implementasinya efektif.

6) Implementasi dan Monitoring

Tahap terakhir adalah implementasi hasil audit serta pemantauan (monitoring) untuk menilai efektivitas tindakan korektif yang telah dilakukan. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa perbaikan yang direkomendasikan benar-benar menghasilkan peningkatan mutu pelayanan. Prinsip utama dalam tahap ini adalah perbaikan berkelanjutan (*continuous quality improvement / CQI*). Pelaksanaan monitoring mencakup:

- a) Menetapkan indikator keberhasilan pasca-audit.
- b) Melakukan evaluasi ulang (re-audit) setelah periode tertentu.
- c) Melibatkan seluruh anggota tim kesehatan dalam refleksi hasil dan tindak lanjut.

Hasil monitoring menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan mutu dan pembaruan pedoman klinis, sehingga audit mutu tidak berhenti sebagai laporan administratif, tetapi menjadi siklus pembelajaran berkelanjutan di fasilitas kesehatan.

f. Alat/Instrumen Audit Mutu

Pelaksanaan audit mutu pelayanan pascapersalinan dan menyusui memerlukan alat ukur yang valid, reliabel, dan sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Alat atau instrumen audit digunakan untuk menilai kesesuaian praktik pelayanan terhadap standar yang telah ditetapkan, mengidentifikasi area perbaikan, serta memantau perkembangan mutu pelayanan dari waktu ke waktu.

Instrumen yang digunakan dapat berupa checklist, indeks mutu, maupun sistem elektronik pemantauan mutu pelayanan yang terintegrasi dengan sistem informasi rumah sakit dan pelayanan primer. Pemilihan instrumen audit harus disesuaikan dengan jenis pelayanan, sumber daya, serta tujuan audit yang ingin dicapai.

1) Checklist Standar

Checklist merupakan alat audit yang paling sering digunakan dalam penilaian mutu pelayanan maternal dan neonatal. Checklist membantu tenaga kesehatan melakukan penilaian objektif terhadap kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standar yang telah ditetapkan.

a) Checklist WHO (World Health Organization)

WHO telah mengembangkan berbagai instrumen audit mutu yang dapat digunakan untuk menilai mutu pelayanan maternal dan neonatal, di antaranya:

- WHO Safe Childbirth Checklist (2015): digunakan untuk memastikan pelaksanaan langkah-langkah penting dalam asuhan persalinan aman, termasuk pencegahan infeksi, manajemen perdarahan postpartum, dan inisiasi menyusui dini (IMD).
- WHO Standards for Improving Quality of Maternal and Newborn Care (2016–2022): memuat indikator struktural, proses, dan hasil pelayanan yang menjadi acuan global dalam audit mutu.
- WHO Quality of Care Assessment Tool (2021): digunakan untuk mengukur kepatuhan terhadap pedoman klinis dan kepuasan pasien terhadap pelayanan maternitas dan neonatal.

b) Checklist Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Kemendes RI melalui Direktorat Kesehatan Keluarga telah mengadaptasi dan mengembangkan instrumen audit mutu pelayanan ibu dan bayi yang selaras dengan pedoman WHO, seperti:

- Instrumen Audit Maternal dan Perinatal (AMP), untuk menilai penyebab kematian ibu dan bayi serta efektivitas sistem pelayanan.
- Checklist Pelayanan Nifas dan Menyusui, yang memuat komponen pengkajian, pemantauan tanda bahaya, edukasi laktasi, dan dokumentasi asuhan.
- Instrumen Audit Mutu Puskesmas (AMP-PKM), yang menilai penerapan standar pelayanan di fasilitas kesehatan primer.

Checklist ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan penguatan sistem mutu di tingkat pelayanan dasar maupun rujukan.

2) Indeks Kualitas Pelayanan (Quality Index)

Indeks kualitas pelayanan (Quality Index) merupakan alat pengukuran yang lebih komprehensif dan kuantitatif untuk menilai mutu pelayanan berdasarkan berbagai dimensi, seperti keselamatan pasien, kepatuhan terhadap standar, efektivitas komunikasi, dan kepuasan pasien.

Indeks ini menilai mutu melalui tiga komponen: struktur, proses, dan hasil (structure–process–outcome). Komponen utama dalam indeks kualitas pelayanan keperawatan/midwifery meliputi:

- a) Struktur: jumlah dan kompetensi tenaga keperawatan/kebidanan, ketersediaan sarana, serta kebijakan pendukung mutu.

- b) Proses: pelaksanaan asuhan berdasarkan standar, ketepatan dokumentasi, edukasi pasien, dan koordinasi antarprofesi.
- c) Hasil (Outcome): meliputi indikator klinis (morbiditas, mortalitas), fungsional (kemandirian ibu), serta kepuasan pasien dan keluarga.

Setiap indikator diberi skor berdasarkan tingkat pencapaian, kemudian dihitung untuk menghasilkan indeks mutu total. Hasilnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan peningkatan mutu, pelatihan tenaga, serta pengambilan keputusan manajerial di fasilitas kesehatan.

3) Sistem Elektronik Monitoring Mutu Pelayanan (SIMRS, e-MPDSR)

Dalam era digitalisasi layanan kesehatan, audit mutu semakin banyak menggunakan sistem elektronik terintegrasi yang mempermudah pengumpulan, analisis, dan pelaporan data mutu pelayanan. Beberapa sistem yang digunakan di Indonesia antara lain:

a) SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)

SIMRS merupakan sistem elektronik yang mencatat seluruh aktivitas pelayanan pasien, termasuk asuhan pascapersalinan, perawatan bayi baru lahir, serta data mutu pelayanan seperti angka infeksi, durasi rawat, dan kepuasan pasien. Data dalam SIMRS dapat dimanfaatkan untuk audit internal, pelaporan kinerja, serta pengambilan keputusan berbasis data.

b) e-MPDSR (Electronic Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response)

e-MPDSR adalah sistem yang dikembangkan oleh Kemenkes RI bekerja sama dengan WHO untuk melakukan surveilans kematian ibu dan bayi secara elektronik. Tujuannya adalah memastikan setiap kematian maternal dan perinatal dapat dilaporkan, dianalisis, dan ditindaklanjuti secara cepat dan akurat. Sistem ini terintegrasi dengan data dari rumah sakit dan puskesmas, serta mendukung pelaksanaan audit kematian berbasis bukti (*data-driven mortality review*).

c) Sistem e-Monev Mutu Pelayanan KIA (Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Ibu dan Anak)

Sistem ini digunakan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk menilai capaian indikator mutu pelayanan ibu dan bayi, termasuk cakupan IMD, ASI eksklusif, kunjungan nifas, dan angka komplikasi pascapersalinan.

Keunggulan sistem elektronik adalah kemampuannya dalam menyediakan data real-time, meningkatkan efisiensi proses audit, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas mutu pelayanan.

g. Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Audit Mutu

Audit mutu pelayanan pascapersalinan dan menyusui tidak berhenti pada proses pengumpulan dan analisis data semata, tetapi harus diikuti oleh tindak lanjut dan evaluasi berkelanjutan. Tahapan ini merupakan inti dari *continuous quality improvement (CQI)* atau perbaikan mutu berkesinambungan, di mana hasil audit digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan strategis, serta pembaruan praktik klinis dan keperawatan.

Tindak lanjut dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil audit benar-benar diterapkan, berdampak terhadap peningkatan mutu pelayanan, serta mampu mengubah sistem kerja menjadi lebih efektif dan efisien.

4. Tujuan Tindak Lanjut Audit Mutu

Tindak lanjut audit mutu bertujuan untuk:

- a. Merealisasikan rekomendasi perbaikan yang dihasilkan dari audit.
- b. Menilai efektivitas tindakan korektif terhadap peningkatan mutu pelayanan.
- c. Menjamin keberlanjutan sistem mutu melalui siklus pembelajaran organisasi.
- d. Mendorong akuntabilitas profesional dan kelembagaan terhadap standar pelayanan yang berlaku.
- e. Memperkuat budaya keselamatan pasien serta meningkatkan kepuasan ibu dan keluarga.

Tahapan tindak lanjut yang efektif tidak hanya berfokus pada pemenuhan indikator mutu, tetapi juga pada perubahan perilaku organisasi dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*).

5. Tahapan Tindak Lanjut Audit Mutu

Pelaksanaan tindak lanjut audit mutu melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu:

a. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (Action Plan)

Rencana tindak lanjut disusun oleh tim mutu berdasarkan hasil rekomendasi audit. Dokumen ini mencakup tujuan perbaikan, langkah-langkah strategis, penanggung jawab, sumber daya yang dibutuhkan, dan jangka waktu pelaksanaan. Misalnya: peningkatan pelatihan manajemen laktasi untuk tenaga kesehatan atau penguatan pemantauan IMD melalui sistem elektronik.

1) Pelaksanaan Tindakan Korektif dan Preventif

Langkah ini mencakup implementasi nyata di lapangan untuk memperbaiki kesenjangan mutu yang ditemukan. Contoh: revisi Standar Operasional Prosedur (SOP), pengadaan sarana pendukung, atau pembentukan tim laktasi di fasilitas kesehatan.

a) Pemantauan (Monitoring) dan Supervisi

Kegiatan monitoring dilakukan secara berkala untuk menilai sejauh mana rencana perbaikan telah dilaksanakan sesuai target. Supervisi dilakukan oleh tim mutu atau manajemen fasilitas kesehatan untuk memberikan arahan dan umpan balik kepada pelaksana layanan.

b) Evaluasi Hasil dan Dampak (Re-audit)

Setelah periode tertentu (misalnya 6–12 bulan), dilakukan audit ulang (re-audit) untuk menilai efektivitas perbaikan yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini mencakup analisis perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah intervensi perbaikan, serta dampaknya terhadap indikator klinis, fungsional, dan kepuasan pasien.

c) Dokumentasi dan Diseminasi Hasil

Seluruh hasil tindak lanjut dan evaluasi harus didokumentasikan dengan baik sebagai bukti akuntabilitas dan bahan pembelajaran bagi seluruh tenaga kesehatan. Hasil tersebut dapat diseminasi melalui rapat mutu, laporan tahunan, seminar ilmiah, atau publikasi internal untuk mendorong budaya berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*).

6. Prinsip Evaluasi Hasil Audit Mutu

Evaluasi hasil audit mutu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a. Objektivitas dan transparansi – hasil evaluasi harus berbasis pada data dan bukti, bukan opini subjektif.
- b. Partisipatif dan kolaboratif – melibatkan tenaga kesehatan dari berbagai profesi (dokter, bidan, perawat, nutrisisionis, manajemen).
- c. Berkelanjutan (continuous) – evaluasi dilakukan secara periodik, bukan insidental.
- d. Berorientasi pada hasil (outcome-oriented) – fokus pada dampak nyata terhadap kesehatan ibu dan bayi.
- e. Berbasis bukti (evidence-based) – hasil evaluasi digunakan untuk memperbarui praktik klinis dan kebijakan pelayanan.

Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, evaluasi tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi menjadi alat transformasi mutu dalam pelayanan maternal dan neonatal.

7. Indikator Keberhasilan Tindak Lanjut

Keberhasilan tindak lanjut audit mutu dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain:

- a. Penurunan angka komplikasi pascapersalinan (perdarahan, infeksi, preeklamsia).
- b. Peningkatan cakupan IMD dan ASI eksklusif.
- c. Kenaikan skor kepuasan ibu dan keluarga terhadap pelayanan.

- d. Peningkatan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap SOP.
- e. Peningkatan kualitas dokumentasi dan pelaporan.

Apabila indikator-indikator tersebut menunjukkan tren perbaikan yang konsisten, maka audit mutu dinilai efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

8. Tantangan dalam Evaluasi Audit Mutu

Meskipun penting, evaluasi hasil audit sering menghadapi beberapa tantangan, seperti:

- a. Keterbatasan waktu dan sumber daya manusia untuk melaksanakan tindak lanjut.
- b. Kurangnya komitmen institusi terhadap pelaksanaan perbaikan berkelanjutan.
- c. Sistem dokumentasi yang belum terintegrasi dengan baik.
- d. Kesenjangan kompetensi tenaga kesehatan dalam analisis data dan manajemen mutu.

Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan pendekatan kolaboratif dan dukungan kebijakan institusional, seperti integrasi audit mutu ke dalam sistem manajemen kinerja dan akreditasi fasilitas kesehatan.

9. Implikasi terhadap Praktik Keperawatan

Bagi tenaga keperawatan, pelaksanaan tindak lanjut dan evaluasi audit mutu memiliki implikasi penting dalam:

- a. Meningkatkan tanggung jawab profesional dan akuntabilitas terhadap mutu pelayanan.
- b. Mendorong praktik berbasis bukti (evidence-based nursing practice).
- c. Memperkuat koordinasi interprofesional dalam pelayanan ibu dan bayi.
- d. Menumbuhkan budaya reflektif dan pembelajaran berkelanjutan.

Dengan demikian, audit mutu bukan hanya alat pengawasan, tetapi juga sarana pembinaan dan pengembangan kapasitas profesional keperawatan.

E. Tantangan dalam Monitoring Indikator dan Audit Mutu

Monitoring indikator dan audit mutu pelayanan pascapersalinan serta dukungan menyusui merupakan komponen penting dalam sistem peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Namun, pelaksanaannya di lapangan sering menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan kegiatan tersebut.

Tantangan ini tidak hanya bersumber dari keterbatasan teknis atau sumber daya, tetapi juga mencakup aspek sistemik, sosial, budaya, serta partisipasi keluarga sebagai bagian integral dari keberhasilan pelayanan maternal dan neonatal.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan monitoring indikator dan audit mutu adalah **terbatasnya jumlah serta kompetensi sumber daya manusia (SDM)** di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di tingkat primer dan daerah terpencil. Tenaga keperawatan, kebidanan, dan manajemen mutu sering kali memiliki beban kerja tinggi, sehingga waktu untuk melakukan audit dan monitoring menjadi terbatas.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti sistem informasi elektronik, peralatan audit, serta dukungan administrasi dapat menghambat proses pengumpulan dan analisis data mutu. Keterbatasan tersebut berimplikasi pada kurang optimalnya penerapan audit berbasis bukti dan rendahnya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi.

2. Variasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan

Variasi sistem pencatatan dan pelaporan antar fasilitas kesehatan juga menjadi tantangan signifikan. Meskipun Kementerian Kesehatan telah menerapkan sistem seperti Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak (e-Monev KIA) dan Sistem e-MPDSR (Electronic Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response), masih terdapat perbedaan format, indikator, dan mekanisme pelaporan antar wilayah. Kurangnya standarisasi dalam pencatatan data menyebabkan kesulitan dalam:

- a. Membandingkan capaian antar fasilitas kesehatan.
- b. Menilai tren mutu pelayanan secara nasional.
- c. Menentukan prioritas intervensi perbaikan.

Selain itu, pencatatan manual yang masih banyak digunakan meningkatkan risiko kesalahan data, kehilangan informasi, dan keterlambatan pelaporan hasil audit.

3. Kesenjangan antara Standar dan Praktik Lapangan

Dalam praktiknya, terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara standar pelayanan yang ditetapkan dan pelaksanaannya di lapangan. Beberapa penyebabnya antara lain:

- a. Kurangnya sosialisasi atau pelatihan mengenai standar pelayanan terkini.
- b. Keterbatasan waktu untuk menerapkan prosedur sesuai pedoman.
- c. Adanya kebiasaan atau praktik lama yang belum sesuai dengan prinsip *evidence-based care*.

Sebagai contoh, meskipun standar pelayanan menyusui menekankan pentingnya Inisiasi Menyusui Dini (IMD), pelaksanaannya masih belum optimal akibat kendala logistik, kurangnya pelatihan tenaga kesehatan, atau kebijakan rumah sakit yang belum mendukung pemberian ASI eksklusif.

Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pendekatan sistemik dalam memperkuat implementasi standar mutu, termasuk melalui pengawasan, supervisi, dan pembinaan berkelanjutan.

4. Faktor Budaya, Sosial, dan Ekonomi

Faktor budaya, sosial, dan ekonomi juga berpengaruh terhadap keberhasilan monitoring indikator dan audit mutu pelayanan. Nilai-nilai budaya dan kebiasaan masyarakat terkait kehamilan, persalinan, dan menyusui dapat memengaruhi praktik klinis maupun penerimaan intervensi kesehatan. Misalnya:

- a. Kepercayaan tradisional yang melarang pemberian kolostrum pada bayi baru lahir.
- b. Norma sosial yang menempatkan keputusan perawatan ibu pada anggota keluarga laki-laki.
- c. Hambatan ekonomi yang membatasi akses ibu terhadap layanan kesehatan pascapersalinan.

Faktor-faktor tersebut dapat menghambat keterlibatan ibu dan keluarga dalam penerapan standar pelayanan, serta memengaruhi hasil audit mutu. Oleh karena itu, pendekatan budaya (*cultural-sensitive approach*) diperlukan dalam proses evaluasi dan intervensi perbaikan mutu agar lebih kontekstual dan dapat diterima masyarakat.

5. Keterlibatan Keluarga dalam Mendukung Indikator Luaran

Keluarga memegang peran penting dalam keberhasilan luaran ibu dan bayi, terutama dalam mendukung praktik menyusui, perawatan diri ibu, dan pemantauan tumbuh kembang bayi. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan keluarga sering kali belum optimal karena:

- a. Kurangnya edukasi dan komunikasi dari tenaga kesehatan.
- b. Minimnya program partisipatif keluarga dalam audit mutu.
- c. Rendahnya kesadaran keluarga tentang pentingnya peran mereka dalam keberhasilan indikator klinis dan fungsional.

Sebagai contoh, kepatuhan terhadap pemberian ASI eksklusif dan kunjungan nifas sering dipengaruhi oleh dukungan suami atau orang tua. Oleh karena itu, pelibatan keluarga dalam monitoring indikator dan audit mutu harus menjadi bagian integral dari sistem evaluasi pelayanan kesehatan ibu dan bayi.

Upaya yang dapat dilakukan meliputi:

- a. Edukasi keluarga tentang indikator kesehatan ibu dan bayi.
- b. Pengembangan program *family-centered audit* yang melibatkan keluarga dalam proses umpan balik pelayanan.
- c. Peningkatan komunikasi terapeutik antara tenaga kesehatan dan keluarga.

F. Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Pascapersalinan

Upaya peningkatan mutu pelayanan pascapersalinan merupakan bagian integral dari sistem kesehatan yang berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi, efektivitas pelayanan, serta kepuasan keluarga.

Pendekatan peningkatan mutu tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi juga mencakup penguatan kebijakan, pengembangan kapasitas tenaga kesehatan, inovasi teknologi, dan keterlibatan keluarga serta komunitas dalam sistem pelayanan.

Menurut World Health Organization (WHO, 2022), peningkatan mutu pelayanan maternal dan neonatal harus dilakukan secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*), terintegrasi, serta berbasis bukti ilmiah. Berikut ini merupakan strategi utama yang dapat diterapkan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pascapersalinan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi

Kebijakan dan regulasi berperan sebagai fondasi utama dalam membangun sistem pelayanan pascapersalinan yang berkualitas dan berkesinambungan. Pemerintah dan institusi kesehatan perlu memastikan bahwa seluruh standar pelayanan dan audit mutu tertuang dalam peraturan resmi yang bersifat operasional dan mengikat. Langkah-langkah strategis mencakup:

- a. Penyusunan dan implementasi regulasi nasional tentang standar asuhan nifas dan menyusui berbasis bukti.
- b. Integrasi kebijakan mutu pelayanan ke dalam sistem akreditasi rumah sakit dan puskesmas.
- c. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi kebijakan melalui audit maternal dan neonatal secara berkala.
- d. Penegakan tata kelola klinis (clinical governance) untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi mutu pelayanan.

Dengan adanya kebijakan yang kuat, setiap tenaga kesehatan memiliki landasan hukum dan etika yang jelas dalam melaksanakan pelayanan sesuai standar.

2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan

Kualitas pelayanan sangat ditentukan oleh kompetensi tenaga kesehatan yang terlibat dalam asuhan ibu dan bayi pascapersalinan. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pelatihan berbasis bukti (*evidence-based training*), sertifikasi kompetensi, serta supervisi klinis berkelanjutan.

Fokus utama peningkatan kapasitas tenaga kesehatan meliputi:

- a. Pelatihan manajemen laktasi dan dukungan menyusui.

- b. Penatalaksanaan komplikasi pascapersalinan (perdarahan, infeksi, preeklamsia, depresi postpartum).
- c. Keterampilan komunikasi terapeutik dan konseling keluarga.
- d. Pelatihan penggunaan teknologi digital dalam audit mutu dan telemonitoring.

Pelatihan berkelanjutan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan klinis, tetapi juga memperkuat sikap profesional, empati, dan kemampuan reflektif tenaga kesehatan.

3. Integrasi Pelayanan Berbasis Keluarga dan Komunitas

Pendekatan berbasis keluarga dan komunitas (*family and community-based care*) menjadi strategi efektif dalam memperkuat kesinambungan pelayanan ibu dan bayi. Model ini menempatkan keluarga sebagai mitra utama tenaga kesehatan dalam mendukung pemulihan fisik dan psikologis ibu serta tumbuh kembang bayi. Implementasi integrasi ini meliputi:

- a. Peningkatan peran keluarga dalam pemantauan ibu dan bayi di rumah.
- b. Kolaborasi lintas sektor dan lintas profesi dengan kader posyandu, bidan desa, dan perawat komunitas.
- c. Edukasi dan pemberdayaan keluarga tentang ASI eksklusif, perawatan luka perineum, tanda bahaya nifas, dan stimulasi bayi.
- d. Pemantauan berbasis komunitas (*community surveillance*) untuk mendeteksi dini risiko komplikasi pascapersalinan.

Dengan demikian, pelayanan pascapersalinan tidak hanya berorientasi pada rumah sakit, tetapi menjadi bagian dari sistem kesehatan berbasis masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Pendekatan Continuity of Care Ibu–Bayi

Konsep *continuity of care* (CoC) menekankan kesinambungan pelayanan dari masa kehamilan, persalinan, hingga masa nifas dan menyusui. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap ibu dan bayi mendapatkan pelayanan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan oleh tenaga kesehatan yang sama atau dalam sistem yang terintegrasi.

Prinsip utama CoC meliputi:

- a. Koordinasi lintas fasilitas dan profesi (bidan, perawat, dokter, nutrisisionis).
- b. Pencatatan terintegrasi antara layanan antenatal, intrapartum, dan postnatal.
- c. Pendampingan ibu secara berkelanjutan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
- d. Pemantauan ibu dan bayi hingga 42 hari setelah persalinan.

5. Pemanfaatan Teknologi Digital (mHealth, Telehealth, e-Audit)

Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu inovasi penting dalam peningkatan mutu pelayanan pascapersalinan. Teknologi ini tidak hanya mempermudah komunikasi dan pemantauan pasien, tetapi juga mempercepat proses audit mutu dan pengambilan keputusan berbasis data.

Beberapa bentuk teknologi yang relevan antara lain:

- a. mHealth (mobile health): aplikasi berbasis ponsel untuk pemantauan kesehatan ibu dan bayi, pengingat kunjungan nifas, dan edukasi laktasi.
- b. Telehealth dan telekonsultasi: layanan jarak jauh untuk konseling menyusui, pendampingan psikologis, dan deteksi dini komplikasi.
- c. e-Audit atau e-MPDSR: sistem digital untuk memantau hasil audit maternal dan perinatal secara real-time.
- d. Dashboard mutu pelayanan: menampilkan capaian indikator kinerja secara visual dan interaktif.

Pemanfaatan teknologi digital mempercepat pertukaran informasi antarprofesi, memperkuat akurasi pelaporan, dan mendukung pengambilan keputusan klinis berbasis bukti (*data-driven decision making*).

6. Sistem Reward and Punishment bagi Tenaga Kesehatan dan Instansi

Penerapan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system) merupakan strategi efektif untuk memotivasi tenaga kesehatan dan institusi dalam mempertahankan mutu pelayanan. Sistem ini bertujuan untuk memberikan penguatan positif terhadap kinerja yang baik dan penegakan disiplin terhadap pelanggaran standar pelayanan.

Contoh penerapan:

- a. Reward: penghargaan kinerja, insentif mutu pelayanan, atau pengakuan profesional bagi tenaga yang berprestasi dalam pelaksanaan audit dan peningkatan mutu.
- b. Punishment: pembinaan atau sanksi administratif bagi pelanggaran standar prosedur atau kelalaian dalam pelayanan ibu dan bayi.

Penerapan sistem ini harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis indikator kinerja, sehingga menumbuhkan budaya tanggung jawab bersama dalam menjaga mutu pelayanan maternal dan neonatal.

G. Penutup

Pelayanan pascapersalinan dan dukungan menyusui merupakan tahap krusial dalam siklus kehidupan ibu dan bayi, yang sangat menentukan keberhasilan adaptasi fisiologis, psikologis, serta kesejahteraan jangka panjang. Untuk menjamin

mutu pelayanan pada periode ini, diperlukan sistem indikator luaran dan audit mutu yang terstruktur, komprehensif, dan berbasis bukti ilmiah.

Indikator luaran ibu mencakup dimensi klinis, fungsional, dan kepuasan, yang digunakan untuk menilai keberhasilan pemulihan pascapersalinan, status psikologis, dan keberhasilan menyusui. Sementara itu, indikator luaran bayi meliputi aspek klinis, nutrisi, perkembangan, dan kepuasan keluarga, yang menggambarkan efektivitas asuhan neonatal dan dukungan keluarga dalam memastikan tumbuh kembang optimal bayi.

Pemantauan kedua kelompok indikator tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas pelayanan maternal dan neonatal, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan intervensi perbaikan berkelanjutan. Melalui pengukuran indikator yang konsisten dan akurat, tenaga kesehatan dapat mendeteksi lebih dini adanya kesenjangan mutu, mengidentifikasi risiko, serta mengevaluasi efektivitas intervensi yang diberikan.

Audit mutu berperan penting sebagai alat pengendalian dan peningkatan kualitas pelayanan. Melalui siklus audit—mulai dari penetapan standar, identifikasi indikator, pengumpulan data, analisis kesenjangan, hingga tindak lanjut—fasilitas kesehatan dapat memastikan bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Audit mutu juga berfungsi sebagai sarana refleksi dan pembelajaran organisasi, mendorong budaya akuntabilitas, serta memperkuat praktik keperawatan berbasis bukti (*evidence-based practice*).

Secara keseluruhan, penerapan indikator luaran dan audit mutu memiliki harapan besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan pascapersalinan. Dengan implementasi yang konsisten, sistem ini mampu:

1. Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui deteksi dini komplikasi dan intervensi tepat waktu.
2. Meningkatkan keberhasilan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif melalui dukungan sistematis terhadap ibu dan keluarga.
3. Meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan ibu-bayi sebagai cerminan keberhasilan pelayanan keperawatan yang holistik dan humanistik.

Oleh karena itu, kolaborasi antara tenaga kesehatan, keluarga, dan manajemen fasilitas kesehatan menjadi kunci keberhasilan dalam menerapkan indikator dan audit mutu. Pendekatan komprehensif ini akan memperkuat sistem pelayanan maternal–neonatal yang aman, efektif, berkesinambungan, dan berorientasi pada kualitas hidup ibu dan bayi.

H. Referensi

- Abenova, M. *et al.* (2022) 'Prevalence of postpartum depression and its associated factors within a year after birth in Semey, Kazakhstan: A cross sectional study', *Clinical Epidemiology and Global Health*, 16(June), p. 101103. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2022.101103>.
- Alvarenga, M.B. *et al.* (2015) 'Episiotomy healing assessment: Redness, oedema, ecchymosis, discharge, approximation (REEDA) scale reliability', *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 23(1), pp. 162–168. Available at: <https://doi.org/10.1590/0104-1169.3633.2538>.
- Amanuel, T., Dache, A. and Dona, A. (2021) 'Postpartum Hemorrhage and its Associated Factors Among Women who Gave Birth at Yirgalem General Hospital, Sidama Regional State, Ethiopia', *Health Services Research and Managerial Epidemiology*, 8, pp. 1–7. Available at: <https://doi.org/10.1177/23333928211062777>.
- Aukes, A.M. *et al.* (2021) 'Causes and circumstances of maternal death: a secondary analysis of the Community-Level Interventions for Pre-eclampsia (CLIP) trials cohort', *The Lancet Global Health*, 9(9), pp. e1242–e1251. Available at: [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(21\)00263-1](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(21)00263-1).
- Azriani, D. *et al.* (2025) 'Prediction models for stunting at 2-years-old from Indonesian newborn population', *BMC Pediatrics*, 25(1), pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/10.1186/s12887-025-06096-4>.
- Beck, C. (2024) 'Postpartum Depression Screening Scale: Its Availability for Use', *Journal of the American Psychiatric Nurses Association*, 30(5), pp. 896–905.
- Bengough, T. *et al.* (2022) 'Factors that influence women's engagement with breastfeeding support: A qualitative evidence synthesis', *Maternal and Child Nutrition*, 18(4), pp. 1–29. Available at: <https://doi.org/10.1111/mcn.13405>.
- Chen, Y., Shiels, M.. and Uribe-Leitz, T. (2025) 'Pregnancy-Related Deaths in the US, 2018-2022', *JAMA Network Open*, 8(4), p. e254325.
- Dewidar, O. *et al.* (2023) 'Effectiveness of nutrition counseling for pregnant women in low- and middle-income countries to improve maternal and infant behavioral, nutritional, and health outcomes: A systematic review', *Campbell Systematic Reviews*, 19(4), pp. 1–89. Available at: <https://doi.org/10.1002/cl2.1361>.
- Gonzalez, R.M. and Gilleskie, D. (2017) 'Infant Mortality Rate as a Measure of a Country's Health: A Robust Method to Improve Reliability and Comparability', *Demography*, 54(2), pp. 701–720. Available at: <https://doi.org/10.1007/s13524-017-0553-7>.

- Gulo, B. *et al.* (2021) 'Parents' Experience and Satisfaction in Neonatal Intensive Care Units in Ethiopia: A Multicenter Cross-Sectional Study Using an Adapted Version of EMPATHIC-N', *Frontiers in Pediatrics*, 9(October), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.3389/fped.2021.738863>.
- Kemenkes (2024) *Profil Kesehatan Indonesia 2023*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2023) *Pedoman Audit Maternal dan Perinatal (AMP) dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Khanam, N., Syed, Z.Q. and Wagh, V. (2012) 'Patient Satisfaction on Maternal and Child Health Services', *Indian Medical Gazette*, 2(11), pp. 47–51.
- Makela, H. *et al.* (2023) 'Exclusive breastfeeding, breastfeeding problems, and maternal breastfeeding attitudes before and after the baby-friendly hospital initiative: A quasi-experimental study', *Sexual and Reproductive Healthcare*, 35(June 2022), pp. 1–7. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.srhc.2022.100806>.
- Michelle, A. and Kominiarek, M. (2016) 'Nutrition Recommendation in pregnancy and Lactation', *Med Clin North Am.*, 100(6), pp. 1199–1215. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.mcna.2016.06.004>.Nutrition.
- Mocumbi S *et al.* (2019) 'Mothers' satisfaction with care during facility-based childbirth: A cross-sectional survey in southern Mozambique. BMC Pregnancy and Childbirth [revista en Internet] 2019 [acceso 17 de setiembre de 2024]; 19(1): 1-14.', *BMC pregnancy and childbirth*, 19(303), pp. 1–14. Available at: <https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-019-2449-6>.
- Mohammed, H.H. *et al.* (2025) 'The effectiveness of nurse-led antenatal education on maternal self-efficacy: an evidence-based approach', *BMC Nursing*, 24(1), pp. 1–13. Available at: <https://doi.org/10.1186/s12912-025-03471-5>.
- Muzigaba, M. *et al.* (2022) 'Global core indicators for measuring WHO's paediatric quality-of-care standards in health facilities: development and expert consensus', *BMC Health Services Research*, 22(1), pp. 1–19. Available at: <https://doi.org/10.1186/s12913-022-08234-5>.
- Neef, V. *et al.* (2024) 'Current concepts in postpartum anemia management', *Current Opinion in Anaesthesiology*, 37(3), pp. 234–238. Available at: <https://doi.org/10.1097/ACO.0000000000001338>.
- Paliulyte, V. *et al.* (2017) 'Physiological Uterine Involution in Primiparous and Multiparous Women: Ultrasound Study', *Obstetrics and Gynecology International*, 2017, pp. 1–10. Available at:

<https://doi.org/10.1155/2017/6739345>.

- Raihana, S. *et al.* (2019) 'Early initiation of breastfeeding and severe illness in the early newborn period: An observational study in rural Bangladesh', *PLoS Medicine*, 16(8), pp. 1–17. Available at: <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002904>.
- Rodríguez-Gallego, I. *et al.* (2024) 'Effectiveness of a Postpartum Breastfeeding Support Group Intervention in Promoting Exclusive Breastfeeding and Perceived Self-Efficacy: A Multicentre Randomized Clinical Trial', *Nutrients*, 16(7), pp. 1–18. Available at: <https://doi.org/10.3390/nu16070988>.
- Sampurna, M.T.A. *et al.* (2023) 'Determinants of neonatal deaths in Indonesia: A national survey data analysis of 10,838 newborns', *Heliyon*, 9(1), p. e12980. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e12980>.
- Syairaji, M. *et al.* (2024) 'Trends and causes of maternal mortality in Indonesia: a systematic review', *BMC Pregnancy and Childbirth*, 24(1), pp. 1–14. Available at: <https://doi.org/10.1186/s12884-024-06687-6>.
- Walsh, A. *et al.* (2023) 'Improving breastfeeding support through the implementation of the Baby-Friendly Hospital and Community Initiatives: a scoping review', *International Breastfeeding Journal*, 18(1), pp. 1–18. Available at: <https://doi.org/10.1186/s13006-023-00556-2>.
- WHO (2023) *Trends in Maternal Mortality: 2000 to 2023*. Geneva: WHO.
- Zhao, Y. *et al.* (2024) 'A postpartum functional assessment tool for women based on the international classification of functioning, disability and health', *BMC Women's Health*, 24(1), pp. 1–13. Available at: <https://doi.org/10.1186/s12905-024-02880-z>.

I. Glosarium

A

Angka Kematian Bayi (AKB): Jumlah kematian bayi sebelum mencapai usia 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI): Jumlah kematian ibu selama kehamilan, persalinan, atau dalam masa nifas per 100.000 kelahiran hidup.

Audit Mutu: Proses sistematis untuk menilai dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui pengukuran kinerja terhadap standar yang telah ditetapkan.

C

Continuous Quality Improvement (CQI)

Pendekatan perbaikan mutu yang berkelanjutan dalam pelayanan kesehatan.

E

Early Initiation of Breastfeeding (EIBF): Inisiasi menyusui dini dalam satu jam pertama setelah lahir, penting untuk meningkatkan keberhasilan menyusui eksklusif.

I

Indikator Luaran: Ukuran kinerja yang menggambarkan hasil pelayanan kesehatan terhadap ibu dan bayi, seperti angka kematian ibu dan bayi, komplikasi persalinan, dan keberhasilan menyusui.

Indikator Proses: Ukuran yang menilai bagaimana pelayanan diberikan, misalnya keterlambatan rujukan atau kepatuhan terhadap standar prosedur.

Indikator Struktur: Ukuran yang menilai kesiapan sumber daya (tenaga, sarana, sistem) dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

K

Kepatuhan Protokol Klinis: Tingkat kesesuaian tindakan tenaga kesehatan terhadap standar operasional prosedur yang berlaku.

M

Mutu Pelayanan Kesehatan: Derajat pelayanan kesehatan yang meningkatkan kemungkinan tercapainya luaran kesehatan sesuai standar dan kebutuhan pengguna layanan.

O

Outcome (Luaran): Hasil akhir dari intervensi atau pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien.

P

Pelaporan Sentinel: Sistem pelaporan insiden kritis atau kejadian tak diinginkan dalam pelayanan kesehatan.

R

Root Cause Analysis (RCA): Metode audit untuk menemukan penyebab mendasar dari suatu masalah atau kejadian sentinel.

S

Standar Pelayanan: Batasan minimal pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh tenaga dan fasilitas kesehatan untuk menjamin mutu layanan.

PROFIL PENULIS



Etik Khusniyati, SST., M.Keb., Lahir di Kediri, 05 Oktober 1982. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi DIV Kebidanan Universitas Kediri lulus tahun 2006. Setelah itu lulus Sarjana Psikologi di Universitas Darul 'Ulum Jombang tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan pada Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2005 hingga saat ini sebagai dosen kebidanan di Universitas Bina Sehat PPNI Kabupaten Mojokerto. Penulis aktif mengajar dalam Mata Kuliah Asuhan Kebidanan Nifas, Asuhan Kebidanan pada Remaja dan Komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan BBL. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan seminar-seminar kebidanan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: etik.khusniyati@gmail.com

Dina Zakiyyatul Fuadah, S.Kep.Ns., M.Kep., Pendidikan terakhir yang ditempuh penulis adalah Program Magister Keperawatan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2014). Saat ini aktif menjadi dosen di Stikes Karya Husada Kediri sejak tahun 2009. Penulis aktif di beberapa organisasi antara lain Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Perawat Maternitas Indonesia (IPEMI), International Academy of Science and Higher Education (IASHE). Saat ini penulis aktif menjadi reviewer jurnal nasional dan menulis artikel ilmiah di beberapa jurnal nasional maupun internasional.

Alamat surel penulis: dzakiyyaf09@gmail.com

PROFIL PENULIS



Alyxia Gita Stellata, S.Tr.Keb., M.Keb., Penulis yang akrab disapa “Aly” merupakan wanita kelahiran Bengkulu, 15 September 1997. Penulis adalah dosen muda di prodi D3 Kebidanan Bukittinggi, Kemenkes Poltekkes Padang. Penulis sudah pernah menerbitkan beberapa buku fiksi secara solo dan antologi. Buku pertamanya adalah buku antologi cerpen tunggal (Ada Salam dari Telur Penyu – 2016) dan novel (Kids Zaman Old – 2019). Penulis juga aktif dalam organisasi dan perlombaan debat baik Inggris maupun bahasa Indonesia, perlombaan KTI, Duta Bahasa 2015, Duta Mahasiswa GenRe 2016, dan Duta Zetizen 2017 serta penulis juga pernah didapuk menjadi salah satu jurnalis dalam Warta BKKBN Provinsi Bengkulu. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan penelitian di kampusnya melalui ajang Penelitian Kreatifitas Mahasiswa (PKM) dengan concern menerbitkan artikel hasil penelitian di jurnal bereputasi dan dijenjang S2 ini tergabung dalam payung penelitian dosen di bidang digital health. Penulis saat ini sangat fokus untuk mempublikasikan jurnal ilmiah hasil penelitian yang telah dilakukan. “Tiada kata lelah untuk berkarya”, itu adalah salah satu motto hidupnya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: alyxiastell@gmail.com.

Zulfa Nur Azizah, M.Tr.Keb., lahir di Wonosobo pada 12 Juni 1997. Penulis menempuh pendidikan Diploma IV Kebidanan dan Magister Terapan Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Semarang. Setelah lulus pada tahun 2021, penulis memulai karier sebagai dosen di Akademi Kebidanan Bandung sebelum kemudian bergabung dengan Universitas UMMI Bogor dan dipercaya sebagai Kepala Program Studi DIII Kebidanan.

Penulis mengampu beberapa mata kuliah, seperti Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui, Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, serta Dokumentasi Kebidanan, dll. Bagi penulis, mengajar adalah sarana untuk membentuk bidan yang kompeten, berempati, dan berintegritas.

Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan sumber belajar yang aplikatif dan bermanfaat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan kebidanan di Indonesia.

PROFIL PENULIS



Shinta Ayu Nani, S.S.T., M.Kes Lahir di Kendal, 19 September 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV Bidan Pendidik Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Diponegoro Semarang dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 sebagai Dosen di Akademi Kebidanan Uniska Kendal yang saat ini menjadi Universitas Bhakti Kencana. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bhakti Kencana mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui, Asuhan Kebidanan Komunitas dan Ketrampilan Klinik Praktik Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: shinta.ayu@bku.ac.id. Motto: "There is Allah with us"



Nurmah, SST., M.Kes., seorang dosen dalam bidang kebidanan, lulus D3 Kebidanan Tahun 2005 di STIKes Medistra Indonesia. Pernah bekerja di RSIA Permata Cibubur, melanjutkan Pendidikan D4 Kebidanan di Universitas Padjadjaran Bandung dan lulus pada tahun 2007. Menyelesaikan Pendidikan Pasca Sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju peminatan kesehatan reproduksi tahun 2017. Penulis aktif di organisasi Ikatan Bidan Indonesia sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini, ia menjadi pengurus dibidang Pendidikan dan Pelatihan serta menjadi pembicara pelatihan di organisasi Ikatan Bidan Indonesia.



Dr. Ns. Nopi Nur Khasanah, M.Kep., Sp.Kep.An., Penulis lahir di Purbalingga, 30 November 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 lulus pada tahun 2009 dan Ners tahun 2011 di Universitas Diponegoro Semarang. Penulis melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2015 yang dilanjutkan dengan Sp 1 dengan Spesialisasi dalam Keperawatan Anak pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan studi S3 di Universitas Indonesia kembali dan lulus tahun 2024. Riwayat pekerjaan sejak tahun 2013 sampai sekarang sebagai Dosen Program Studi Fakultas Ilmu Keperawatan Departemen Keperawatan Anak, Universitas Islam Sultan Agung. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Penulis juga aktif dalam organisasi profesi sebagai pengurus IPANI Jawa Tengah Divisi Sistem Informasi dan Komunikasi yang dapat dihubungi melalui e-mail: nopi.khasanah@unissula.ac.id. Motto: "Semua belum berakhir, hingga benar-benar berakhir"

Sinopsis

Buku referensi “Asuhan Pascapersalinan dan Dukungan Menyusui Berbasis Bukti” disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai asuhan ibu dan bayi pada masa pascapersalinan, dengan penekanan khusus pada dukungan menyusui yang aman, efektif, dan sesuai standar ilmiah terkini. Berlandaskan konsep *evidence-based practice*, buku ini menguraikan aspek fisiologis, klinis, hingga manajerial yang dibutuhkan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan paripurna pada ibu dan bayi setelah persalinan.

Dimulai dari kajian Fisiologi Pemulihan Ibu dan Laktasi, buku ini menjelaskan proses adaptasi tubuh ibu pascapersalinan serta mekanisme produksi dan pengeluaran ASI, sehingga pembaca mampu membedakan antara perubahan normal dan tanda bahaya yang memerlukan intervensi. Bagian Konsep Perdarahan Pasca Persalinan: Pencegahan dan Tata Laksana kemudian mengulas secara sistematis faktor risiko, upaya pencegahan, deteksi dini, dan penatalaksanaan perdarahan pascapersalinan, yang masih menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu.

Topik Infeksi, Anemia, dan Nyeri Pascapersalinan disajikan untuk memperkuat kemampuan klinis tenaga kesehatan dalam mengenali, mencegah, dan menangani komplikasi yang sering muncul pada masa nifas. Selanjutnya, melalui pembahasan Inisiasi Menyusu Dini dan Menyusui Eksklusif, buku ini menegaskan kembali pentingnya praktik menyusui yang tepat sejak awal kehidupan bayi, beserta strategi implementasi di berbagai tatanan pelayanan.

Bab Masalah Laktasi dan Solusi Berbasis Bukti menyajikan berbagai masalah yang umum dihadapi ibu menyusui—seperti pelekatan yang kurang optimal, bendungan ASI, puting lecet, hingga kekhawatiran terkait produksi ASI—beserta pendekatan penanganannya yang praktis dan berbasis bukti. Di sisi lain, pembahasan Kontrasepsi Pasca Persalinan mengarahkan pembaca pada pemilihan metode yang aman, rasional, dan sesuai kondisi ibu, sekaligus menekankan pentingnya konseling yang menghargai hak dan pilihan perempuan.

Sebagai upaya menjamin mutu pelayanan, buku ini ditutup dengan bab Indikator Luaran Ibu Bayi dan Audit Mutu, yang menguraikan cara mengukur keberhasilan asuhan pascapersalinan dan dukungan menyusui, serta sistem audit mutu yang aplikatif di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan bahasa yang sistematis dan dilengkapi acuan ilmiah, buku ini diharapkan menjadi rujukan penting bagi mahasiswa kebidanan, keperawatan, dan kedokteran, bidan, perawat, dokter, serta pengelola program kesehatan ibu dan anak dalam meningkatkan kualitas pelayanan pascapersalinan dan keberhasilan menyusui.

Buku referensi “Asuhan Pascapersalinan dan Dukungan Menyusui Berbasis Bukti” disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai asuhan ibu dan bayi pada masa pascapersalinan, dengan penekanan khusus pada dukungan menyusui yang aman, efektif, dan sesuai standar ilmiah terkini. Berlandaskan konsep evidence-based practice, buku ini menguraikan aspek fisiologis, klinis, hingga manajerial yang dibutuhkan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan paripurna pada ibu dan bayi setelah persalinan.

Dimulai dari kajian Fisiologi Pemulihan Ibu dan Laktasi, buku ini menjelaskan proses adaptasi tubuh ibu pascapersalinan serta mekanisme produksi dan pengeluaran ASI, sehingga pembaca mampu membedakan antara perubahan normal dan tanda bahaya yang memerlukan intervensi. Bagian Konsep Perdarahan Pasca Persalinan: Pencegahan dan Tata Laksana kemudian mengulas secara sistematis faktor risiko, upaya pencegahan, deteksi dini, dan penatalaksanaan perdarahan pascapersalinan, yang masih menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu.

Topik Infeksi, Anemia, dan Nyeri Pascapersalinan disajikan untuk memperkuat kemampuan klinis tenaga kesehatan dalam mengenali, mencegah, dan menangani komplikasi yang sering muncul pada masa nifas. Selanjutnya, melalui pembahasan Inisiasi Menyusu Dini dan Menyusui Eksklusif, buku ini menegaskan kembali pentingnya praktik menyusui yang tepat sejak awal kehidupan bayi, beserta strategi implementasi di berbagai tatanan pelayanan.

Bab Masalah Laktasi dan Solusi Berbasis Bukti menyajikan berbagai masalah yang umum dihadapi ibu menyusui—seperti pelekatan yang kurang optimal, bendungan ASI, puting lecet, hingga kekhawatiran terkait produksi ASI—beserta pendekatan penanganannya yang praktis dan berbasis bukti. Di sisi lain, pembahasan Kontrasepsi Pasca Persalinan mengarahkan pembaca pada pemilihan metode yang aman, rasional, dan sesuai kondisi ibu, sekaligus menekankan pentingnya konseling yang menghargai hak dan pilihan perempuan.

Sebagai upaya menjamin mutu pelayanan, buku ini ditutup dengan bab Indikator Luaran Ibu Bayi dan Audit Mutu, yang menguraikan cara mengukur keberhasilan asuhan pascapersalinan dan dukungan menyusui, serta sistem audit mutu yang aplikatif di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan bahasa yang sistematis dan dilengkapi acuan ilmiah, buku ini diharapkan menjadi rujukan penting bagi mahasiswa kebidanan, keperawatan, dan kedokteran, bidan, perawat, dokter, serta pengelola program kesehatan ibu dan anak dalam meningkatkan kualitas pelayanan pascapersalinan dan keberhasilan menyusui.

ISBN 978-634-7426-74-1



9

786347

426741

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

